מדריך דיקור לחי למטפלים ברפואה סינית

Jiá Zhēn · 颊针 · שיטת פרופ' וואנג יונג-ג'ואו (王永洲)

עקרונות השיטה, אטלס אנטומי אינטראקטיבי של 16 הנקודות ו-7 שרירי הלחי, טבלת מיקומים והתוויות, פרוטוקולים קליניים וטכניקת דיקור

1. עקרונות השיטה 2. יסודות תאורטיים 3. אטלס אינטראקטיבי 4. טבלת 16 הנקודות 5. בחירת נקודות 6. אבחון 7. פרוטוקולים 8. מקרים מהספר 9. טכניקה ובטיחות 10. מילון מונחים 11. מקורות ופערים 12. סרטונים

גרסת PDF של האתר, עם כל התוכן במצב פתוח: כל הנקודות, השרירים, הפרוטוקולים והמקרים. נוצרה ב-2026-11-13 מתוך guyqi.github.io/ACUPANCURECHEEK. קישורי הסרטונים דורשים חיבור לאינטרנט.

תוכן העניינים

1. עקרונות דיקור הלחי (颊针疗法)
2. יסודות תאורטיים לפי ספר המקור
3. כרטיסי 16 הנקודות
4. כרטיסי 7 השרירים
5. טבלת 16 הנקודות: מיקום, התוויות ושימוש בדיווח
6. בחירת נקודות ועקרונות טיפול
7. אבחון: אבחון שרירים ואבחון בטן
8. פרוטוקולים קליניים
9. מאגר המקרים הקליניים מהספר
10. טכניקת דיקור ובטיחות
11. מילון מונחים
12. מקורות והערות לבדיקה
13. 12 ▶️ סרטוני הדרכה והדגמות קליניות בדיקור לחי (YouTube)

1 עקרונות דיקור הלחי (颊针疗法)

מיפוי הולוגרפי

השיטה פותחה בסין על ידי פרופ' וואנג יונג-ג'ואו (王永洲). הלחי נתפסת כ"מיקרו-מערכת" שעליה ממופה הגוף כולו: **הראש** ברקה, **שלושת המחממים (三焦)** לאורך הגבול הקדמי של שריר המלעס, **עמוד השדרה** לאורך השפה האחורית של ענף הלסת, **הגפה העליונה** על עצם הלחי וקפל החיוך, ו**הגפה התחתונה** לאורך גוף הלסת והסנטר.

16 נקודות ב-5 קבוצות

- **ראש** – CA-1 (头穴)
- **שלושת המחממים** – CA-2 עד CA-4 (上焦·中焦·下焦)
- **עמוד השדרה** – CA-5 עד CA-8 (颈·背·腰·骶)
- **גפה עליונה** – CA-9 עד CA-12 (肩·肘·腕·手)
- **גפה תחתונה** – CA-13 עד CA-16 (髋·膝·踝·足)

איך לעבוד עם המדריך

באטלס (חלק 3) לוחצים על נקודה או על שריר כדי לראות מיקום, מישוש, מחט והתוויות. בטבלה (חלק 4) מופיעים כל 16 הנקודות עם תיאור המיקום וההתוויות לפי טבלה 1 בדיווח המקרה, וסימון הנקודות שבהן השתמשו לשיכוך כאב אצל מטופל 1 (P1) ומטופל 2 (P2). לחיצה על שורה בטבלה מציגה את הנקודה באטלס. בכרטיס כל נקודה ושריר נוסף פאנל 📖 **לפי ספר המקור** עם מיקום סטנדרטי, מבנה אנטומי בשכבות, התוויות, שרירים קשורים ומקרים קליניים. חלקים 2, 5, 6, 8, 10 ו-11 מבוססים על הספר; כל קוד נקודה (כמו **CA-4**) בהם פותח את הנקודה באטלס.

יחידות מידה: כל המרחקים נמדדים ב**צון (寸)** פרופורציונלי של המטופל. בתרגום של טבלה 1 הופיע "אינץ'" – הכוונה לצון.

2 יסודות תאורטיים לפי ספר המקור

הגדרת השיטה, ששת היסודות התאורטיים שעליהם המחבר מבסס אותה, ושלושת רובדי ההתוויות. כל טענה מסומנת בעמוד המקור, ומבחינה בין רפואה סינית קלאסית, אנטומיה ביו-רפואית ותאוריית המחבר.

מהו דיקור הלחי

דיקור הלחי הוא שיטה לטיפול במחלות ולשמירה על הבריאות באמצעות דיקור, או עיסוי, טיפול מגנטי, לייזר וכדומה, בנקודות ספציפיות באזור הפנים והלחיים. לדברי המחבר, לאחר 25 שנות אימות קליני נמצא כי באזור הלחי קיימת יחידה הולוגרפית (全息元) הכוללת את כל גוף האדם, וההשלכה שלו על הלחי רציפה. הנקודות הורחבו לכן ל"אזורי נקודות" (区穴), ולכל אחת נקבע מיקום סטנדרטי המבוסס על סימנים גרמיים – יסוד לשחזוריות הטיפול. קוד הנקודה: A (acupuncture) + C (cheek) + מספר סידורי. 📖 עמ' 39

סיפור הגילוי (1991)

גילוי השיטה היה מקרי: ביולי 1991 טיפל המחבר בגבר שסבל מסיאטיקה והגיע עם כאב שיניים עז. לאחר דיקור ג'יאצ'ה (颊车, ST-6) בצד החולה וחה-גו (合谷, LI-4) בצד הנגדי, דיווח המטופל שגם כאב הגב והרגל השתפר. בהמשך הרחיב המחבר את טווח הדיקור בלחי, ובשנת 1992, במשלחת רפואית במדגסקר, המשיך לחקור את האזור. השיטה פורסמה רשמית בשנת 2000 בגיליון המשלים של "דיקור ומוקסה של סין" (《中国针灸》). 📖 עמ' 2–3

מקרא: סוגי הידע בפרק זה

רפואה סינית קלאסית מושגים ומקורות מהקלאסיקות (נֵי-ג'ינג וכו').

אנטומיה ביו-רפואית ידע אנטומי מקובל.

תאוריית המחבר הסברים והשערות של מפתח השיטה – אינם עובדה מדעית מבוססת.

שישה יסודות תאורטיים 📖 עמ' 10–13

דרכי הצ'י (气街)

רפואה סינית קלאסית

ב"לינג-שו, וויי צ'י": "לצ'י של החזה יש דרך, לצ'י של הבטן יש דרך, לצ'י של הראש יש דרך, ולצ'י של השוק יש דרך". דרכי הצ'י הן נתיב משותף שבו מתכנס צ'י המרידיאנים; "הצ'י שבראש נעצר במוח". לפי המחבר, תיאוריה זו מסבירה מדוע אזור בראש יכול לשמש בסיס לטיפול לפי אזורים בכל הגוף.

📖 עמ' 10–11

תורת המרידיאנים (经络理论)

רפואה סינית קלאסית

אזור הלחי מכוסה בעיקר על ידי מרידיאני היד והרגל יאנג-מינג (阳明) ושאו-יאנג (少阳). ביאנג-מינג "צ'י ודם רבים", ושאו-יאנג משמש "ציר" המווסת עלייה וירידה, יציאה וכניסה של הצ'י. בפרק 2 מתוארים גם מרידיאני-הגידים (经筋) העוברים בלחי, נקודות המרידיאנים באזור ונקודות ייחודיות (奇穴).

📖 עמ' 12

תורת העצבים (神经理论)

אנטומיה ביו-רפואית

באזור מתפרשים שני עצבי גולגולת – הטריגמינלי (תחושה) והפציאלי (תנועה). המחבר מציין שעצבוב חופף של שני עצבי גולגולת שלמים נדיר במערכות המיקרו-דיקור, ורואה בהם את הבסיס האנטומי-פיזיולוגי של השיטה.

📖 עמ' 12, 20–23

תורת ההולוגרמה (全息理论)

תאוריית המחבר

השיטה מפיקה לפי המחבר אפקט מקומי וכלל-גופני, וחוקיותה סוכמה על בסיס חשיבה הולוגרפית ומחקר קליני. לעובר ההולוגרפי של הלחי אין גבול אנטומי בולט, ויחסי הגודל בו אינם בהכרח פרופורציונליים לאנטומיה. ימין ושמאל מכילים כל אחד את ההולוגרמה, אך תפקודיהם אינם סימטריים לחלוטין. המחבר מציין במפורש שאישוש התאוריה על ידי המדע המודרני "ידרוש זמן רב מאוד".

📖 עמ' 12–13, 71–74

תורת המחמם המשולש הגדול (大三焦理论)

תאוריית המחבר

"המחמם המשולש הגדול" הוא המחמם המשולש במובנו הכולל – שליח הצ'י המקורי העובר דרך חמשת האיברים ושישת האיברים החלולים – להבדיל מ"פקיד התעלות". לדברי המחבר, השלב הקשה ביותר במחקר היה קביעת הנקודות לאיברים הפנימיים; ניסיונות להתאים איברים אנטומיים לנקודות (כמו בדיקור האוזן) לא נתנו תוצאות ניתנות לשחזור, והפתרון נמצא בתורת המחמם המשולש: "כמו אחיזה בחוט הראשי של הרשת".

📖 עמ' 13, 86

תורת גוף-נפש (心身理论)

תאוריית המחבר + רפואה פסיכוסומטית

השיטה מבוססת על "אחדות גוף ונפש"; חמשת האיברים הם "מאגרי חמש הרוחות" (五神藏) והצ'י מחבר בין הגוף לרוח. לפי המחבר: בלחי השמאלית – הלב, הטחול והכבד; בלחי הימנית – הריאה, הקיבה והכליה; ובמחמם המשולש – העליון: לב וריאה, האמצעי: טחול וקיבה, התחתון: כבד וכליה. המחבר מצביע על הקשר בין כאב כרוני, לחץ נפשי וסומטיזציה.

📖 עמ' 13, 104–105

שלושת רובדי ההתוויות 📖 עמ' 155–156

רובד 1

הרובד ההולוגרפי

בעיקר כאב חריף וכרוני בגפיים ובעמוד השדרה – בראש ובראשונה כאבי צוואר, כתף, גב תחתון ורגליים הנגרמים מפגיעות ברקמות רכות; וכן חלק ממחלות מורכבות של חוליות הצוואר, בקע דיסק מותני, היצרות תעלת השדרה ועוד.

CA-5 CA-6 CA-7 CA-8 CA-9 CA-10 CA-11 CA-12 CA-13 CA-14 CA-15 CA-16

רובד 2

רובד המחמם המשולש

מנגנונים ותסמינים של האיברים הפנימיים בחזה ובבטן: לחץ בחזה, פלפיטציות, שיעול וקוצר נשימה, ליחה, כאב ומלאות בשדיים, כאבי קיבה, חומציות, צרבת, נפיחות, שלשול, עצירות, תכיפות ודחיפות במתן שתן, כאבי מחזור – וכן כאבי צוואר, גב, מותן ועצה הקשורים בחלקם לאיברים הפנימיים.

CA-2 CA-3 CA-4

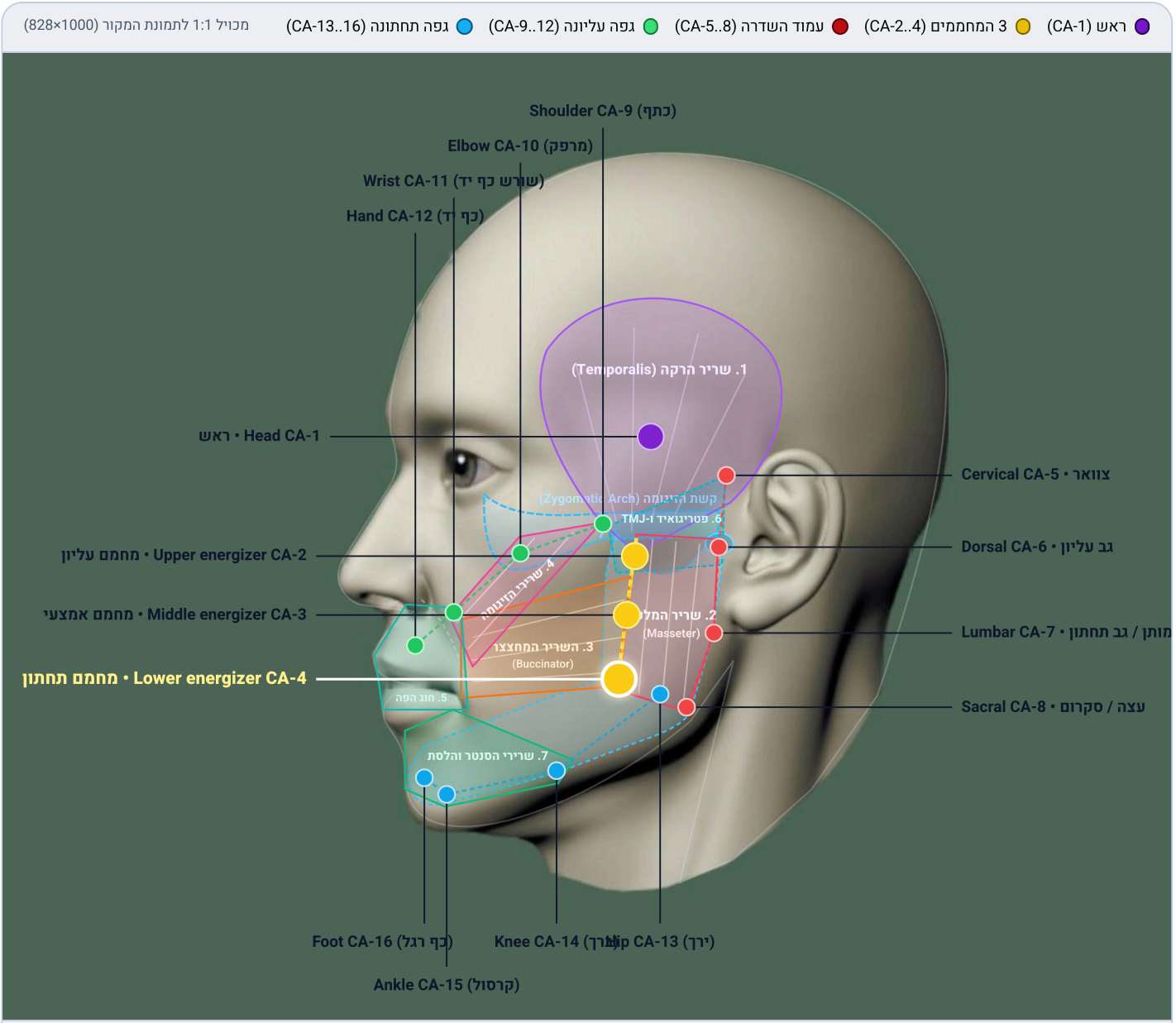
רובד 3

רובד הגוף והנפש

אי-שקט, מתח, חרדה, מחלות תגובתיות הקשורות להפרעות רגשיות, מחלות ראומטיות ודמויות ראומטיות, מחלות אנדוקריניות, מחלות עור עקשניות, אסתמה אלרגית כרונית, נדודי שינה עקשניים, ירידה בזיכרון, דמנציה, כאבי ראש ומיגרנה.

CA-1 CA-2 CA-3 CA-4

שלושת הרבדים מהווים בדרך כלל שלם אחד: המחלה עשויה להתמקד ברובד אחד, ובמחלות כרוניות מורכבות מופיעה השפעה הדדית בין שלושת הרבדים – ועל הקלינאי "להבחין, לבחור ולוותר, ולהתמקד בכוון מדויק".



דיוק אנטומי לפי תמונת המקור: הנקודות הצהובות הגדולות (**CA-2, CA-3, CA-4**) יושבות על הגבול הקדמי של שריר המלעס, הנקודה הכחולה **CA-13 (ירך)** יושבת בבטן המלעס בין **CA-4** ל-**CA-8 (סקרום)**, ונקודות הגפה העליונה הירוקות (**CA-9..12**) יורדות מקשת הזיגומה אל השפה העליונה.

כרטיסי 16 הנקודות א2

כל הפרטים של כל נקודה, כפי שהם מוצגים באטלס כשבוחרים בה: מיקום, מישוש, מחט, התוויות, טבלה 1 ונוסח ספר המקור.

CA-1 נקודת הראש (סגול)

ראש (Head)

头穴
Tóu Xué

📐 **מיקום אנטומי ושרירי מדויק (לפי התמונה):**
אזור הרקה (Temple): בקו אופקי עם העין (y=328), כ-1 צון מעל אמצע הגבול העליון של קשת הזיגומה, על בטן שריר הרקה (Temporalis).

👆 **איך מוצאים במישוש (PALPATION):**
מתח קו אופקי מגובה העין אחורה אל שקע הרקה, ובקש מהמטופל להדק שיניים כדי לחוש את התכווצות שריר הרקה מתחת לאצבע.

עובי, עומק ורקמת יעד
13×0.16 מ"מ | עומק 2–4 מ"מ לפאשיה של שריר הרקה

צד דיקור וזמן שהייה
דו-צדדי או בצד הכאב | 30 דקות

🩺 **התוויות קליניות:**
כאבי ראש, מיגרנות, סחרחורת צווארית, נדודי שינה, חרדה, הרגעת ה-Shen ואיזון ציר היפותלמוס-היפופיזה-שחלות (HPO) בטיפולי פריון.

📄 **לפי טבלה 1 בדיווח המקרה:**
מיקום: 1 צון מעל אמצע הגבול העליון של קשת הזיגומה.
התוויות: כאב ראש, סחרחורת, כאב שיניים, נדודי שינה, מתח, חרדה, דיכאון, שבץ וכו'.
שימוש לשיכוך כאב בדיווח: P1

📖 **לפי ספר המקור: נקודת הראש** 📖 איור 1-1-3 · עמ' 39–40

⚠️ קיימים 3 פערים בין תיאור האתר לספר בנקודה זו (שיוך שרירים לנקודות במפת השרירים · התוויות שאינן מופיעות בספר · פרוטוקולי כאבי מחזור ופריון) – לחצו לפירוט

📐 **מיקום סטנדרטי (לפי סימנים גרמיים)**

צון אחד מעל השוליים העליונים של נקודת האמצע של קשת הלחי (הקשת הזיגומטית).

נקודות הראש והמחמם המשולש · 📖 עמ' 39–40

🔬 **מבנה אנטומי בשכבות**

שכבה שטחית: עור, פאשיה שטחית, ענף רקתי של עצב הפנים, ענפי עורק ווריד רקתיים שטחיים.

שכבה עמוקה: פאשיה עמוקה, שריר הרקה, גומת הרקה.

טבלה 2-1-1 (מחקר אנטומי) · 📖 עמ' 24, 39–40

🩺 **התוויות עיקריות לפי הספר (11)**

כאב ראש | סחרחורת | כאב שיניים | נדודי שינה | מתח | חרדה | דיכאון | שבץ מוחי | תסמונת פרקינסון | דמנציה סנילית | טנטון

טבלה 3-5-1 · 📖 עמ' 39–40

💪 **שרירים ומבנים קשורים**

● שריר הרקה (Temporalis) שריר הרקה קשור לנקודות הראש והצוואר בדיקור הלחי. 📖 עמ' 16

🔗 **קשרים לנקודות אחרות והערות המחבר**

מלבד השימוש במחלות מקומיות של הראש והפנים, נקודת הראש היא נקודה חשובה במחלות נפשיות ופסיכוסומטיות; לדברי המחבר, תפקודה קשור להתפתחות הנוירופסיכולוגיה ומדעי המוח ו"עוד נשאר לגלות בעתיד דברים רבים". 📖 עמ' 51

בשיטת ההתאמה עליון-תחתון ניתן, לפי הספר, להשתמש בנקודת העצה (CA-8) בכאב ראש. 📖 עמ' 153

CA-8

📚 **מקרים קליניים בספר שבהם נבחרה הנקודה (13)**

- כאב ראש מתחי (הרובד ההולוגרפי, עמ' 204)

- סינוסיטיס כרונית (הרובד ההולוגרפי, עמ' 205)
- הפרעה תפקודית עצבית של מערכת העיכול (מחלות המחמם המשולש, עמ' 249)
- תסמונת המעי הרגיז (מחלות המחמם המשולש, עמ' 252)
- הפרעת חרדה (3) (מחלות גוף-נפש, עמ' 259)
- הפרעת חרדה (4) (מחלות גוף-נפש, עמ' 260)

← הצג את כל 13 המקרים במאגר

CA-2 שלושת המחממים (צהוב)

מחמם עליון (Upper Energizer)

上焦穴
Shàng Jiāo Xué

📐 **מיקום אנטומי ושרירי מדויק (לפי התמונה):**
הנקודה הצהובה העליונה: בשקע שמתחת לקשת הזיגומה, במפגש השפה האחורית של הזיז הוויי (Coronoid Process) עם הגבול הקדמי-עליון של שריר המלעס (Masseter), בקו אופקי אחד עם נקודת המרפק (CA-10) ונקודת הגב העליון (CA-6).

👆 **איך מוצאים במישוש (PALPATION):**
בקש מהמטופל לפתוח ולסגור את הפה: תרגיש את הזיז הוויי נע קדימה ואחורה מתחת לעצם הלחי. הנקודה יושבת בשקע שבין הזיז הוויי לגבול הקדמי של המלעס.

עובי, עומק ורקמת יעד
0.16–0.18 מ"מ | עומק 3–5 מ"מ אנכית לעור

צד דיקור וזמן שהייה
דו-צדדי (בוויסות מערכתי) | 30–45 דקות

🩺 **התוויות קליניות:**
מועקה בחזה, פלפיטציות, חרדה, קוצר נשימה, כאבים בבית החזה, וויסות ציר הלב-רחם (Bao Mai) להורדת סטרס בטיפולי פריון.

📄 **לפי טבלה 1 בדיווח המקרה:**
מיקום: נקודת המפגש בין השפה האחורית של הזיז הקורונואידי של הלסת התחתונה לבין הגבול התחתון של קשת הזיגומה.
התוויות: כאב ראש, כאב צוואר, כאב בחזה, מועקה בחזה, נפיחות וכאב בשדיים, טכיקרדיה, הפרעות קצב, אסטמה וכו'.
שימוש לשיכוך כאב בדיווח: P1

📖 **לפי ספר המקור: נקודת המחמם העליון 上焦** 📖 איור 2-1-3 · עמ' 41

⚠️ קיימים 3 פערים בין תיאור האתר לספר בנקודה זו (שיוך שרירים לנקודות במפת השרירים · התוויות שאינן מופיעות בספר · פרוטוקולי כאבי מחזור ופריון) – לחצו לפירוט

📐 מיקום סטנדרטי (לפי סימנים גרמיים)

מאחורי תהליך הקורונואיד של הלסת התחתונה, במפגש עם השוליים התחתונים של קשת הלחי.

נקודות הראש והמחמם המשולש · 📖 עמ' 41

🔬 מבנה אנטומי בשכבות

שכבה שטחית: עור, פאשיה שטחית, ענף רקתי של עצב הפנים, השוליים הקדמיים של בלוטת הפרוטיד.

שכבה עמוקה: השוליים התחתונים של קשת הלחי והשוליים העליונים של החריץ הסיגמואידי של הלסת התחתונה, השוליים האחוריים של עורק הלסת העליונה, תהליך הקורונואיד של הלסת התחתונה.

טבלה 1-1-2 (מחקר אנטומי) · 📖 עמ' 24, 41

🩺 התוויות עיקריות לפי הספר (20)

כאב ראש · כאב צוואר · כאב חזה · לחץ בחזה · כאב ונפיחות בשדיים · דפיקות לב · הפרעות קצב · אסתמה · שיעול · ברונכיטיס · מתח
חרדה · עצבנות · עצב · סחרחורת · מחלות חמשת האיברים (五官) · נפיחות וכאב בבטן · עווית סרעפת · כאב גרון · נדודי שינה

טבלה 1-5-3 · 📖 עמ' 41

💪 שרירים ומבנים קשורים

● שריר המלעס (Masseter) שריר הלעיסה קשור לשכבה השטחית של נקודות המחמם המשולש, ולנקודות הגב, המותן, העצה והירך. 📖 עמ' 16–17

● השריר הפטריגואידי הצידי וזיז הלסת הפטריגואידי הפנימי קשור לשכבה העמוקה של נקודות המחמם העליון, האמצעי והתחתון; הפטריגואיד החיצוני קשור לשכבה העמוקה של נקודות המחמם העליון והאמצעי ולנקודות הגב. 📖 עמ' 17

🔗 קשרים לנקודות אחרות והערות המחבר

המחמם העליון מתואם עם חוליות הצוואר; ויסות המחמם המשולש מתואר כ"טיפול בשורש" בבעיות כרוניות של עמוד השדרה. 📖 עמ' 51

CA-5

בחלוקת גוף-נפש: המחמם העליון – הלב והריאה. 📖 עמ' 104

📚 מקרים קליניים בספר שבהם נבחרה הנקודה (32)

- כאב ראש מתחי (הרובד ההולוגרפי, עמ' 204)
- סינוסיטיס כרונית (הרובד ההולוגרפי, עמ' 205)
- מיגרנה (הרובד ההולוגרפי, עמ' 206)
- פיברומיאלגיה כרונית (הרובד ההולוגרפי, עמ' 212)
- דלקת סביב מפרק הכתף (הרובד ההולוגרפי, עמ' 216)
- דלקת במפרק הברך (הרובד ההולוגרפי, עמ' 240)

← הצג את כל 32 המקרים במאגר

מחמם אמצעי (Middle Energizer)

CA-3 · שלושת המחממים (צהוב)

中焦穴
Zhōng Jiāo Xué

📐 **מיקום אנטומי ושרירי מדויק (לפי התמונה):**
הנקודה הצהובה האמצעית: באמצע הקו המחבר בין CA-2 ל-CA-4 לאורך הגבול הקדמי של שריר המלעס (Masseter), בקו אופקי אחד עם בסיס הנחיר ונקודת שורש כף היד (CA-11).

👆 **איך מוצאים במישוש (PALPATION):**
בקש מהמטופל להדק שיניים, אתר את 'המדרגה' הקדמית של שריר המלעס באמצע הלחי (בגובה בסיס הנחיר), ודקור בחריץ שבינו לבין השריר המחצצר הרך.

עובי, עומק ורקמת יעד
0.18–0.16 מ"מ | עומק 3–5 מ"מ אנכית

צד דיקור וזמן שהייה
דו-צדדי או לפי אבחנת בטן | 30–45 דקות

🩺 **התוויות קליניות:**
הפרעות עיכול, כאבי קיבה, נפיחות בטנית, רפלוקס, בחילות, תקיעות צ'י הכבד ותסמונת קדם-וסתית (PMS) המלווה כאבי מחזור.

📄 **לפי טבלה 1 בדיווח המקרה:**
מיקום: אמצע הקו המחבר בין נקודות המחמם העליון והמחמם התחתון.
התוויות: התכווציות בקיבה, דלקת קיבה חריפה/כרונית, צרבת וחומציות.
שימוש לשיכוך כאב בדיווח: P1

📖 **לפי ספר המקור: נקודת המחמם האמצעי 中焦** · 📖 איור 3-1-3 · עמ' 41

⚠️ קיים פער בין תיאור האתר לספר בנקודה זו (פרוטוקולי כאבי מחזור ופריון) – לחצו לפירוט

📐 מיקום סטנדרטי (לפי סימנים גרמיים)

בנקודת האמצע של הקו המחבר בין נקודות המחמם העליון (CA-2) והמחמם התחתון (CA-4).

נקודות הראש והמחמם המשולש · 📖 עמ' 41

🔬 מבנה אנטומי בשכבות

שכבה שטחית: עור, פאשיה שטחית, ענף רקתי וענף הלחי של עצב הפנים, בלוטת הפרוטיד.

שכבה עמוקה: כרית השומן של הלחי, פאשיה עמוקה, שריר הלעיסה, השוליים העליונים של החריץ הסיגמואידי של הלסת התחתונה.

טבלה 1-1-2 (מחקר אנטומי) · 📖 עמ' 24, 41

🩺 התוויות עיקריות לפי הספר (20)

עווית קיבה · דלקת קיבה חריפה וכרונית · צרבת וחומציות · שיהוקים · הקאות · נפיחות וכאב בבטן · דלקת כיס המרה · כיב קיבה
כיב בפקעת התריסריון · כאב גב · חרדה · עקשנות · דאגה · סוכרת · יתר לחץ דם · מחלות כבד · נדודי שינה · עייפות כרונית · השמנה
כבד שומני

טבלה 1-5-3 · 📖 עמ' 41

💪 שרירים ומבנים קשורים

- **שריר המלעס (Masseter)** שריר הלעיסה קשור לשכבה השטחית של נקודות המחמם המשולש, ולנקודות הגב, המותן, העצה והירך. 📖 עמ' 16–17
- **השריר הפטריגואידי הצידי וזיז הלסת** הפטריגואיד הפנימי קשור לשכבה העמוקה של נקודות המחמם העליון, האמצעי והתחתון; הפטריגואיד החיצוני קשור לשכבה העמוקה של נקודות המחמם העליון והאמצעי ולנקודות הגב. 📖 עמ' 17
- **השריר המחצצר (Buccinator)** שריר הלחי (בוקינטור) קשור לנקודות המחמם האמצעי והתחתון. 📖 עמ' 17–18

🔗 קשרים לנקודות אחרות והערות המחבר

המחמם האמצעי מתואם עם חוליות החזה. 📖 עמ' 51

CA-6

בחלוקת גוף-נפש: המחמם האמצעי – הטחול והקיבה. 📖 עמ' 104

📚 מקרים קליניים בספר שבהם נבחרה הנקודה (38)

- כאב ראש מתחי (הרובד ההולוגרפי, עמ' 204)
- סינוסיטיס כרונית (הרובד ההולוגרפי, עמ' 205)
- מיגרנה (הרובד ההולוגרפי, עמ' 206)
- פיברומיאלגיה כרונית (הרובד ההולוגרפי, עמ' 212)
- גדילה עצמית של חוליות החזה (הרובד ההולוגרפי, עמ' 212)
- דלקת סביב מפרק הכתף (הרובד ההולוגרפי, עמ' 216)

← הצג את כל 38 המקרים במאגר

下焦穴
Xià Jiāo Xué

מחמם תחתון (Lower Energizer)

CA-4 · שלושת המחממים (צהוב)

📐 מיקום אנטומי ושרירי מדויק (לפי התמונה):
הנקודה הצהובה התחתונה: בחלק התחתון של הגבול הקדמי של שריר המלעס (Masseter), בקו אופקי עם קו השפתיים/זווית הפה, וקדמית-עליונה מעט לנקודת הירך הכחולה (CA-13).

👆 איך מוצאים במישוש (PALPATION):
בקש מהמטופל להדק שיניים, עקוב אחרי הגבול הקדמי של שריר המלעס למטה עד לגובה זווית הפה (מעל גבול הלסת התחתונה).

עובי, עומק ורקמת יעד
0.16–0.18 מ"מ | עומק 3–5 מ"מ (זהירות מעורק הפנים הצמוד)

צד דיקור וזמן שהייה
בצד הרגיש בבטן התחתונה או דו-צדדי | 30–45 דקות

🩺 התוויות קליניות:
נקודת המאסטר לגינקולוגיה ופריון: כאבי מחזור (דיסמנוריאה), כאב שחלתי, ויסות רחם ושחלות, אנדומטריוזיס, שיפור זרימת דם לאגן וחיזוק הכליות.

📄 לפי טבלה 1 בדיווח המקרה:
מיקום: על הקו האלכסוני הקדמי של הלסת התחתונה.
התוויות: נפיחות וכאב בבטן, קוליטיס, כאבי מחזור, מחלה דלקתית של האגן (PID), אי-סדירות בווסת, הפרשות נרתיקיות, מחלות גינקולוגיות.
שימוש לשיכוך כאב בדיווח: P1

📖 לפי ספר המקור: נקודת המחמם התחתון 下焦 · 📖 איור 3-1-4 · עמ' 41

⚠️ קיימים 3 פערים בין תיאור האתר לספר בנקודה זו (מיקום CA-4 · התוויות שאינן מופיעות בספר · פרוטוקולי כאבי מחזור ופריון) – לחצו לפירוט

📐 מיקום סטנדרטי (לפי סימנים גרמיים)
בשוליים הקדמיים של הזווית הפנימית של הלסת התחתונה.
נקודות הראש והמחמם המשולש · 📖 עמ' 41

🔬 מבנה אנטומי בשכבות
שכבה שטחית: עור, פאשיה שטחית, ענף הלחי של עצב הפנים.
שכבה עמוקה: כרית השומן של הלחי, פאשיה עמוקה, שריר הלעיסה, החלק האמצעי של ענף הלסת התחתונה, הזווית הפנימית של הלסת התחתונה.
טבלה 2-1-1 (מחקר אנטומי) · 📖 עמ' 24, 41

🩺 התוויות עיקריות לפי הספר (25)
נפיחות וכאב בבטן · דלקת המעי הגס · כאבי מחזור · הפרשות נרתיקיות · דלקת באגן · מחזור לא סדיר · שרירנים ברחם · דלקת בחצוצרות
דלקת כרונית של התוספתן · דלקת שלפוחית השתן · דלקת כרונית של המעי הגס · שלשול ועצירות · כאב גב תחתון · כאב במפשעה · בצקת
נדודי שינה · אין-אונות וגמירה מוקדמת · קור מיני · הרטבת לילה · פליטת זרע · אי-פוריות · טחורים · תסמונות הפרעה (痫证) · תסמונות ניוון (痿证)
דלקת הערמונית
טבלה 1-5-3 · 📖 עמ' 41

💪 שרירים ומבנים קשורים
● שריר המלעס (Masseter) שריר הלעיסה קשור לשכבה השטחית של נקודות המחמם המשולש, ולנקודות הגב, המותן, העצה והירך. 📖 עמ' 16–17
● השריר הפטריגואידי הצידי וזיז הלסת הפטריגואידי הפנימי קשור לשכבה העמוקה של נקודות המחמם העליון, האמצעי והתחתון; הפטריגואיד החיצוני קשור לשכבה העמוקה של נקודות המחמם העליון והאמצעי ולנקודות הגב. 📖 עמ' 17
● השריר המחצצר (Buccinator) שריר הלחי (בוקינטור) קשור לנקודות המחמם האמצעי והתחתון. 📖 עמ' 17–18

🔗 קשרים לנקודות אחרות והערות המחבר
המחמם התחתון מתואם עם חוליות המותן והעצה. בשיטת ההתאמה קדימה-אחורה אפשר לבחור בנקודת המחמם התחתון בכאב גב תחתון. 📖 עמ' 51, 152
CA-7 CA-8
בחלוקת גוף-נפש: המחמם התחתון – הכבד והכליה. 📖 עמ' 104

📚 מקרים קליניים בספר שבהם נבחרה הנקודה (41)

- כאב ראש מתחי (הרובד ההולוגרפי, עמ' 204)
- סינוסיטיס כרונית (הרובד ההולוגרפי, עמ' 205)
- מיגרנה (הרובד ההולוגרפי, עמ' 206)
- פיברומיאלגיה כרונית (הרובד ההולוגרפי, עמ' 212)
- דלקת סביב מפרק הכתף (הרובד ההולוגרפי, עמ' 216)
- פגיעה בשריר המותני הגדול (1) (הרובד ההולוגרפי, עמ' 226)

← הצג את כל 41 המקרים במאגר

CA-5 עמוד השדרה (אדום)

צוואר (Cervical)

颈穴
Jǐng Xué

📐 **מיקום אנטומי ושרירי מדויק (לפי התמונה):**
הנקודה האדומה העליונה: קדמית לחיבור העליון של אפרכסת האוזן (Helix Root), מעל שורש קשת הזיגומה ומפרק הלסת.

👆 **איך מוצאים במישוש (PALPATION):**
משש צמוד לקצה העליון-קדמי של האוזן מעל שורש עצם הלחי.

עובי, עומק ורקמת יעד
0.16×13 מ"מ | עומק 2–3 מ"מ בהטיה שטחית על הפאשיה

צד דיקור וזמן שהייה
בצד הכאב (איפסילטרלי) או דו-צדדי | 30 דקות

🩺 **התוויות קליניות:**
נקודת המאסטר לכל פתולוגיות הצוואר: צוואר תפוס חריף, בלט/פריצת דיסק צווארית, רדיקולופתיה צווארית ונוקשות בשרירי הצוואר.

📄 **לפי טבלה 1 בדיווח המקרה:**
מיקום: הקצה העליון של שורש קשת הזיגומה.
התוויות: כאב צוואר, צוואר תפוס לאחר שינה, ספונדילוזיס צווארי, כאב גרון, סחרחורת, מתח, התכווצות שרירי הסקלנוס, טנטון וכו'.
שימוש לשיכוך כאב בדיווח: P1

📖 **לפי ספר המקור: נקודת הצוואר 颈**

📖 איור 1-2-3 · עמ' 41

⚠️ קיים פער בין תיאור האתר לספר בנקודה זו (שיוך שרירים לנקודות במפת השרירים) – לחצו לפירוט

📐 מיקום סטנדרטי (לפי סימנים גרמיים)

בשוליים העליונים של שורש קשת הלחי.

נקודות עמוד השדרה · 📖 עמ' 41

🔬 מבנה אנטומי בשכבות

שכבה שטחית: עור, פאשיה שטחית, ענף רקתי של עצב הפנים, השוליים הקדמיים של עורק ווריד רקתיים שטחיים.

שכבה עמוקה: פאשיה עמוקה, שריר הרקה, גומת הרקה, שורש קשת הלחי.

טבלה 1-1-2 (מחקר אנטומי) · 📖 עמ' 24, 41

🩺 התוויות עיקריות לפי הספר (11)

כאב צוואר | צוואר תפוס משינה (落枕) | מחלות חוליות הצוואר | כאב גרון | סחרחורת | כאב ראש | מיגרנה | מתח | עווית שרירי הסקאלנוס | תסמונת מוצא בית החזה | טנטון

טבלה 1-5-3 · 📖 עמ' 41

💪 שרירים ומבנים קשורים

● שריר הרקה (Temporalis) שריר הרקה קשור לנקודות הראש והצוואר בדיקור הלחי. 📖 עמ' 16

🔗 קשרים לנקודות אחרות והערות המחבר

במחלות גפה עליונה הקשורות לעמוד השדרה (למשל תסמונת התעלה הקרפלית) יש לבדוק גם את חוליות הצוואר, ולטפל קודם בעמוד השדרה ואחר כך בגפה.

📖 עמ' 51

CA-9 CA-11

📚 מקרים קליניים בספר שבהם נבחרה הנקודה (35)

- מיגרנה (הרובד ההולוגרפי, עמ' 206)
- נוירלגיה של העצב העורפי הגדול (הרובד ההולוגרפי, עמ' 206)
- פגיעת שוט בצוואר (הרובד ההולוגרפי, עמ' 207)
- פגיעה חיצונית בכתף בשילוב כאב בצוואר ובמרפק (הרובד ההולוגרפי, עמ' 208)
- עייפות יתר של שרירי הצוואר ושל שריר הטרפז (הרובד ההולוגרפי, עמ' 208)
- כאב צוואר (הרובד ההולוגרפי, עמ' 208)

← הצג את כל 35 המקרים במאגר

CA-6 עמוד השדרה (אדום)

גב עליון (Dorsal / Thoracic)

背穴
Bèi Xué

📐 **מיקום אנטומי ושרירי מדויק (לפי התמונה):**
הנקודה האדומה השנייה: ממש קדמית לטרגוס של האוזן (אזור SI19), בשקע מפרק הלסת (TMJ) מתחת לשורש קשת הזיגומה.

👆 **איך מוצאים במישוש (PALPATION):**
בקש מהמטופל לפתוח מעט את הפה – ייווצר שקע ברור מתחת לראש מפרק הלסת וקדמית לטרגוס של האוזן.

עובי, עומק ורקמת יעד
0.18–0.16 מ"מ | עומק 3–4 מ"מ אנכית

צד דיקור וזמן שהייה
בצד הכאב (נדקרת בצמד עם CA-5) | 30 דקות

🩺 **התוויות קליניות:**
כאבי גב עליון ושכמות, שריר הטרפז והמעויינים, נוקשות במעבר צוואר-גב (C7–T1).

📄 **לפי טבלה 1 בדיווח המקרה:**
מיקום: נקודת המפגש בין הגבול התחתון של קשת הזיגומה לבין הקופסית התחתונה של מפרק הלסת (TMJ).
התוויות: כאב גב, מתיחת שריר המעוין, מועקה בחזה, קוצר נשימה, כאב בטן, דפיקות לב וכו'.
שימוש לשיכוך כאב בדיווח: P1 P2

📖 **לפי ספר המקור: נקודת הגב 背**

📖 איור 2-2-3 · עמ' 41–43

⚠️ קיימים 3 פערים בין תיאור האתר לספר בנקודה זו (מיקום CA-6 · שיוך שרירים לנקודות במפת השרירים · שבירת טבלה בספר) – לחצו לפירוט

📐 **מיקום סטנדרטי (לפי סימנים גרמיים)**

מתחת לשוליים התחתונים של שורש קשת הלחי, מתחת למפרק הלסת-רקה.

נקודות עמוד השדרה · 📖 עמ' 41–43

🔬 **מבנה אנטומי בשכבות**

שכבה שטחית: עור, פאשיה שטחית, בלוטת הפרוטיד.

שכבה עמוקה: פאשיה עמוקה, השוליים הקדמיים של הווריד הרטרומנדיבולרי, שריר הרקה, גומת הרקה, שורש קשת הלחי.

טבלה 1-1-2 (מחקר אנטומי) · 📖 עמ' 24, 41–43

🩺 **התוויות עיקריות לפי הספר (8)**

לחץ בחזה | קוצר נשימה | כאב קיבה | כאב גב | תחושת קור בגב | מאמץ יתר של שריר המעוין | דפיקות לב | עווית של הסרעפת

טבלה 3-5-1 · 📖 עמ' 41–43

💪 **שרירים ומבנים קשורים**

● שריר הרקה (Temporalis) מופיע במבנה העמוק של הנקודה. 📖 עמ' 41–43

● שריר המלעס (Masseter) שריר הלעיסה קשור לשכבה השטחית של נקודות המחמם המשולש, ולנקודות הגב, המותן, העצה והירך. 📖 עמ' 16–17

● השריר הפטריגואידי הצידי וזיז הלסת הפטריגואידי הפנימי קשור לשכבה העמוקה של נקודות המחמם העליון, האמצעי והתחתון; הפטריגואיד החיצוני קשור לשכבה העמוקה של נקודות המחמם העליון והאמצעי ולנקודות הגב. 📖 עמ' 17

📚 **מקרים קליניים בספר שבהם נבחרה הנקודה (18)**

- עייפות יתר של שרירי הצוואר ושל שריר הטרפז (הרובד ההולוגרפי, עמ' 208)
- כאב צוואר (הרובד ההולוגרפי, עמ' 208)
- פיברומיאלגיה של הצוואר, הגב והמותן (הרובד ההולוגרפי, עמ' 210)
- כאב בשרירים לצד חוליות הצוואר והחזה (הרובד ההולוגרפי, עמ' 210)
- פיברומיאלגיה כרונית (הרובד ההולוגרפי, עמ' 212)
- גדילה עצמית של חוליות החזה (הרובד ההולוגרפי, עמ' 212)

← הצג את כל 18 המקרים במאגר

CA-7 עמוד השדרה (אדום)

מותן / גב תחתון (Lumbar)

腰穴
Yāo Xué

📐 **מיקום אנטומי ושרירי מדויק (לפי התמונה):**
הנקודה האדומה השלישית: קדמית-תחתונה לתנוך האוזן, באמצע הקו שבין CA-6 ל-CA-8 לאורך השפה האחורית של ענף הלסת (Ramus) ושריר המלעס.

👆 **איך מוצאים במישוש (PALPATION):**
החלק אצבע מתחת לתנוך האוזן לאורך השפה האחורית של עצם הלסת ושריר המלעס – הנקודה נמצאת מיד מתחת לגובה התנוך.

עובי, עומק ורקמת יעד
0.18–0.16 מ"מ | עומק 3–4 מ"מ לתוך הפאשיה של שריר המלעס האחורי

צד דיקור וזמן שהייה
בצד הכאב או דו-צדדי | 30 דקות

🩺 **התוויות קליניות:**
כאבי גב תחתון חריפים וכרוניים, נקע מותני, בלט דיסק מותני (L1–L5) וכאבי גב תחתון בזמן הווסת.

📄 **לפי טבלה 1 בדיווח המקרה:**
מיקום: אמצע הקו המחבר בין הנקודה הגבית (CA-6) לנקודה הסקראלית (CA-8).
התוויות: כאב גב תחתון, מתיחת שריר מותני, נקע מותני חריף, אישיאס, פריצת דיסק וכו'.
שימוש לשיכוך כאב בדיווח: P1 P2

📖 **לפי ספר המקור: נקודת המותן 腰** 📖 איור 3-2-3 · עמ' 43

⚠️ קיים פער בין תיאור האתר לספר בנקודה זו (פרוטוקולי כאבי מחזור ופריון) – לחצו לפירוט

📐 מיקום סטנדרטי (לפי סימנים גרמיים)

בנקודת האמצע של הקו המחבר בין נקודות הגב (CA-6) והעצה (CA-8).

נקודות עמוד השדרה · 📖 עמ' 43

🔬 מבנה אנטומי בשכבות

שכבה שטחית: עור, פאשיה שטחית, בלוטת הפרוטיד, ענף הלחי של עצב הפנים, וריד הצוואר החיצוני.

שכבה עמוקה: פאשיה עמוקה, השוליים האחוריים של גוף הלסת התחתונה.

טבלה 1-1-2 (מחקר אנטומי) · 📖 עמ' 24, 43

🩺 התוויות עיקריות לפי הספר (5)

כאב גב תחתון | מאמץ יתר של שרירי המותן | נקע חריף במותן | כאב עצב הסיאטיקה | בקע דיסק מותני

טבלה 1-5-3 · 📖 עמ' 43

💪 שרירים ומבנים קשורים

- **שריר המלעס (Masseter)** שריר הלעיסה קשור לשכבה השטחית של נקודות המחמם המשולש, ולנקודות הגב, המותן, העצה והירך. 📖 עמ' 16–17

🔗 קשרים לנקודות אחרות והערות המחבר

בכאב גב תחתון כרוני שבו הרגישות המקומית במותן אינה בולטת, ואילו בבטן יש קשיות, מלאות ורגישות עזה, "נקודת המטרה של הפתולוגיה נמצאת לעיתים קרובות בבטן". 📖 עמ' 51

CA-4

📚 מקרים קליניים בספר שבהם נבחרה הנקודה (19)

- פיברומיאלגיה של הצוואר, הגב והמותן (הרובד ההולוגרפי, עמ' 210)
- כאב במפרק המרפק; עייפות יתר של שרירי המותן (הרובד ההולוגרפי, עמ' 222)
- עייפות יתר של שרירי המותן (הרובד ההולוגרפי, עמ' 226)
- פגיעה בשריר המותני הגדול (1) (הרובד ההולוגרפי, עמ' 226)
- פגיעה בשריר המותני הגדול (2) (הרובד ההולוגרפי, עמ' 227)
- כאב גב תחתון בהריון (הרובד ההולוגרפי, עמ' 228)

← הצג את כל 19 המקרים במאגר

CA-8 עמוד השדרה (אדום)

עצה / סקרום (Sacral)

骶穴
Dǐ Xué

📐 **מיקום אנטומי ושרירי מדויק (לפי התמונה):**
הנקודה האדומה התחתונה: באזור זווית הלסת התחתונה (Mandibular Angle), על אחיזת הגיד התחתון-אחורי של שריר המלעס, אחורית ותחתונה לנקודת הירך (CA-13).

👆 **איך מוצאים במישוש (PALPATION):**
משש את הזווית הגרמית האחורית-תחתונה של הלסת התחתונה על גבי סיבי האחיזה של שריר המלעס.

עובי, עומק ורקמת יעד
0.18–0.16 מ"מ | עומק 3–4 מ"מ

צד דיקור וזמן שהייה
דו-צדדי או בצד הכאב | 30–45 דקות

🩺 **התוויות קליניות:**
כאבי סקרום ועצם הזנב, אישיאס, נקודת מפתח בכאבי מחזור (מקלעת העצבים הסקראלית) ושיפור זרימת הדם לרחם בפריון.

📄 **לפי טבלה 1 בדיווח המקרה:**
מיקום: 0.5 צון קדמית-עליונה לזווית הלסת התחתונה.
התוויות: מתיחת השריר הזוקף (Erector spinae), כאב גב תחתון בנשים, פציעות ברצועות הכסל-עצה, הרטבת לילה, דלקת ערמונית וכו'.
שימוש לשיכוך כאב בדיווח: P1 P2

📖 **לפי ספר המקור: נקודת העצה 骶**
📖 איור 4-2-3 · עמ' 43

⚠️ קיימים 4 פערים בין תיאור האתר לספר בנקודה זו (מיקום CA-8 ו-CA-13 · התוויות שאינן מופיעות בספר · פרוטוקולי כאבי מחזור ופריון · טעות פנימית בספר – מקרה 2-1-8-11) – לחצו לפירוט

📐 מיקום סטנדרטי (לפי סימנים גרמיים)

חצי צון לפני ומעל לזווית הלסת התחתונה.

נקודות עמוד השדרה · 📖 עמ' 43

🔬 מבנה אנטומי בשכבות

שכבה שטחית: עור, פאשיה שטחית, בלוטת הפרוטיד, ענף הלחי של עצב הפנים.

שכבה עמוקה: פאשיה עמוקה, השוליים האחוריים של גוף הלסת התחתונה.

טבלה 1-1-2 (מחקר אנטומי) · 📖 עמ' 24, 43

🩺 התוויות עיקריות לפי הספר (6)

מאמץ יתר של שריר זוקף השדרה (骶棘肌) · כאב גב תחתון על רקע גינקולוגי · פגיעה ברצועות העצה-כסל · הרטבת לילה · הפרעות בתפקוד המיני · דלקת הערמונית

טבלה 1-5-3 · 📖 עמ' 43

💪 שרירים ומבנים קשורים

- **שריר המלעס (Masseter)** שריר הלעיסה קשור לשכבה השטחית של נקודות המחמם המשולש, ולנקודות הגב, המותן, העצה והירך. 📖 עמ' 16–17

🔗 קשרים לנקודות אחרות והערות המחבר

שיטת ההתאמה עליון-תחתון: בכאב ראש אפשר להשתמש בנקודת העצה. 📖 עמ' 153

CA-1

📚 מקרים קליניים בספר שבהם נבחרה הנקודה (19)

- פיברומיאלגיה של הצוואר, הגב והמותן (הרובד ההולוגרפי, עמ' 210)
- כאב במפרק המרפק; עייפות יתר של שרירי המותן (הרובד ההולוגרפי, עמ' 222)
- פגיעה בשריר המותני הגדול (1) (הרובד ההולוגרפי, עמ' 226)
- בקע דיסק מותני בקטע L4–5 עם הסטת חוליה מותנית (הרובד ההולוגרפי, עמ' 228)
- כאב כרוני במותן וברגל עם גדילת עצם בחוליות המותניות (הרובד ההולוגרפי, עמ' 230)

- סיאטיקה (הרובד ההולוגרפי, עמ' 231)

← הצג את כל 19 המקרים במאגר

肩穴
Jiān Xué

כתף (Shoulder)

CA-9 · גפה עליונה (ירוק)

📐 **מיקום אנטומי ושרירי מדויק (לפי התמונה):**
הנקודה הירוקה העליונה: במרכז קשת הזיגומה (על התפר הטמפורו-זיגומטי), קדמית ומעט מעל לנקודת המחמם העליון (CA-2).

👆 **איך מוצאים במישוש (PALPATION):**
העבר אצבע לאורך מרכז קשת עצם הלחי עד שתרגיש שקע/חריץ זעיר במרכז הקשת, מעט קדמית ומעל ל-CA-2.

עובי, עומק ורקמת יעד
0.16×13 מ"מ | עומק 2–3 מ"מ שטחי מעל העצם

צד דיקור וזמן שהייה
בצד הכתף הכואבת | 30 דקות

🩺 **התוויות קליניות:**
כתף קפואה (Frozen Shoulder), דלקות בגידי הכתף (Rotator Cuff), וכאבי צוואר המקרינים לכתף.

📄 **לפי טבלה 1 בדיווח המקרה:**
מיקום: אמצע התפר הטמפורו-זיגומטי.
התוויות: כאב כתף, כתף קפואה, דלקת בגיד הדו-ראשי, סינוביטיס תת-אקרומיאלי, דלקת בגיד הסופרספינטוס וכו'.
שימוש לשיכוך כאב בדיווח: P1

📖 **לפי ספר המקור: נקודת הכתף 肩** · 📖 איור 1-3-3 · עמ' 44

⚠️ קיים פער בין תיאור האתר לספר בנקודה זו (שיוך שרירים לנקודות במפת השרירים) – לחצו לפירוט

📐 מיקום סטנדרטי (לפי סימנים גרמיים)

בנקודת האמצע של התפר הרקתי-זיגומטי (顴髎).

נקודות הגפה העליונה · 📖 עמ' 44

🔬 מבנה אנטומי בשכבות

שכבה שטחית: עור, פאשיה שטחית, ענף זיגומטי של עצב הפנים.

שכבה עמוקה: פאשיה עמוקה, מקום התחברות שריר הלעיסה, השוליים העליונים של קשת הלחי.

טבלה 1-1-2 (מחקר אנטומי) · 📖 עמ' 24, 44

🩺 התוויות עיקריות לפי הספר (8)

כאב כתף · דלקת פרק הכתף (כתף קפואה) · דלקת גיד הראש הארוך של הדו-ראשי · דלקת בורסת תת-אקרומיון · דלקת גיד העל-קוצי · פגיעה בשרוול המסובבים · עוויית שריר הסטרנוקלידומסטואיד · פגיעה בשריר מרים השכמה

טבלה 1-5-3 · 📖 עמ' 44

💪 שרירים ומבנים קשורים

● שריר המלעס (Masseter) מופיע במבנה העמוק של הנקודה. · 📖 עמ' 44

🔗 קשרים לנקודות אחרות והערות המחבר

במחלת כתף, מלבד הפתולוגיה המקומית יש לבדוק קשר לחוליות הצוואר ולרגש ולנפש. · 📖 עמ' 51

CA-1 · CA-5

שיטת ההתאמה המוצלבת: בכאב במפרק הירך השמאלי בוחרים בנקודת הכתף הימנית. שיטת ההתאמה במיקום זהה: מחלה בכתף שמאל – נקודת הכתף בלחי השמאלית. · 📖 עמ' 152–153

CA-13

בפרק הנקודות הייחודיות (奇穴) מובא ציטוט מה"לינג-שו": "עצם הלחי היא הכתף". · 📖 עמ' 34

📚 מקרים קליניים בספר שבהם נבחרה הנקודה (17)

- פגיעה חיצונית בכתף בשילוב כאב בצוואר ובמרפק (הרובד ההולוגרפי, עמ' 208)
- עייפות יתר של שרירי הצוואר ושל שריר הטרפז (הרובד ההולוגרפי, עמ' 208)

- כאב כתף ממקור צווארי (הרובד ההולוגרפי, עמ' 210)
- תסמונת מרובת-שורשים בצוואר ובזרוע (הרובד ההולוגרפי, עמ' 210)
- דלקת בגיד שריר העל-קוצי (הרובד ההולוגרפי, עמ' 214)
- פגיעה במפרק הכתף (הרובד ההולוגרפי, עמ' 214)

← הצג את כל 17 המקרים במאגר

肘穴
Zhǒu Xué

מרפק (Elbow)
CA-10 · גפה עליונה (ירוק)

📐 **מיקום אנטומי ושרירי מדויק (לפי התמונה):**
הנקודה הירוקה השנייה: על גוף עצם הלחי (Zygomatic Bone) ממש מתחת לזווית החיצונית של העין, ובקו אופקי אחד עם נקודת המחמם העליון (CA-2).

👆 **איך מוצאים במישוש (PALPATION):**
רד אנכית מהזווית החיצונית של העין אל הגבול התחתון של גוף עצם הלחי (מוצא שרירי הזיגומה).

עובי, עומק ורקמת יעד
13×0.16 מ"מ | עומק 2–3 מ"מ שטחי

צד דיקור וזמן שהייה
בצד הכאב | 30 דקות

🩺 **התוויות קליניות:**
מרפק טניס (Lateral Epicondylitis), מרפק גולף, כאבים באמה.

📄 **לפי טבלה 1 בדיווח המקרה:**
מיקום: אמצע הקו המחבר בין זווית העין החיצונית לתחתית עצם הלחי.
התוויות: כאב מרפק, מרפק טניס, מרפק גולף, דלקת בגידי פושטי ומכופפי שורש כף היד וכו'.
שימוש לשיכוך כאב בדיווח: –

📖 **לפי ספר המקור: נקודת המרפק** 肘

📖 איור 2-3-3 · עמ' 44

⚠️ קיים פער בין תיאור האתר לספר בנקודה זו (שיוך שרירים לנקודות במפת השרירים) – לחצו לפירוט

📐 מיקום סטנדרטי (לפי סימנים גרמיים)
בנקודת האמצע של הקו המחבר בין הקצה החיצוני של העין לקצה התחתון ביותר של עצם הלחי.

נקודות הגפה העליונה · 📖 עמ' 44

🔬 מבנה אנטומי בשכבות
שכבה שטחית: עור, פאשיה שטחית, ענף זיגומטי של עצב הפנים.
שכבה עמוקה: עצם הלחי.

טבלה 2-1-1 (מחקר אנטומי) · 📖 עמ' 44, 24

🩺 התוויות עיקריות לפי הספר (6)
כאב מרפק · מרפק טניסאים · מרפק גולפרים · דלקת הגיד המשותף של פושטי שורש כף היד · דלקת הגיד המשותף של מכופפי שורש כף היד · דלקת גיד התלת-ראשי

טבלה 3-5-1 · 📖 עמ' 44

📚 מקרים קליניים בספר שבהם נבחרה הנקודה (11)
- פגיעה חיצונית בכתף בשילוב כאב בצוואר ובמרפק (הרובד ההולוגרפי, עמ' 208)
- תסמונת מרובת-שורשים בצוואר ובזרוע (הרובד ההולוגרפי, עמ' 210)
- כאב לאחר ניתוח במפרק הכתף (הרובד ההולוגרפי, עמ' 219)
- כאב במפרק המרפק; עייפות יתר של שרירי המותן (הרובד ההולוגרפי, עמ' 222)
- דלקת באפיקונדיל המדיאלי של עצם הזרוע (הרובד ההולוגרפי, עמ' 223)
- דלקת באפיקונדיל הלטרלי של עצם הזרוע (הרובד ההולוגרפי, עמ' 223)

← הצג את כל 11 המקרים במאגר

CA-11 גפה עליונה (ירוק)

שורש כף יד (Wrist)

腕穴
Wàn Xué

📐 **מיקום אנטומי ושרירי מדויק (לפי התמונה):**
הנקודה הירוקה השלישית: במפגש קו אופקי מבסיס הנחיר עם קפל החיוך (Nasolabial Groove), ובקו אופקי אחד עם נקודת המחמם האמצעי (CA-3).

👆 **איך מוצאים במישוש (PALPATION):**
צא בקו אופקי מבסיס הנחיר אל תוך החריץ השרירי של קפל החיוך.

עובי, עומק ורקמת יעד
0.16×13 מ"מ | עומק 2–3 מ"מ בהחדרה מהירה

צד דיקור וזמן שהייה
בצד הכאב | 30 דקות

🩺 **התוויות קליניות:**
תסמונת התעלה הקרפלית, דלקות גידים ונקעים בשורש כף היד.

📄 **לפי טבלה 1 בדיווח המקרה:**
מיקום: בקפל האף-שפה (Nasolabial fold), בקו האופקי של הקצה התחתון של הנחיר.
התוויות: כאב בשורש כף היד, פציעות במפרק, תסמונת התעלה הקרפלית, כאב באצבעות.
שימוש לשיכוך כאב בדיווח: –

📖 **לפי ספר המקור: נקודת שורש כף היד 腕**

📖 איור 3-3-3 · עמ' 44

⚠️ קיים פער בין תיאור האתר לספר בנקודה זו (שיוך שרירים לנקודות במפת השרירים) – לחצו לפירוט

📐 מיקום סטנדרטי (לפי סימנים גרמיים)

במפגש של הקו האופקי היורד מהשוליים התחתונים של נקבובית האף עם חריץ האף-שפה.

נקודות הגפה העליונה · 📖 עמ' 44

🔬 מבנה אנטומי בשכבות

שכבה שטחית: עור, פאשיה שטחית, ענף הלחי של עצב הפנים, הצד החיצוני של עורק ווריד הפנים.

שכבה עמוקה: פאשיה עמוקה, הצד הפנימי של החלק התחתון של שריר הזיגומטי הגדול, הצד החיצוני של החלק התחתון של שריר השפה העליונה המרובע, החלק האמצעי של גוף הלסת העליונה.

טבלה 2-1-1 (מחקר אנטומי) · 📖 עמ' 24, 44

🩺 התוויות עיקריות לפי הספר (4)

כאב בשורש כף היד | נקע במפרק שורש כף היד | תסמונת התעלה הקרפלית | כאב באצבעות

טבלה 3-5-1 · 📖 עמ' 44

💪 שרירים ומבנים קשורים

- **חוג הפה ומרימי השפה (Orbicularis Oris)** שריר הפה המעגלי קשור לנקודות היד ושורש כף היד, והרגל (כף הרגל) והקרסול. 📖 עמ' 18
- **שרירי הזיגומה (Zygomaticus Major & Minor)** הספר אינו מקדיש לשריר זה סעיף נפרד; הוא מופיע במבנה העמוק של נקודת שורש כף היד (CA-11) – "הצד הפנימי של החלק התחתון של שריר הזיגומטי הגדול". 📖 עמ' 44

🔗 קשרים לנקודות אחרות והערות המחבר

בתסמונת התעלה הקרפלית יש לבדוק גם את חוליות הצוואר, ובמידת הצורך להיעזר בבדיקות הדמיה. 📖 עמ' 51

CA-5

📚 מקרים קליניים בספר שבהם נבחרה הנקודה (2)

- עייפות יתר של שרירי הפשט של פרק כף היד (הרובד ההולוגרפי, עמ' 224)
- תסמונת התעלה הקרפלית עם מחלת עמוד שדרה צווארי (הרובד ההולוגרפי, עמ' 225)

← הצג את כל 2 המקרים במאגר

手穴
Shǒu Xué

CA-12 גפה עליונה (ירוק)

כף יד (Hand)

📐 **מיקום אנטומי ושרירי מדויק (לפי התמונה):**

הנקודה הירוקה התחתונה: בין תחתית הנחיר לשפה העליונה (צידי לפילטרום), על סיבי שריר חוג הפה העליון (Orbicularis Oris).

👆 **איך מוצאים במישוש (PALPATION):**

בחצי הגובה שבין פתח הנחיר לשפה העליונה.

עובי, עומק ורקמת יעד

0.16×13 מ"מ | עומק 1.5–2 מ"מ שטחי מאוד

צד דיקור וזמן שהייה

בצד הכאב | 20–30 דקות

🩺 **התוויות קליניות:**

כאב, נימול או אצבע הדק (Trigger Finger) בכף היד ובאצבעות.

📄 **לפי טבלה 1 בדיווח המקרה:**

מיקום: אמצע הקו המחבר בין הקצה התחתון של הנחיר לגבול האדום של השפה העליונה.

התוויות: דלקת פרקים באצבעות, דלקת בגידים, חוסר תחושה באצבעות או בכף היד.

שימוש לשיכוך כאב בדיווח: –

📖 **לפי ספר המקור: נקודת היד 手**

📖 איור 4-3-3 · עמ' 45

📐 **מיקום סטנדרטי (לפי סימנים גרמיים)**

בנקודת האמצע של הקו המחבר בין נקודת האמצע של השוליים התחתונים של נקבובית האף לבין קו השפה העליונה.

נקודות הגפה העליונה · 📖 עמ' 45

🔬 **מבנה אנטומי בשכבות**

שכבה שטחית: עור, פאשיה שטחית, ענף הלחי של עצב הפנים, מעל עורק השפה העליונה.

שכבה עמוקה: שריר הפה המעגלי, שורשי השיניים העליונות.

טבלה 2-1-1 (מחקר אנטומי) · 📖 עמ' 45, 24

🩺 **התוויות עיקריות לפי הספר (4)**

דלקת במפרקי האצבעות | דלקת בגדן הגיד | חוסר תחושה בקצות האצבעות | חוסר תחושה בכף היד

טבלה 3-5-1 · 📖 עמ' 45

💪 **שרירים ומבנים קשורים**

● חוג הפה ומרימי השפה (Orbicularis Oris) שריר הפה המעגלי קשור לנקודות היד ושורש כף היד, והרגל (כף הרגל) והקרסול. 📖 עמ' 18

🔗 **קשרים לנקודות אחרות והערות המחבר**

המחבר שואל: "איך נקודה אחת ביד יכולה לכסות חמש אצבעות?" – ומציין שמחקר הנקודות עדיין נמשך בעידון נוסף. 📖 עמ' 71

📚 **מקרים קליניים בספר שבהם נבחרה הנקודה (1)**

- תסמונת התעלה הקרפלית עם מחלת עמוד שדרה צווארי (הרובד ההולוגרפי, עמ' 225)

← הצג את כל 1 המקרים במאגר

髋穴
Kuān Xué

ירך (Hip)

CA-13 | גפה תחתונה (כחול)

📐 מיקום אנטומי ושרירי מדויק (לפי התמונה):
הנקודה הכחולה האחורית ביותר: על בליטת שריר המלעס (Masseteric Prominence), ממוקמת בדיוק בין נקודת המחמם התחתון הצהובה (CA-4) לבין נקודת הסקרום האדומה (CA-8).

👆 איך מוצאים במישוש (PALPATION):
בקש מהמטופל להדק שיניים חזק – הנקודה נמצאת על בטן שריר המלעס התחתונה, באמצע הדרך בין CA-4 (בגבול הקדמי) ל-CA-8 (בגבול האחורי).

עובי, עומק ורקמת יעד
0.16–0.18 מ"מ | עומק 3–5 מ"מ לתוך הפאשיה של שריר המלעס

צד דיקור וזמן שהייה
בצד הכאב | 30 דקות

🩺 התוויות קליניות:
כאבי מפרק הירך, בורסיטיס טרוכנטרית, אישיאס המקרין לישבן ולירך.

📄 לפי טבלה 1 בדיווח המקרה:
מיקום: 1 צון קדמית-עליונה לזווית הלסת התחתונה, על בליטת שריר המלעס.
התוויות: אישיאס, דלקת מפרקים ניוונית בירך, פציעה בשריר הפיריפורמיס, כאב במפשעה.
שימוש לשיכוך כאב בדיווח: P1 P2

📖 לפי ספר המקור: נקודת הירך 髋
📖 איור 1-4-3 · עמ' 45

⚠️ קיימים 2 פערים בין תיאור האתר לספר בנקודה זו (מיקום CA-8 ו-CA-13 · טעות פנימית בספר – מקרה 2-8-1-11) – לחצו לפירוט

📐 מיקום סטנדרטי (לפי סימנים גרמיים)
בבליטה של שריר הלעיסה, צון אחד לפני ומעל לזווית הלסת התחתונה.
נקודות הגפה התחתונה · 📖 עמ' 45

🔬 מבנה אנטומי בשכבות
שכבה שטחית: עור, פאשיה שטחית, ענף הלחי של עצב הפנים.
שכבה עמוקה: פאשיה עמוקה, שריר הלעיסה, הבליטה (פקעת) של שריר הלעיסה בלסת התחתונה.
טבלה 1-1-2 (מחקר אנטומי) · 📖 עמ' 24, 45

🩺 התוויות עיקריות לפי הספר (4)
כאב עצב הסיאטיקה | דלקת טראומטית במפרק הירך | פגיעה בשריר האגס (梨状肌) | כאב במפשעה
טבלה 1-5-1 · 📖 עמ' 45

💪 שרירים ומבנים קשורים
● שריר המלעס (Masseter) שריר הלעיסה קשור לשכבה השטחית של נקודות המחמם המשולש, ולנקודות הגב, המותן, העצה והירך. 📖 עמ' 16–17

🔗 קשרים לנקודות אחרות והערות המחבר
שיטת ההתאמה המוצלבת: בכאב במפרק הירך השמאלי בוחרים בנקודת הכתף הימנית. 📖 עמ' 153
CA-9
שיטת ההתאמה הקשורה: בדליות בגפיים התחתונות בוחרים בנקודות הירך, הברך והקרסול. 📖 עמ' 153
CA-14 CA-15

📚 מקרים קליניים בספר שבהם נבחרה הנקודה (4)
- פיברומיאלגיה של הצוואר, הגב והמותן (הרובד ההולוגרפי, עמ' 210)
- פגיעה בשריר העכוז הבינוני (1) (הרובד ההולוגרפי, עמ' 234)
- פגיעה בשריר העכוז הבינוני (2) (הרובד ההולוגרפי, עמ' 235)
- פגיעה בשריר הדו-ראשי של הירך (הרובד ההולוגרפי, עמ' 237)

← הצג את כל 4 המקרים במאגר

膝穴
Xī Xué

CA-14 גפה תחתונה (כחול)

ברך (Knee)

📐 **מיקום אנטומי ושרירי מדויק (לפי התמונה):**
הנקודה הכחולה האמצעית: על הגבול התחתון של גוף הלסת התחתונה (Mandibular Body), באמצע הקו שבין נקודת הירך (CA-13) לנקודת הקרסול (CA-15).

👆 **איך מוצאים במישוש (PALPATION):**
משש לאורך העצם התחתונה של הלסת קדמית לשריר המלעס ובאמצע הדרך לכיוון הסנטר.

עובי, עומק ורקמת יעד
0.18–0.16 מ"מ | עומק 2–4 מ"מ

צד דיקור וזמן שהייה
בצד הברך הכואבת | 30 דקות

🩺 **התוויות קליניות:**
שחיקת סחוס בברך (אוסטיאוארתריטיס), פציעות מניסקוס ורצועות, כאבי ברכיים במדרגות.

📄 **לפי טבלה 1 בדיווח המקרה:**
מיקום: אמצע הקו המחבר בין זווית הלסת התחתונה לנקודת צ'נג-ג'יאנג (CV24 承浆).
התוויות: כאב ברך, כאב לאורך העצב הפרונאלי, דלקת מפרקים, פציעה בשרירי ההמסטרינג, התכווצות שריר התאומים (Gastrocnemius) וכו'.
שימוש לשיכוך כאב בדיווח: P1

📖 **לפי ספר המקור: נקודת הברך 膝** 📖 איור 2-4-3 · עמ' 45–46

⚠️ קיים פער בין תיאור האתר לספר בנקודה זו (מיקום CA-14 עד CA-16 ושרירי הסנטר) – לחצו לפירוט

📐 מיקום סטנדרטי (לפי סימנים גרמיים)

בנקודת האמצע של הקו המחבר בין זווית הלסת התחתונה לנקודת צ'נג-ג'יאנג (承浆, CV-24).

נקודות הגפה התחתונה · 📖 עמ' 45–46

🔬 מבנה אנטומי בשכבות

שכבה שטחית: עור, פאשיה שטחית, ענף הלחי של עצב הפנים, השוליים האחוריים של עורק הפנים.

שכבה עמוקה: פאשיה עמוקה, השוליים הקדמיים של שריר הלעיסה, השוליים התחתונים של החלק האמצעי של גוף הלסת התחתונה.

טבלה 1-1-2 (מחקר אנטומי) · 📖 עמ' 24, 45–46

🩺 התוויות עיקריות לפי הספר (7)

כאב במפרק הברך · כאב עצב הפרונאלי השטחי · דלקת מפרק הברך · פגיעה בשריר הפופליטאלי (腘肌) · עוויות שריר התאומים · דליות בגפה התחתונה · בצקת בגפה התחתונה

טבלה 1-5-1 · 📖 עמ' 45–46

💪 שרירים ומבנים קשורים

● שריר המלעס (Masseter) מופיע במבנה העמוק של הנקודה. 📖 עמ' 45–46

🔗 קשרים לנקודות אחרות והערות המחבר

ההשלכה על הלחי רציפה: בין נקודת הירך לנקודת הברך נמצאת ההשלכה של הירך (הפמור), ובין הברך לקרסול – של השוק. 📖 עמ' 39

CA-13 CA-15

📚 מקרים קליניים בספר שבהם נבחרה הנקודה (10)

- נוירלגיה של העצב הירכי (הרובד ההולוגרפי, עמ' 231)
- רכות סחוס של פיקת הברך (הרובד ההולוגרפי, עמ' 239)
- כאב במפרק הברך לאחר כריתת המניסקוס (הרובד ההולוגרפי, עמ' 239)
- דלקת במפרק הברך (הרובד ההולוגרפי, עמ' 240)
- דלקת במפרק הברך; עווית בשריר הטרפז (הרובד ההולוגרפי, עמ' 241)
- תסמונת הרגליים חסרות המנוחה (הרובד ההולוגרפי, עמ' 241)

← הצג את כל 10 המקרים במאגר

קרסול (Ankle)

CA-15 · גפה תחתונה (כחול)

踝穴
Huái Xué

📐 **מיקום אנטומי ושרירי מדויק (לפי התמונה):**
הנקודה הכחולה התחתונה בסנטר: בצד התחתון של הסנטר, מעט אחורית ותחתונה לנקודת כף הרגל (CA-16), בבסיס שריר מוריד השפה התחתונה.

👆 **איך מוצאים במישוש (PALPATION):**
בחלק הקדמי-תחתון של הלסת התחתונה בצידי הסנטר, מעט מתחת ומאחורי CA-16.

עובי, עומק ורקמת יעד
13×0.16 מ"מ | עומק 2–3 מ"מ

צד דיקור וזמן שהייה
בצד הקרסול הכואב | 30 דקות

🩺 **התוויות קליניות:**
נקע חריף או כרוני בקרסול, דלקת בגיד אכילס, נפיחות בקרסול.

📄 **לפי טבלה 1 בדיווח המקרה:**
מיקום: בשליש הקרוב (לנקודת הברך) של הקו המחבר בין נקודת הברך (CA-14) לנקודת צ'נג-ג'יאנג (CV24 承浆).
התוויות: נקע בקרסול, נפיחות וכאב, דלקת מפרקים בקרסול, דלקת בגיד אכילס, כאב בעקב.
שימוש לשיכוך כאב בדיווח: –

📖 **לפי ספר המקור: נקודת הקרסול 踝**

📖 איור 3-4-3 · עמ' 46

⚠️ קיים פער בין תיאור האתר לספר בנקודה זו (מיקום CA-14 עד CA-16 ושרירי הסנטר) – לחצו לפירוט

📐 **מיקום סטנדרטי (לפי סימנים גרמיים)**

על הקו המחבר בין נקודת הברך (CA-14) לצ'נג-ג'יאנג (CV-24), בשליש הקרוב לקו האמצע של הגוף.

נקודות הגפה התחתונה · 📖 עמ' 46

🔬 **מבנה אנטומי בשכבות**

שכבה שטחית: עור, פאשיה שטחית, ענף שולי הלסת התחתונה של עצב הפנים, השוליים הקדמיים של עורק הפנים.

שכבה עמוקה: פאשיה עמוקה, שריר מוריד זווית הפה, השוליים האחוריים של נקב הלסת התחתונה (הנקב המנטלי), עצב הסנטר.

טבלה 2-1-1 (מחקר אנטומי) · 📖 עמ' 24, 46

🩺 **התוויות עיקריות לפי הספר (5)**

נקע במפרק הקרסול | נפיחות וכאב | דלקת מפרק הקרסול | דלקת גיד אכילס | תסמונת כאב העקב

טבלה 3-5-1 · 📖 עמ' 46

💪 **שרירים ומבנים קשורים**

- **חוג הפה ומרימי השפה (Orbicularis Oris)** שריר הפה המעגלי קשור לנקודות היד ושורש כף היד, והרגל (כף הרגל) והקרסול. 📖 עמ' 18
- **מורידי זווית הפה והסנטר (Mentalis & Depressors)** הספר מציין את שריר מוריד זווית הפה במבנה העמוק של נקודת הקרסול (CA-15), ואת שריר מוריד השפה התחתונה במבנה העמוק של נקודת כף הרגל (CA-16). שריר הסנטר (Mentalis) עצמו אינו מוזכר בטבלת הנקודות. 📖 עמ' 46

📚 **מקרים קליניים בספר שבהם נבחרה הנקודה (12)**

- דלקת במפרק הברך (הרובד ההולוגרפי, עמ' 240)
- תסמונת הרגליים חסרות המנוחה (הרובד ההולוגרפי, עמ' 241)
- פגיעה בשריר התאומים (הרובד ההולוגרפי, עמ' 242)
- דלקת בגיד שריר התאומים (הרובד ההולוגרפי, עמ' 243)
- פגיעה בשריר הפרוני הארוך עם כאב במפשעה (הרובד ההולוגרפי, עמ' 243)
- דלקת בגיד אכילס (1) (הרובד ההולוגרפי, עמ' 244)

← הצג את כל 12 המקרים במאגר

足穴
Zú Xué

CA-16 גפה תחתונה (כחול)

כף רגל (Foot)

📐 מיקום אנטומי ושרירי מדויק (לפי התמונה):

הנקודה הכחולה הקדמית ביותר בסנטר: בצד הסנטר (כ-0.5 צון הצידה ממרכז הסנטר), מעט קדמית וגבוהה יותר מנקודת הקרסול (CA-15), על שריר הסנטר (Mentalis).

👆 איך מוצאים במישוש (PALPATION):

אתר את בליטת הסנטר מתחת לשפה התחתונה וזוז חצי רוחב אגודל הצידה (קדמית ומעל ל-CA-15).

עובי, עומק ורקמת יעד

13×0.16 מ"מ | עומק 2–3 מ"מ

צד דיקור וזמן שהייה

בצד הכואב | 30 דקות

🩺 התוויות קליניות:

דורבן בעקב (Plantar Fasciitis), כאבים בכריות כף הרגל או נימול בבהונות.

📄 לפי טבלה 1 בדיווח המקרה:

מיקום: 0.5 צון לצד נקודת צ'נג-ג'יאנג (承浆 CV24).

התוויות: גאוט (שיגדון), מתיחת הפאשיה הפלנטרית, דורבן, כאב בעקב, כאב בבוהן.

שימוש לשיכוך כאב בדיווח: P1

📖 לפי ספר המקור: נקודת כף הרגל 足

📖 איור 3-4-4 · עמ' 46

⚠️ קיים פער בין תיאור האתר לספר בנקודה זו (מיקום CA-14 עד CA-16 ושרירי הסנטר) – לחצו לפירוט

📐 מיקום סטנדרטי (לפי סימנים גרמיים)

חצי צון לצד נקודת צ'נג-ג'יאנג (CV-24).

נקודות הגפה התחתונה · 📖 עמ' 46

🔬 מבנה אנטומי בשכבות

שכבה שטחית: עור, פאשיה שטחית, ענף שולי הלסת התחתונה של עצב הפנים, השוליים הקדמיים של עורק הפנים.

שכבה עמוקה: פאשיה עמוקה, שריר מוריד השפה התחתונה, השוליים האחוריים של נקב הלסת התחתונה, ענף של עצב הסנטר.

טבלה 2-1-1 (מחקר אנטומי) · 📖 עמ' 24, 46

🩺 התוויות עיקריות לפי הספר (5)

שיגדון (风痛) | פגיעה בפאשיה הפלנטרית | כאב בכף הרגל | תסמונת כאב העקב | כאב בבוהן

טבלה 3-5-1 · 📖 עמ' 46

💪 שרירים ומבנים קשורים

● חוג הפה ומרימי השפה (Orbicularis Oris) שריר הפה המעגלי קשור לנקודות היד ושורש כף היד, והרגל (כף הרגל) והקרסול. 📖 עמ' 18

● מורידי זווית הפה והסנטר (Mentalis & Depressors) הספר מציין את שריר מוריד זווית הפה במבנה העמוק של נקודת הקרסול (CA-15), ואת שריר מוריד השפה התחתונה במבנה העמוק של נקודת כף הרגל (CA-16). שריר הסנטר (Mentalis) עצמו אינו מוזכר בטבלת הנקודות. 📖 עמ' 46

📚 מקרים קליניים בספר שבהם נבחרה הנקודה (3)

- מרפק טניסאי ותסמונת מורטון (הרובד ההולוגרפי, עמ' 224)
- תסמונת מורטון (הרובד ההולוגרפי, עמ' 245)
- תסמונת תעלת הקרסול (הרובד ההולוגרפי, עמ' 247)

← הצג את כל 3 המקרים במאגר

ב2 כרטיסי 7 השרירים

כל הפרטים של כל שריר, כפי שהם מוצגים באטלס כשבוחרים בו.

שריר המפתח #1 בשיטה | אנטומיית שרירי הלסת והלחי

2. שריר המלעס (Masseter)

Masseter Muscle (Superficial & Deep Heads)

🦴 תחל ואחז (מאיפה לאיפה השריר עובר):

מתחיל מהגבול התחתון של קשת הזיגומה (עצם הלחי) ויורד למטה ואחורה עד לזווית הלסת התחתונה (Mandibular Angle) ולחלק החיצוני של ענף הלסת (Ramus).

👆 איך להקפיץ ולמשש אותו בקליניקה:

בקש מהמטופל לנשוך/להדק שיניים חזק – השריר המלבני יקפוץ מיד מתחת לאצבעותיך בחלק האחורי של הלחי. משש את ה'מדרגה' הקדמית שלו (הגבול הקדמי) ואת הבליטה המרכזית שלו.

📍 נקודות הדיקור שעל השריר ובגבולותיו:

זהו 'מגדלור המיפוי' החשוב ביותר בדיקור לחי! לאורך הגבול הקדמי שלו יושבים שלושת המחממים בצהוב (CA-2, CA-3, CA-4), על הגבול האחורי שלו יושבים המותן והסקרום באדום (CA-7, CA-8), ובלב הבטן השרירית התחתונה שלו (בין CA-4 ל-CA-8) יושבת נקודת הירך בכחול (CA-13).

- CA-2: מחמם עליון
- CA-3: מחמם אמצעי
- CA-4: מחמם תחתון
- CA-7: מותן / גב תחתון
- CA-8: עצה / סקרום
- CA-13: ירך

📖 לפי ספר המקור: שריר הלעיסה (咬肌)

📖 איור 4-2-1 · עמ' 16–17

שריר הלעיסה קשור לשכבה השטחית של נקודות המחמם המשולש, ולנקודות הגב, המותן, העצה והירך.

נקודות הקשורות לשריר לפי הספר:

CA-2 מחמם עליון | CA-3 מחמם אמצעי | CA-4 מחמם תחתון | CA-6 גב עליון | CA-7 מותן / גב תחתון | CA-8 עצה / סקרום | CA-13 ירך

מופיע ב"מבנה העמוק" של הנקודות (טבלה 1-1-2):

CA-3 | CA-4 | CA-9 | CA-13 | CA-14

⚠️ השיוך באתר (CA-2, CA-3, CA-4, CA-7, CA-8, CA-13) שונה מהשיוך בספר – לפירוט

🦴 תיאור השריר בספר

הסיבים השטחיים מתחילים ב-2/3 הקדמיים של קשת הלחי, והעמוקים ב-1/3 האחורי ובמשטחה הפנימי; שריר מרובע חזק המכסה את המשטח החיצוני של ענף הלסת ומסתיים בפקעת שריר הלעיסה. בנשיכה חזקה הבליטה המורגשת בשני צדי הלחי היא שריר הלעיסה.

שריר לעיסה ורקה | אנטומיית שרירי הלסת והלחי

1. שריר הרקה (Temporalis)

Temporalis Muscle

🦴 תחל ואחז (מאיפה לאיפה השריר עובר):

שריר רחב דמוי מניפה המכסה את עצם הרקה (מעל קשת הזיגומה). סיביו מתכנסים למטה, עוברים מתחת לקשת הזיגומה ומתחברים לזיז הוויי (Coronoid Process) של הלסת התחתונה.

👆 איך להקפיץ ולמשש אותו בקליניקה:

הנח אצבעות על הרקה (מעל עצם הלחי, בגובה קו העין) ובקש מהמטופל להדק שיניים – תרגיש את המניפה השרירית מתכווצת. הגיד התחתון שלו מתחבר בדיוק באזור נקודת המחמם העליון (CA-2).

📍 נקודות הדיקור שעל השריר ובגבולותיו:

על הבטן השרירית של הרקה בגובה העין יושבת נקודת הראש הסגולה הגדולה (CA-1), מעל קשת הזיגומה יושבת נקודת הכתף (CA-9), ובחיבור הגיד לזיז הוויי של הלסת יושבת נקודת המחמם העליון (CA-2).

- CA-1: ראש
- CA-2: מחמם עליון
- CA-9: כתף

📖 לפי ספר המקור: שריר הרקה (颞肌)

📖 איור 3-2-1 · עמ' 16

שריר הרקה קשור לנקודות הראש והצוואר בדיקור הלחי.

נקודות הקשורות לשריר לפי הספר:

CA-1 ראש | CA-5 צוואר

מופיע ב"מבנה העמוק" של הנקודות (טבלה 1-1-2):

CA-1 | CA-5 | CA-6

⚠️ השיוך באתר (CA-1, CA-2, CA-9) שונה מהשיוך בספר – לפירוט

🦴 תיאור השריר בספר

מתחיל בגומת הרקה; אגודות השריר מתכנסות כמניפה לגיד שטוח, עוברות במשטח העמוק של קשת הלחי ומסתיימות בבליטת הקורונואיד של הלסת התחתונה. שלוש אגודות (קדמית, אמצעית, אחורית) המועצבות בנפרד על ידי ענפי העצב הרקתי העמוק.

שריר שקע הלחי (המחממים)

אנטומיית שרירי הלסת והלחי

3. השריר המחצצר (Buccinator)

Buccinator Muscle (Deep Cheek Wall)

🦴 תחל ואחז (מאיפה לאיפה השריר עובר):

השריר העמוק המרכיב את הדופן הרכה של הלחי ('השקע של הלחי'). עובר אופקית מהלסת העליונה והתחתונה (מול השיניים הטוחנות) קדימה אל זווית הפה, ממוקם ממש קדמית לשריר המלעס.

👆 איך להקפיץ ולמשש אותו בקליניקה:

זהו האזור הרך של הלחי שלתוכו האצבע שוקעת ברגע שמחליקים קדימה משריר המלעס הקשה. הוא פועל כשמנפחים את הלחיים או שואבים אותן פנימה.

📍 נקודות הדיקור שעל השריר ובגבולותיו:

שלושת המחממים הצהובים (CA-2, CA-3, CA-4) נדקרים לאורך התפר הפאשיאלי שבין הגבול הקדמי של שריר המלעס לבין השריר המחצצר.

- CA-2: מחמם עליון
- CA-3: מחמם אמצעי
- CA-4: מחמם תחתון

📖 לפי ספר המקור: שריר הלחי – בוקינטור (颊肌)

📖 איור 2-1-6 · עמ' 17–18

שריר הלחי (בוקינטור) קשור לנקודות המחמם האמצעי והתחתון.

נקודות הקשורות לשריר לפי הספר:

CA-3 מחמם אמצעי · CA-4 מחמם תחתון

⚠️ השיוך באתר (CA-2, CA-3, CA-4) שונה מהשיוך בספר – לפירוט

🦴 תיאור השריר בספר

שריר שטוח מרובע המהווה את בסיס אזור הלחי; מתחיל מהצד החיצוני של מכתש הטוחנת השלישית בשתי הלסתות ומתפתר הפטריגו-מנדיבולרי, וסיביו נעים קדימה ומשתתפים ביצירת שריר הפה המעגלי.

שרירי הבעה - גפה עליונה

אנטומיית שרירי הלסת והלחי

4. שרירי הזיגומה (Zygomaticus Major & Minor)

Zygomaticus Major & Minor Muscles

🦴 תחל ואחז (מאיפה לאיפה השריר עובר):

יוצאים מגוף עצם הלחי (Zygomatic Bone) ויורדים באלכסון קדימה ומטה אל זווית הפה והשפה העליונה (מרימים את זווית הפה בחיוך).

👆 איך להקפיץ ולמשש אותו בקליניקה:

בקש מהמטופל לחייך חיוך רחב – תרגיש את הרצועה השרירית האלכסונית שנמתחת מעצם הלחי אל זווית הפה.

📍 נקודות הדיקור שעל השריר ובגבולותיו:

מסלול הגפה העליונה (הנקודות הירוקות) עוקב אחרי שרירי הזיגומה: מנקודת הכתף (CA-9) ונקודת המרפק (CA-10) שעל עצם הלחי ועד לנקודת שורש כף היד (CA-11) בקפל החיוך.

- CA-9: כתף
- CA-10: מרפק
- CA-11: שורש כף יד

📖 לפי ספר המקור: שריר הזיגומטי הגדול (מבנה עמוק של CA-11)

📖 עמ' 44

הספר אינו מקדיש לשריר זה סעיף נפרד; הוא מופיע במבנה העמוק של נקודת שורש כף היד (CA-11) – "הצד הפנימי של החלק התחתון של שריר הזיגומטי הגדול".

נקודות הקשורות לשריר לפי הספר:

CA-11 שורש כף יד

מופיע ב"מבנה העמוק" של הנקודות (טבלה 1-1-2):

CA-11

⚠️ השיוך באתר (CA-9, CA-10, CA-11) שונה מהשיוך בספר – לפירוט

שרירי השפה והאף | אנטומיית שרירי הלסת והלחי

5. חוג הפה ומרימי השפה (Orbicularis Oris)

Orbicularis Oris & Levator Labii Superioris

🦴 תחל ואחז (מאיפה לאיפה השריר עובר):

שריר טבעתי המקיף את השפתיים, ואליו מתחברים מלמעלה שרירי הרמת השפה העליונה וכנף האף (לאורך קפל החיוך - Nasolabial Fold).

👆 איך להקפיץ ולמשש אותו בקליניקה:

משש את החריץ של קפל החיוך בגובה בסיס הנחיריים (בקו אופקי עם CA-3), ואת השריר השטחי שבין הנחיר לשפה העליונה.

📍 נקודות הדיקור שעל השריר ובגבולותיו:

נקודת שורש כף היד הירוקה (CA-11) יושבת בקפל החיוך בגובה בסיס הנחיר, ונקודת כף היד הירוקה (CA-12) יושבת מעל השפה העליונה מתחת לנחיר.

- CA-11: שורש כף יד
- CA-12: כף יד

📖 לפי ספר המקור: שריר הפה המעגלי (口轮匝肌)

📖 איור 2-1-6 · עמ' 18

שריר הפה המעגלי קשור לנקודות היד ושורש כף היד, והרגל (כף הרגל) והקרסול.

נקודות הקשורות לשריר לפי הספר:

CA-11 שורש כף יד | CA-12 כף יד | CA-15 קרסול | CA-16 כף רגל

מופיע ב"מבנה העמוק" של הנקודות (טבלה 1-1-2):

CA-12

⚠️ השיוך באתר (CA-11, CA-12) שונה מהשיוך בספר – לפירוט

🦴 תיאור השריר בספר

טבעת שרירית שטוחה במרכז החלק התחתון של הפנים (רוחב כ-2–3 ס"מ), הבנויה שכבות: סיבים עצמיים בשכבה השטחית, סיבים מהבוקינטור בשכבה העמוקה, וסיבי הזיגומטי ומרימי השפה בשכבה האמצעית.

שריר לעיסה עמוק ומפרק הלסת | אנטומיית שרירי הלסת והלחי

6. השריר הפטריגואידי הצידי וזיז הלסת

Lateral Pterygoid & Coronoid Process Zone

🦴 תחל ואחז (מאיפה לאיפה השריר עובר):

שוכן בעומק שקע הלחי מתחת לקשת הזיגומה, ומתחבר לצוואר מפרק הלסת (TMJ) ולקופסית המפרק (קדמית לטרגוס של האוזן).

👆 איך להקפיץ ולמשש אותו בקליניקה:

הנח אצבע מתחת לקשת הזיגומה ובקש מהמטופל לפתוח ולסגור את הפה: בחלק האחורי (ליד הטרגוס) תרגיש את ראש מפרק הלסת זז (CA-6), ובחלק הקדמי תרגיש את הזיז הוויי נע קדימה ואחורה (CA-2).

📍 נקודות הדיקור שעל השריר ובגבולותיו:

חיוני לאיתור מדויק של נקודת המחמם העליון (CA-2) מאחורי הזיז הוויי, ולנקודות הצוואר והגב העליון האדומות (CA-5, CA-6) הצמודות לקדמת האוזן ומפרק הלסת.

- CA-2: מחמם עליון
- CA-5: צוואר
- CA-6: גב עליון

📖 לפי ספר המקור: שרירי הפטריגואיד הפנימי (翼内肌) והחיצוני (翼外肌)

📖 איור 2-1-5 · עמ' 17

הפטריגואיד הפנימי קשור לשכבה העמוקה של נקודות המחמם העליון, האמצעי והתחתון; הפטריגואיד החיצוני קשור לשכבה העמוקה של נקודות המחמם העליון והאמצעי ולנקודות הגב.

נקודות הקשורות לשריר לפי הספר:

CA-2 מחמם עליון | CA-3 מחמם אמצעי | CA-4 מחמם תחתון | CA-6 גב עליון

⚠️ השיוך באתר (CA-2, CA-5, CA-6) שונה מהשיוך בספר – לפירוט

🦴 תיאור השריר בספר

הפנימי: בעומק שרירי הלעיסה והרקה, מגומת הפטריגואיד אל המשטח הפנימי של זווית הלסת; מסייע להרמת הלסת. החיצוני: מכוסה בקשת הלחי, נצמד לצוואר הלסת, לדיסקית ולמעטפת המפרק; מקדם את הלסת ומשתתף בפתיחת הפה.

שרירי הסנטר וקו הלסת
אנטומיית שרירי הלסת והלחי

7. מורידי זווית הפה והסנטר (Mentalis & Depressors)

Depressor Anguli Oris, Depressor Labii & Mentalis

🦴 **תחל ואחז (מאיפה לאיפה השריר עובר):**

שרירים הנאחזים לאורך הגבול התחתון של גוף הלסת התחתונה (Mandibular Body) ועולים אל זווית הפה, השפה התחתונה והסנטר.

👆 **איך להקפיץ ולמשש אותו בקליניקה:**

משש לאורך העצם התחתונה של הלסת מאזור שריר המלעס קדימה אל צידי הסנטר מתחת לזווית הפה והשפה התחתונה.

📍 **נקודות הדיקור שעל השריר ובגבולותיו:**

לאורך אחיזת השרירים הללו ממוקמות 3 מנקודות הגפה התחתונה הכחולות: ברך (CA-14) באמצע גוף הלסת, וקרסול (CA-15) וכף רגל (CA-16) בצד הסנטר.

- CA-14: ברך
- CA-15: קרסול
- CA-16: כף רגל

📖 **לפי ספר המקור: מורידי זווית הפה והשפה התחתונה (מבנה עמוק של CA-15/CA-16)**

📖 עמ' 46

הספר מציין את שריר מוריד זווית הפה במבנה העמוק של נקודת הקרסול (CA-15), ואת שריר מוריד השפה התחתונה במבנה העמוק של נקודת כף הרגל (CA-16). שריר הסנטר (Mentalis) עצמו אינו מוזכר בטבלת הנקודות.

נקודות הקשורות לשריר לפי הספר:

CA-15 קרסול · CA-16 כף רגל

מופיע ב"מבנה העמוק" של הנקודות (טבלה 1-1-2):

CA-15 · CA-16

⚠️ השיוך באתר (CA-14, CA-15, CA-16) שונה מהשיוך בספר – לפירוט

4 טבלת 16 הנקודות: מיקום, התוויות ושימוש בדיווח

נקודות הדיקור הסטנדרטיות בדיקור לחי, השימושים העיקריים שלהן, והנקודות ששימשו לשיכוך כאב בדיווח המקרה (טבלה 1). לחיצה על שורה מציגה את הנקודה באטלס.

קוד	שם הנקודה	מיקום	התוויות	בשימוש בדיווח
CA-1	**ראש (Head)** 头穴 Tóu Xué	1 צון מעל אמצע הגבול העליון של קשת הזיגומה. 📖 צון אחד מעל השוליים העליונים של נקודת האמצע של קשת הלחי (הקשת הזיגומטית). (עמ' 39–40)	כאב ראש, סחרחורת, כאב שיניים, נדודי שינה, מתח, חרדה, דיכאון, שבץ וכו'. 📖 כאב ראש, סחרחורת, כאב שיניים, נדודי שינה, מתח, חרדה, דיכאון, שבץ מוחי, תסמונת פרקינסון, דמנציה סנילית, טנטון	P1
CA-2	**מחמם עליון (Upper) (Energizer** 上焦穴 Shàng Jiāo Xué	נקודת המפגש בין השפה האחורית של הזיז הקורונואידי של הלסת התחתונה לבין הגבול התחתון של קשת הזיגומה. 📖 מאחורי תהליך הקורונואיד של הלסת התחתונה, במפגש עם השוליים התחתונים של קשת הלחי. (עמ' 41)	כאב ראש, כאב צוואר, כאב בחזה, מועקה בחזה, נפיחות וכאב בשדיים, טכיקרדיה, הפרעות קצב, אסטמה וכו'. 📖 כאב ראש, כאב צוואר, כאב חזה, לחץ בחזה, כאב ונפיחות בשדיים, דפיקות לב, הפרעות קצב, אסתמה, שיעול, ברונכיטיס, מתח, חרדה, עצבנות, עצב, סחרחורת, מחלות חמשת האיברים (五官), נפיחות וכאב בבטן, עווית סרעפת, כאב גרון, נדודי שינה	P1
CA-3	**מחמם אמצעי Middle) (Energizer** 中焦穴 Zhōng Jiāo Xué	אמצע הקו המחבר בין נקודות המחמם העליון והמחמם התחתון. 📖 בנקודת האמצע של הקו המחבר בין נקודות המחמם העליון (CA-2) והמחמם התחתון (CA-4). (עמ' 41)	התכווציות בקיבה, דלקת קיבה חריפה/כרונית, צרבת וחומציות. 📖 עווית קיבה, דלקת קיבה חריפה וכרונית, צרבת וחומציות, שיהוקים, הקאות, נפיחות וכאב בבטן, דלקת כיס המרה, כיב קיבה, כיב בפקעת התריסריון, כאב גב, חרדה, עקשנות, דאגה, סוכרת, יתר לחץ דם, מחלות כבד, נדודי שינה, עייפות כרונית, השמנה, כבד שומני	P1
CA-4	**מחמם תחתון Lower) (Energizer** 下焦穴 Xià Jiāo Xué	על הקו האלכסוני הקדמי של הלסת התחתונה. 📖 בשוליים הקדמיים של הזווית הפנימית של הלסת התחתונה. (עמ' 41)	נפיחות וכאב בבטן, קוליטיס, כאבי מחזור, מחלה דלקתית של האגן (PID), אי-סדירות בווסת, הפרשות נרתיקיות, מחלות גינקולוגיות. 📖 נפיחות וכאב בבטן, דלקת המעי הגס, כאבי מחזור, הפרשות נרתיקיות, דלקת באגן, מחזור לא סדיר, שרירים ברחם, דלקת בחצוצרות, דלקת כרונית של התוספתן, דלקת שלפוחית השתן, דלקת כרונית של המעי הגס, שלשול ועצירות, כאב גב תחתון, כאב במפשעה, בצקת, נדודי שינה, אין-אונות וגמירה מוקדמת, קור מיני, הרטבת לילה, פליטת זרע, אי-פוריות, טחורים, תסמונות הפרעה (痹证), תסמונות ניוון (痿证), דלקת הערמונית	P1
CA-5	**צוואר (Cervical)** 颈穴 Jǐng Xué	הקצה העליון של שורש קשת הזיגומה. 📖 בשוליים העליונים של שורש קשת הלחי. (עמ' 41)	כאב צוואר, צוואר תפוס לאחר שינה, ספונדילוזיס צווארי, כאב גרון, סחרחורת, מתח, התכווצות שרירי הסקלנוס, טנטון וכו'. 📖 כאב צוואר, צוואר תפוס משינה (落枕), מחלות חוליות הצוואר, כאב גרון, סחרחורת, כאב ראש, מיגרנה, מתח, עווית שרירי הסקאלנוס, תסמונת מוצא בית החזה, טנטון	P1
CA-6	**גב עליון Dorsal /) (Thoracic** 背穴 Bèi Xué	נקודת המפגש בין הגבול התחתון של קשת הזיגומה לבין הקופסית התחתונה של מפרק הלסת (TMJ). 📖 מתחת לשוליים התחתונים של שורש קשת הלחי, מתחת למפרק הלסת-רקה. (עמ' 41–43)	כאב גב, מתיחת שריר המעוין, מועקה בחזה, קוצר נשימה, כאב בטן, דפיקות לב וכו'. 📖 לחץ בחזה, קוצר נשימה, כאב קיבה, כאב גב, תחושת קור בגב, מאמץ יתר של שריר המעוין, דפיקות לב, עווית של הסרעפת	P1 P2

קוד	שם הנקודה	מיקום	התוויות	בשימוש בדיווח
CA-7	**מותן / גב תחתון (Lumbar)** 腰穴 Yāo Xué	אמצע הקו המחבר בין הנקודה הגבית (CA-6) לנקודה הסקראלית (CA-8). 📖 בנקודת האמצע של הקו המחבר בין נקודות הגב (CA-6) והעצה (CA-8). (עמ' 43)	כאב גב תחתון, מתיחת שריר מותני, נקע מותני חריף, אישיאס, פריצת דיסק וכו'. 📖 כאב גב תחתון, מאמץ יתר של שרירי המותן, נקע חריף במותן, כאב עצב הסיאטיקה, בקע דיסק מותני	P1 P2
CA-8	**עצה / סקרום (Sacral)** 骶穴 Dǐ Xué	0.5 צון קדמית-עליונה לזווית הלסת התחתונה. 📖 חצי צון לפני ומעל לזווית הלסת התחתונה. (עמ' 43)	מתיחת השריר הזוקף (Erector spinae), כאב גב תחתון בנשים, פציעות ברצועות הכסל-עצה, הרטבת לילה, דלקת ערמונית וכו'. 📖 מאמץ יתר של שריר זוקף השדרה (骶棘肌), כאב גב תחתון על רקע גינקולוגי, פגיעה ברצועות העצה-כסל, הרטבת לילה, הפרעות בתפקוד המיני, דלקת הערמונית	P1 P2
CA-9	**כתף (Shoulder)** 肩穴 Jiān Xué	אמצע התפר הטמפורו-זיגומטי. 📖 בנקודת האמצע של התפר הרקתי-זיגומטי (顳顬縫). (עמ' 44)	כאב כתף, כתף קפואה, דלקת בגיד הדו-ראשי, סינוביטיס תת-אקרומיאלי, דלקת בגיד הסופרספינטוס וכו'. 📖 כאב כתף, דלקת פרק הכתף (כתף קפואה), דלקת גיד הראש הארוך של הדו-ראשי, דלקת בורסת תת-אקרומיון, דלקת גיד העל-קוצי, פגיעה בשרוול המסובבים, עוויית שריר הסטרנוקלידומסטואיד, פגיעה בשריר מרים השכמה	P1
CA-10	**מרפק (Elbow)** 肘穴 Zhǒu Xué	אמצע הקו המחבר בין זווית העין החיצונית לתחתית עצם הלחי. 📖 בנקודת האמצע של הקו המחבר בין הקצה החיצוני של העין לקצה התחתון ביותר של עצם הלחי. (עמ' 44)	כאב מרפק, מרפק טניס, מרפק גולף, דלקת בגידי פושטי ומכופפי שורש כף היד וכו'. 📖 כאב מרפק, מרפק טניסאים, מרפק גולפרים, דלקת הגיד המשותף של פושטי שורש כף היד, דלקת הגיד המשותף של מכופפי שורש כף היד, דלקת גיד התלת-ראשי	–
CA-11	**שורש כף יד (Wrist)** 腕穴 Wàn Xué	בקפל האף-שפה (Nasolabial fold), בקו האופקי של הקצה התחתון של הנחיר. 📖 במפגש של הקו האופקי היורד מהשוליים התחתונים של נקבובית האף עם חריץ האף-שפה. (עמ' 44)	כאב בשורש כף היד, פציעות במפרק, תסמונת התעלה הקרפלית, כאב באצבעות. 📖 כאב בשורש כף היד, נקע במפרק שורש כף היד, תסמונת התעלה הקרפלית, כאב באצבעות	–
CA-12	**כף יד (Hand)** 手穴 Shǒu Xué	אמצע הקו המחבר בין הקצה התחתון של הנחיר לגבול האדום של השפה העליונה. 📖 בנקודת האמצע של הקו המחבר בין נקודת האמצע של השוליים התחתונים של נקבובית האף לבין קו השפה העליונה. (עמ' 45)	דלקת פרקים באצבעות, דלקת בגידים, חוסר תחושה באצבעות או בכף היד. 📖 דלקת במפרקי האצבעות, דלקת בנדן הגיד, חוסר תחושה בקצות האצבעות, חוסר תחושה בכף היד	–
CA-13	**ירך (Hip)** 髋穴 Kuān Xué	1 צון קדמית-עליונה לזווית הלסת התחתונה, על בליטת שריר המלעס. 📖 בבליטה של שריר הלעיסה, צון אחד לפני ומעל לזווית הלסת התחתונה. (עמ' 45)	אישיאס, דלקת מפרקים ניוונית בירך, פציעה בשריר הפיריפורמיס, כאב במפשעה. 📖 כאב עצב הסיאטיקה, דלקת טראומטית במפרק הירך, פגיעה בשריר האגס (梨状肌), כאב במפשעה	P1 P2

קוד	שם הנקודה	מיקום	התוויות	בשימוש בדיווח
CA-14	**ברך (Knee)** 膝穴 Xī Xué	אמצע הקו המחבר בין זווית הלסת התחתונה לנקודת צ'נג-ג'יאנג (承浆 CV24). 📖 בנקודת האמצע של הקו המחבר בין זווית הלסת התחתונה לנקודת צ'נג-ג'יאנג (承浆, CV-24). (עמ' 45–46)	כאב ברך, כאב לאורך העצב הפרונאלי, דלקת מפרקים, פציעה בשרירי ההמסטרינג, התכווצות שריר התאומים (Gastrocnemius) וכו'. 📖 כאב במפרק הברך, כאב עצב הפרונאלי השטחי, דלקת מפרק הברך, פגיעה בשריר הפופליטאלי (腘肌), עווית שריר התאומים, דליות בגפה התחתונה, בצקת בגפה התחתונה	P1
CA-15	**קרסול (Ankle)** 踝穴 Huái Xué	בשליש הקרוב (לנקודת הברך) של הקו המחבר בין נקודת הברך (CA-14) לנקודת צ'נג-ג'יאנג (承浆 CV24). 📖 על הקו המחבר בין נקודת הברך (CA-14) לצ'נג-ג'יאנג (CV-24), בשליש הקרוב לקו האמצע של הגוף. (עמ' 46)	נקע בקרסול, נפיחות וכאב, דלקת מפרקים בקרסול, דלקת בגיד אכילס, כאב בעקב. 📖 נקע במפרק הקרסול, נפיחות וכאב, דלקת מפרק הקרסול, דלקת גיד אכילס, תסמונת כאב העקב	–
CA-16	**כף רגל (Foot)** 足穴 Zú Xué	0.5 צון לצד נקודת צ'נג-ג'יאנג (承浆 CV24). 📖 חצי צון לצד נקודת צ'נג-ג'יאנג (CV-24). (עמ' 46)	גאוט (שיגדון), מתיחת הפאשיה הפלנטרית, דורבן, כאב בעקב, כאב בבוהן. 📖 שיגדון (痛风), פגיעה בפאשיה הפלנטרית, כאב בכף הרגל, תסמונת כאב העקב, כאב בבוהן	P1

הערה: P1 – מטופל מס' 1; P2 – מטופל מס' 2 בדיווח. "–" = לא שימשה בדיווח.

5 בחירת נקודות ועקרונות טיפול

כיצד המחבר מצרף נקודות: עקרונות היישום, שמונה שיטות הצירוף, שלוש תקופות הכאב ושיטות הדיקור המיוחדות. לחצו על קוד נקודה כדי לפתוח אותה באטלס.

עקרונות יישום הנקודות 📖 עמ' 50–51

- 16 נקודות היסוד הן "נקודות מיקום" (定位穴) המתאימות למקום המחלה כ"נקודות מטרה" (靶点). במחלה פשוטה בדרך כלל די לבחור את הנקודה המתאימה למקום המחלה. 📖 עמ' 50
- בפועל, בחירת הנקודה משתנה לפי מוקד המחלה, הפתולוגיה ומנגנון המחלה (病机): "אין לפעול לגמרי לפי האיור, ויש להתאים את הטיפול לאדם ולמחלה". 📖 עמ' 50
- המחבר אינו ממליץ למתחילים לערבב כמה שיטות דיקור, עד ששולטים בכל אחת בנפרד. 📖 עמ' 50
- מחלות עמוד השדרה – נקודות עמוד השדרה; מחלות גפיים – מוסיפים נקודות גפיים; אם מחלת הגפה קשורה לעמוד השדרה – מטפלים קודם בעמוד השדרה ואחר כך בגפה. 📖 עמ' 51
  CA-5 CA-6 CA-7 CA-8
- ויסות המחמם המשולש הוא "יסוד היסודות" של השיטה: אם המחלה קשורה לרגש, מווסתים את המחמם המשולש ואת האיברים המתאימים. במחלות כרוניות, ובקשישים וחלשים, ברוב המקרים יש לווסת קודם את המחמם המשולש. 📖 עמ' 51
  CA-2 CA-3 CA-4
- התאמת עמוד השדרה למחמם המשולש: חוליות הצוואר – המחמם העליון; חוליות החזה – המחמם האמצעי; חוליות המותן והעצה – המחמם התחתון. 📖 עמ' 51
  CA-2 CA-3 CA-4 CA-5 CA-6 CA-7 CA-8
- מתחילים יכולים להתחיל בתרגול איתור במחלות עמוד שדרה כואבות פשוטות ובמישוש אזורי הנקודות בלחי; במחלות כרוניות ניתן בדרך כלל למצוא אזורים רגישים, ולעיתים הצד הנגדי רגיש אף יותר. 📖 עמ' 51

שמונה שיטות לצירוף נקודות 📖 עמ' 152–153

1. התאמה במיקום זהה
מחלה בכתף שמאל → נקודת הכתף בלחי השמאלית.
CA-9

2. התאמה שמאל-ימין
דיקור הצד הנגדי (מיאו-צ'י, 缪刺): כאב ראש בצד שמאל → נקודת הראש בלחי הימנית.
CA-1

3. התאמה קדימה-אחורה
לפי ההתאמה האנטומית בין קדימה לאחור: כאב גב תחתון → נקודת המחמם התחתון.
CA-4 CA-7

4. התאמה מוצלבת
לפי עקרון הדמיון ההולוגרפי: כאב במפרק הירך השמאלי → נקודת הכתף הימנית.
CA-9 CA-13

5. התאמה עליון-תחתון
לפי הקשר בין שני הקטבים ההולוגרפיים: כאב ראש → נקודת העצה.
CA-1 CA-8

6. התאמה קשורה
לפי הרציפות האנטומית: דליות ברגליים → נקודות הירך, הברך והקרסול.
CA-13 CA-14 CA-15

7. התאמה לפי יעילות המחט
מחט אחת לנקודה, מספר מחטים לאזור נקודה אחד, או מספר נקודות למחלה אחת – הקריטריון הוא הגעת הצ'י והיעילות.

8. התאמה משולבת
שילוב עם מערכות מיקרו-דיקור אחרות ועם דיקור ומוקסה מסורתיים להגברת היעילות.

שלוש תקופות הכאב ועקרונות הטיפול 📖 עמ' 153–154

המחבר מחלק כאב חריף וכרוני מפגיעה ברקמות רכות (ברובד ההולוגרפי) לשלוש תקופות, לכל אחת מנגנון ועיקרון טיפול:

תקופה	מנגנון	מאפיינים	עיקרון טיפול	לפי הספר
תקופה ראשונה	סטגנציה (滞/瘀) – "סטגנציה מולידה כאב, ואם יש זרימה – אין כאב"	כאב המתחזק ונחלש לסירוגין, מושפע ממזג אוויר ומאמץ, מיקום לא קבוע, כבדות ועייפות והתקררות מקומית.	הרגעת המרידיאנים ופתיחתם, הנעת הצ'י והסרת הסטגנציה.	בדרך כלל השפעה מיידית על התסמינים.
תקופה שנייה	עווית – "התכווצות מחריפה את הכאב, והרפיה מפיגה אותו"	כאב חריף ומתמשך, ליקוי תנועה בולט; מעגל "עווית מגבירה כאב, וכאב מגביר עווית".	הרפיית העווית והסרתה, הפגת הכאב.	השפעה מסוימת; יש לדייק בנקודת היעד, לקבוע במישוש את היקף העווית, ובמידת הצורך להגדיל את מספר המחטים.
תקופה שלישית	קשר (结) – "קשר מביא לגוש וכאב, ופיזור מסיר את הכאב"	כאב עקשן ומתמשך לאחר פגיעות חוזרות ועומס כרוני: התכווצות, הידבקות וצלקת.	פירוק הקשר והפגת הכאב.	השפעה מיידית אך נדרשים טיפולים חוזרים; לעיתים יש לשלב אבחון בטן ולהסיר את הקשרים בבטן.

שיטות דיקור מיוחדות 📖 עמ' 151

- האבחון קודם: על בסיסו נוצר טיפול ב"נקודת יעד" (靶点); הנקודה מובנת כאזור, ומספר המחטים נקבע לפי גודל המוקד והיקפו.
- מכיוון שהשיטה מושתתת על "תחושת מחט סמויה", משתמשים באותו אזור נקודה בכמה מחטים לחיזוק האפקט: הנפוצות הן דיקור כפול ודיקור משולש (איור 1-2-8); במקרים מיוחדים – דיקור מעוין, פרח שזיף, שורה אחת או שתי שורות – בעיקר בחומרה פתולוגית גבוהה, מחלה ממושכת ומוקד נרחב.
- לאחר הדיקור מכוונים ומוסיפים מחטים לפי התגובה.
- עומק: לפי מיקום המחלה – מחלה קלה: שטחי, מחלה קשה: עמוק, בשילוב אבחון הבטן.
- סדר: קודם הזאנג-פו ואחר כך הגפיים. במחלה מקומית – הצד הנגוע; במחלה כללית – המחמם המשולש בשני הצדדים, ומחזקים במיוחד את המקומות שבהם הצ'י "נקשר".
- מטפלים מנוסים יכולים להפעיל טכניקות להתאמת הרוח והובלת הצ'י, "אך יש להקפיד שלא להרבות בהרמה, בהחדרה ובסיבוב".

עקרונות הטיפול 📖 עמ' 149–151

עיקר השימוש במחט – התאמת הצ'י
מתאימים את מנגנון הצ'י המקומי והכללי: לצ'י המגן – דיקור שטחי; לצ'י המזין – דיקור עמוק; לצ'י המקורי – התאמת המחמם המשולש.

כל דיקור אמיתי מתחיל בוויסות הרוח
ויסות הרוח (神) אינו רק התאמת רוח הלב אלא של חמש רוחות האיברים; לדברי המחבר, "הרוח המתוקנת מביאה לכך שחמשת איברי הזאנג כולם שלווים".

6 אבחון: אבחון שרירים ואבחון בטן

בדיקור הלחי האבחון קודם לטיפול ומשמש גם לבדיקה חוזרת לאחר הדיקור. הסעיף מסכם את פרק 7 בספר – מבחני השרירים המפורטים (עמ' 106–139) נמצאים בספר המקור.

אבחון שרירים – הבסיס לרובד ההולוגרפי

📖 עמ' 105–106

אבחון השרירים הוא "היעד החשוב ביותר ברובד ההולוגרפי": רק אבחון נכון מאפשר לבחור את נקודת היעד, והטיפול הוא גם מבחן לאבחון – אם התוצאה אינה טובה, ייתכן שיש לתקן את האבחון. הספר מפרט לכל קבוצת שרירים את השרירים, העצבוב, המוצא, ההיצמדות והתפקוד.

שרירי הצוואר — 📖 עמ' 106
CA-5

שרירי החזה והבטן — 📖 עמ' 109
CA-4 · CA-3 · CA-2

שרירי הכתף והזרוע — 📖 עמ' 111
CA-9

שרירי האמה הקדמיים — 📖 עמ' 114
CA-11 · CA-10

שרירי האמה האחוריים — 📖 עמ' 117
CA-11 · CA-10

שרירי כף היד — 📖 עמ' 120
CA-12

שרירי המותן והגב — 📖 עמ' 121
CA-7 · CA-6

שרירי הישבן — 📖 עמ' 125
CA-13 · CA-8

שרירי הירך — 📖 עמ' 128
CA-14 · CA-13

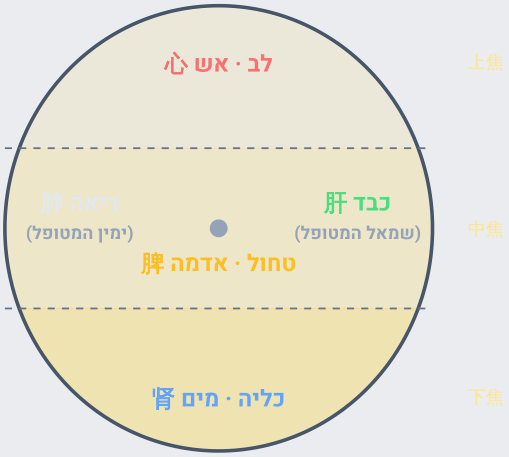
שרירי השוק — 📖 עמ' 134
CA-15 · CA-14

שרירי כף הרגל — 📖 עמ' 137
CA-16 · CA-15

שיוך קבוצות השרירים לנקודות הוא לפי האזור ההולוגרפי בטבלת הנקודות (עמ' 47–48), ולא מופיע בספר כטבלה נפרדת.

מפת הבטן: חמשת הזאנג והמחמם המשולש

📖 איורים 2-2-7, 3-2-7 · עמ' 142–143



מבט מלפנים על המטופל · מיקום תפקודי ולא אנטומי

מיקום מושגי-תפקודי (לא אנטומי) של חמשת הזאנג בבטן: כבד-עץ משמאל, ריאה-מתכת מימין, לב-אש למעלה, כליה-מים למטה, טחול-אדמה במרכז – יחד הם יוצרים את "מחזור הצ'י האחד".

חלוקת הבטן למחמם המשולש: המחמם העליון – למעלה; המחמם האמצעי – באזור הטבור; המחמם התחתון – למטה. CA-2 · CA-3 · CA-4

אבחון הבטן בדיקור הלחי 📖 עמ' 140–148

לפי המחבר, אבחון הבטן הוא "בסיס שיפוט עצמאי וחשוב": הוא אובייקטיבי יחסית, מגביר את השתתפות המטופל ונותן משוב בזמן אמת. "לרוב המחלות הכרוניות יש בבטן נקודת קשר צ'י מקבילה" – גוש קשה, נקודה כואבת או "גוש צ'י" (气团).

① הציר המרכזי והערכת הצ'י המקורי

הציר המרכזי חשוב להערכת הצ'י המקורי: מגששים באצבעות צמודות לפי הסדר ג'יו-וויי (CV-15 鸠尾), ג'ונג-ואן (CV-12 中脘), שן-צ'ואה (CV-8 神阙), צ'י-האי (CV-6 气海) וגואן-יואן (CV-4 关元). לחיצה ללא מכשול, נשימה נענית ועור ובשר המתרוממים בכוח עמום – סימן לשפע הצ'י המקורי; רכות ללא כוח – סימן להתדלדלות. 📖 עמ' 144

② סדר הבדיקה ושיטת המישוש

סדר הבדיקה: תחילה חוסר ועודף (虚实), אחר כך הבחנה בחומרה, ושלישית איתור מקום הקשר של ה"פי". 📖 עמ' 145

בתחילת הבדיקה לוחצים בכוח שלם כדי לחפש נקודות קשר, ולא רק באזור מקומי: שתי הידיים על הבטן כולה, מקל לכבד, לפי שכבות ועומק; לאחר הדיקור בודקים שוב, ובסוף מתקנים ומשחררים את הנקודות בדיקור. 📖 עמ' 147

③ שמונת הממצאים בבטן

מלאות (满)	תחושה סובייקטיבית של מלאות/התנפחות; בלחיצה – התנגדות קלה.
פי (痞)	"מלאות ללא כאב"; חסימה וסטגנציה של צ'י; התנגדות גדולה מזו של מלאות.
התנפחות (胀)	סימן אובייקטיבי – בליטה נראית לעין של הבטן.
קשיחות (硬)	התנגדות וקשיחות ברורות – כעץ או כאבן; לרוב גורמים עודפים (דם סטגנטי, מים, יציאות יבשות, גושים).
תמיכה (支)	תחושת התנגדות.
קשר (结)	גוש בלחיצה; תחושת חסימה שאינה ניתנת להזזה.
דחיפות (急)	מתח; מתחת ללב – רצון להקיא, באמצע הבטן – להתפנות, בבטן התחתונה – להשתין.
כאב (痛)	התנגדות ללחיצה מעידה בדרך כלל על עודף, והעדפת לחיצה – על חוסר.

📖 עמ' 145

④ דרישות ביצוע

1. סביבה שקטה, טמפרטורה מתאימה, מיטה נוחה ותאורה מספקת.
2. בבדיקת בן המין השני – במדינות מסוימות נדרשת נוכחות אחות.
3. המטופל שוכב שטוח ושקט ומתיר את החגורה; שואלים על צום/ארוחה, יציאות ושתן; מבקשים להתרוקן אם יש דחיפות; מאפשרים מנוחה אם הגיע מתוח או לאחר הליכה.
4. ידיים נקיות וחמימות; להניח קודם את כף היד בעדינות ולהחליק בהדרגה – לא ללחוץ לפתע.
5. לא לבצע כשיש פגיעה בעור המקומי; בנשים הרות להימנע ככל האפשר, ובמיוחד לא ללחוץ על מקום העובר.

📖 עמ' 147–148

7 פרוטוקולים קליניים

סיכומי הפרוטוקולים מהאטלס

פרוטוקול קליני מלא פעיל

פרוטוקול קליני: בעיות צוואר, שכמות והקרנה לכתף

מתמקד בנקודות האדומות בקדמת האוזן (CA-5, CA-6), בנקודה הירוקה על קשת הזיגומה (CA-9) ובנקודה הסגולה ברקה (CA-1).

📍 סדר בחירת הנקודות המדויק:
1. CA-5 (צוואר - אדום) + CA-6 (גב עליון - אדום) [ליבה] | 2. תוספת CA-9 (כתף - ירוק) בהקרנה ליד | 3. תוספת CA-1 (ראש - סגול) בסחרחורת או מתח.

⚖️ צד הדיקור (חד-צדדי מול דו-צדדי):
בכאב צוואר חד-צדדי – דוקרים רק בלחי של אותו הצד. בנוקשות צוואר מרכזית – דוקרים דו-צדדית.

✅ בדיקת אימות מיידית (אבחנת בטן/תנועה):
בדיקה דינמית בתנועה: מבקשים מהמטופל לסובב את הצוואר מיד לאחר החדרת המחטים ל-CA-5 ו-CA-6.

פרוטוקול קליני מלא פעיל

🌸 פרוטוקול קליני מלא: כאבי מחזור (דיסמנוריאה) וכאב שחלתי

מבוסס על הנקודה הצהובה התחתונה בגבול הקדמי של המלעס (CA-4) והנקודות האדומות בגבול האחורי של המלעס (CA-8, CA-7) בשילוב אבחנת בטן.

📍 סדר בחירת הנקודות המדויק:
1. מחט ראשונה: CA-4 (מחמם תחתון - צהוב תחתון) | 2. מחט שנייה (להקרנה לאגן): CA-8 (סקרום - אדום תחתון) | 3. לכאב גב תחתון: CA-7 (מותן - אדום) | 4. לבחילות/נפיחות/PMS: CA-3 (מחמם אמצעי - צהוב אמצעי).

⚖️ צד הדיקור (חד-צדדי מול דו-צדדי):
אם רק שחלה אחת כואבת/רגישה בבטן (למשל שמאל) – דוקרים בלחי שמאל בלבד! אם הכאב במרכז הרחם – דוקרים דו-צדדית.

✅ בדיקת אימות מיידית (אבחנת בטן/תנועה):
אבחנת בטן: לוחצים על מוקד הכאב בבטן התחתונה לפני הדיקור, מחדירים את CA-4, ולוחצים שוב על הבטן – הרגישות צריכה לצנוח מיד.

פרוטוקול קליני מלא פעיל

🤱 פרוטוקול קליני מלא: פריון ואיזון ציר הורמונלי (HPO Axis)

טיפול מערכתי המשלב את הנקודה הסגולה ברקה (CA-1), שלוש הנקודות הצהובות של המחממים (CA-2, CA-3, CA-4) ונקודות האגן האדומות (CA-8, CA-7).

📍 סדר בחירת הנקודות המדויק:
1. ליבת רבייה: CA-4 (מחמם תחתון - צהוב) + CA-8 (סקרום - אדום) | 2. ציר מוח-הורמונים והרגעת Shen: CA-1 (ראש - סגול) + CA-2 (מחמם עליון - צהוב) | 3. ויסות צ'י הכבד והעיכול: CA-3 (מחמם אמצעי - צהוב) + CA-7 (מותן - אדום).

⚖️ צד הדיקור (חד-צדדי מול דו-צדדי):
בפריון נהוג לדקור דו-צדדית (בשתי הלחיים) לאיזון מערכתי מלא של ציר ההורמונים וזרימת הדם לאגן.

✅ בדיקת אימות מיידית (אבחנת בטן/תנועה):
מישוש השוואתי של מתח דופן הבטן סביב הטבור ובבטן התחתונה (CV4/CV6/ST29) לפני ואחרי החדרת מחטי הגבול הקדמי של המלעס.

⚠️ **הערת מקור:** שני הפרוטוקולים המלאים שלהלן (כאבי מחזור ופריון) אינם מופיעים בספר המקור של וואנג יונגז'ואו, ומקורם אינו מצוין באתר. הספר אינו מציג פרוטוקולים קבועים אלא עקרונות לבחירת נקודות (חלק 5) ו-101 מקרים מתועדים (חלק 8), ומדגיש שהמקרים "אינם מרשם תקני". הספר מונה הריון – במיוחד לאחר הפריה מלאכותית – בין התוויות הנגד (עמ' 156). ראו פירוט הפערים

פרוטוקול קליני מלא #1

פרוטוקול קליני מלא #2

🤱 פרוטוקול מלא לפריון ואיזון ציר הורמונלי (HPO Axis)

⚠️ לבדיקה: השלב "יום החזרת עוברים" בפרוטוקול זה עומד בסתירה לספר המקור, המונה הריון בעקבות הפריה מלאכותית בין התוויות הנגד (עמ' 156) ואינו ממליץ על דיקור הלחי בהריון (עמ' 190).

🌸 פרוטוקול מלא לכאבי מחזור (דיסמנוריאה) וכאב שחלתי

1. **שלב 1 – אבחנת בטן (Abdominal Palpation):** המטופלת שוכבת על הגב. ממששים את הבטן התחתונה (מתחת לטבור: אזור CV4/CV6 באמצע, ואזור השחלות ST28/ST29/Zigong משמאל ומימין). מזהים באיזה צד יש רגישות, נוקשות או כאב חד יותר.

2. **שלב 2 – מחט ליבה ראשונה (CA-4 מחמם תחתון):** מבקשים מהמטופלת להדק שיניים, מאתרים את הנקודה הצהובה התחתונה בגבול הקדמי-תחתון של שריר המלעס (Masseter) בגובה קו הפה התחתון. אם הכאב רק בשחלה השמאלית – דוקרים ב**לחי שמאל בלבד**. אם הכאב במרכז הרחם או דו-צדדי – דוקרים בשתי הלחיים.

3. **שלב 3 – בדיקת אימות מיידית:** לוחצים שוב על הבטן התחתונה. ב-80% מהמקרים הכאב יורד מיד.

4. **שלב 4 – מחט שנייה ושלישית לפי הקרנת הכאב:**
   - אם נשאר כאב שמקרין לאגן או לעצם הזנב: מוסיפים **CA-8 (סקרום)** בגבול האחורי-תחתון של שריר המלעס (ליד זווית הלסת).
   - אם יש כאב גב תחתון נלווה לווסת: מוסיפים **CA-7 (מותן)** מתחת לתנוך האוזן על השפה האחורית של הלסת.
   - אם יש בחילות, נפיחות בטנית או גודש בחזה (PMS): מוסיפים **CA-3 (מחמם אמצעי)** בנקודה הצהובה האמצעית.

5. **מפרט טכני ותזמון:** מחט 0.16×13 או 0.18×13 מ"מ, עומק 3–5 מ"מ, שהייה של 30–45 דקות. מומלץ לטפל 3–5 ימים לפני הווסת וכן ביום הראשון של הווסת.

1. **עיקרון הטיפול בפריון:** בניגוד לכאב חד-צדדי חריף, בטיפולי פריון המטרה היא מערכתית – ויסות ציר מוח-היפופיזה-שחלות (HPO), הרגעת מערכת העצבים הסימפתטית (הורדת קורטיזול וסטרס), ושיפור זרימת הדם העורקית לרחם ולשחלות.

2. **קבוצה א' – ויסות שלושת המחממים (3 הנקודות הצהובות - San Jiao):**
   - **CA-4 (מחמם תחתון - דו-צדדי):** נקודת המאסטר לחיזוק הכליות, השחלות והרחם.
   - **CA-3 (מחמם אמצעי) + CA-2 (מחמם עליון):** לפתיחת תקיעות צ'י הכבד וחיבור ציר הלב-רחם (*Bao Mai*). ניתן לדקור דו-צדדית או בשיטת "שמאל עולה - ימין יורד".

3. **קבוצה ב' – ויסות מוחי והורדת סטרס (CA-1 ראש):** הנקודה הסגולה הגדולה על שריר הרקה (דו-צדדית). מרגיעה את ה-Shen ומאזנת הפרשת GnRH/FSH/LH.

4. **קבוצה ג' – הזרמת דם לאגן (CA-8 סקרום + CA-7 מותן):** מעוררות את העצבוב הפאראסימפתטי של האגן לעיבוי רירית הרחם ושיפור תגובת השחלות.

5. **התאמה לשלבי החודש / IVF:** בשלב הפוליקולרי (לפני ביוץ/שאיבה) דגש על CA-4 + CA-8 + CA-1. ביום החזרת עוברים (Embryo Transfer): CA-1 + CA-2 + CA-4 להרפיית התכווצויות רחם והרגעה עמוקה.

8 מאגר המקרים הקליניים מהספר

המקרים בפרק 11 טופלו בקליניקה של המחבר בפריז בשנים 2015–2016 בדיקור הלחי בלבד. המחבר מדגיש שהם "חומר עזר ללימוד הראשוני... ואינם מרשם תקני", שבחר במקרים פשוטים יחסית, שבמטופלים עם שינוי אורגני השתמש במונח "הקלה קלינית", ושאין לעקוב אחר התמונות צעד אחר צעד – בחירת הנקודות מתבססת תמיד על איתור מתוקנן לפי סימני עצם (פרק 3). 📖 עמ' 204

הטקסט מובא כלשונו מהתרגום. תגיות הנקודות זוהו אוטומטית מתוך משפטי הטיפול – "נקודות המחמם המשולש" מסומנות כ-CA-2 עד CA-4; נקודות שהספר מתאר מחוץ ל-16 אזורי היסוד (למשל "נקודות השוק") אינן מסומנות.

כאב ראש מתחי

הרובד ההולוגרפי · הראש

אבחנה: כאב ראש מתחי

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות המחמם המשולש ונקודות הראש; לאחר טיפול אחד הכאב פחת, בשבוע היה רק התקף אחד, ולאחר שני טיפולים נוספים ההתקפים פסקו; המשכנו בחיזוק הטיפול חמש פעמים נוספות, ולאחר שהתסמינים בבטן ובצוואר חלפו כליל הסתיים הטיפול – הקלה קלינית.

CA-1 CA-2 CA-3 CA-4

תיאור המקרה המלא

גבר, בן 26, סובל כבר עשר שנים ממיגרנה בצד שמאל, וכיום יש לו התקפים פעמיים בשבוע, שנמשכים יום עד יומיים, ובמשך זמן רב הוא זקוק למשככי כאב להקלה, אך האפקט אינו מתמשך; הוא מקווה שהדיקור והמוקסה יוכלו לסייע במצבו. בבדיקה: רגישות ללחץ בצוואר העליון, מעט חזקה יותר בצד שמאל, מלאות ומתיחות בבטן; מלבד לחצי העבודה והחיים הרגילים, אין היסטוריה מיוחדת בזיכרון. אבחנה: כאב ראש מתחי. נבחרו נקודות המחמם המשולש ונקודות הראש; לאחר טיפול אחד הכאב פחת, בשבוע היה רק התקף אחד, ולאחר שני טיפולים נוספים ההתקפים פסקו; המשכנו בחיזוק הטיפול חמש פעמים נוספות, ולאחר שהתסמינים בבטן ובצוואר חלפו כליל הסתיים הטיפול – הקלה קלינית.

📖 איור 1-1-1-11 · עמ' 204

סינוסיטיס כרונית

הרובד ההולוגרפי · הראש

אבחנה: סינוסיטיס כרונית

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות המחמם המשולש בשני הצדדים ונקודות הראש, פעם בשבוע;

CA-1 CA-2 CA-3 CA-4

תיאור המקרה המלא

גבר, בן 55, סובל כבר עשר שנים מכאב ראש חוזר באזור המצח, בליווי גודש באף ונזלת. אבחנה: סינוסיטיס כרונית. נבחרו נקודות המחמם המשולש בשני הצדדים ונקודות הראש, פעם בשבוע; לאחר שלושה טיפולים הכאב החל לפחת, ואחר כך עברו לטיפול אחת לשבועיים-שלושה, בסך הכול שנים-עשר טיפולים, כאב הראש נעלם לחלוטין – החלמה קלינית.

📖 איור 2-1-1-11 · עמ' 205

מיגרנה

הרובד ההולוגרפי · הראש

אבחנה: מיגרנה

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות המחמם המשולש ונקודות הצוואר;

CA-2 CA-3 CA-4 CA-5

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 44, סובלת כבר 25 שנה, מאז אירוע משפחתי, ממיגרנה בצד ימין, שמופיעה כמעט מדי יום. בבדיקה: רגישות ללחץ בצוואר, ובצד ימין של הבטן רגישות כזו שהיא אינה מרשה ללחוץ. אבחנה: מיגרנה. נבחרו נקודות המחמם המשולש ונקודות הצוואר; לאחר הטיפול כאב הבטן פחת וגם כאב הראש הוקל; טיפול אחת לשבועיים-שלושה, בסך הכול שנים-עשר טיפולים, כאב הראש מופיע רק לעתים נדירות, והיא כבר אינה חוששת מכאב ראש, ומצמצמת כעת את נטילת התרופות נגד דיכאון – הקלה קלינית של כאב הראש.

📖 איור 3-1-1-11 · עמ' 206

נוירלגיה של העצב העורפי הגדול

הרובד ההולוגרפי · הראש

אבחנה: נוירלגיה של העצב העורפי הגדול בצד שמאל

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות הצוואר, ועוד מחט מחזקת אחת;

CA-5

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 72, סובלת שבועיים מכאב דוקר בצד ימין של העורף, שמחריף בלילה בשעת השינה עד כדי חוסר יכולת להירדם, ולכן פנתה לטיפול. שנה קודם לכן היא טופלה אצלי והחלימה מהרפס זוסטר בצד ימין של הפנים; מפני שאזור הכאב התחלתי היה אז זהה, היא הייתה מתוחה במיוחד, ולכן הרגעתי אותה תחילה והסברתי שהרפס זוסטר הוא מחלה חיסונית מוגבלת מאליה, ושההסתברות לחזרתה בדרך כלל קטנה, כדי להסיר את החשש. בהתאם למיקום הכאב, בבדיקה: רגישות ללחץ ניכרת באזור צוואר 1–2. אבחנה: נוירלגיה של העצב העורפי הגדול בצד שמאל. נבחרו נקודות הצוואר, ועוד מחט מחזקת אחת; הרגישות ללחץ בצוואר וכאב הראש נעלמו, המחטים נשארו 50 דקות, ובמהלכן המטופלת ישנה שנת קצרה, ובעת ההליכה כבר לא הייתה אי-נוחות. לאחר הטיפול סיפרה המטופלת שהתקוטטה עם בתה ושהיא "נפגעה מאוד"; טיפלנו עוד פעמיים, בעיקר נגד לחץ וחרדה – החלמה קלינית.

📖 איור 4-1-1-11 · עמ' 206

פגיעת שוט בצוואר

הרובד ההולוגרפי · הצוואר

אבחנה: פגיעת שוט בצוואר

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות הצוואר וחוזקו;

CA-5

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 31, סובלת חודש וחצי מכאב צוואר שנגרם מתאונת דרכים; יש כאב בסיבוב הראש ובהטיה קדימה ואחורה, ורגישות ללחץ לצד ימין של עמוד השדרה בין C5 ל-T1. אבחנה: פגיעת שוט בצוואר. נבחרו נקודות הצוואר וחוזקו; לאחר הדקירה הכאב פחת, המחטים נשארו 20 דקות, הכאב נעלם בעיקרו, ולאחר שבוע נערך עוד חיזוק של שלושה טיפולים, הכאב חלף – החלמה קלינית.

📖 איור 11-1-2-1 · עמ' 207

פגיעה חיצונית בכתף בשילוב כאב בצוואר ובמרפק

הרובד ההולוגרפי · הצוואר

אבחנה: פגיעה חיצונית בכתף בשילוב כאב בצוואר ובמרפק

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות הצוואר, הכתף והמרפק בצד שמאל; נוספה מחט מחזקת אחת בנקודות המרפק והצוואר, והכאב נעלם בעיקרו.

CA-5 CA-9 CA-10

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 52, סובלת יותר מחודשיים מכאב בכתף שמאל; לפני חודשיים נפלה בטעות ונחתה על הכתף השמאלית, מה שגרם לכאב כתף שמקרין לצוואר ולמרפק, עם הגבלה בהרמת הכתף ובתפקוד הגב, והכאב מחריף במיוחד בעת הרמה והנחה של חפצים. בבדיקה: רגישות ללחץ בגיד הראש הקצר של שריר הדו-ראשי ובאפיקונדילוס הצדדי של עצם הזרוע, וברגישות ללחץ בצד החיצוני-אחורי של הצוואר השמאלי. אבחנה: פגיעה חיצונית בכתף בשילוב כאב בצוואר ובמרפק. נבחרו נקודות הצוואר, הכתף והמרפק בצד שמאל; לאחר הדקירה הכאב פחת, ובעת הרמת חפץ כבד נותר כאב במרפק שמקרין כלפי מעלה לצוואר; נוספה מחט מחזקת אחת בנקודות המרפק והצוואר, והכאב נעלם בעיקרו. כעבור שבוע הגיעה לטיפול נוסף, הטיפול כמקודם – החלמה קלינית.

📖 איור 11-1-2-2 · עמ' 208

עייפות יתר של שרירי הצוואר ושל שריר הטרפז

הרובד ההולוגרפי · הצוואר

אבחנה: עייפות יתר של שרירי הצוואר ושל שריר הטרפז

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות הגב, הצוואר והכתף, המחטים נשארו 30 דקות, העווית בשריר שוחררה והכאב פחת;

CA-5 CA-6 CA-9

תיאור המקרה המלא

גבר, בן 59, סובל חצי שנה מכאב בצוואר ובכתף ימין; המטופל עובד 40 שנה כספר, ובשנים האחרונות הכאב חוזר ומופיע, ובגופו כבר נוצרה גבנת בולטת. בבדיקה: שרירי הצוואר מתוחים וקשים, ובצרור העליון של שריר הטרפז יש עווית. אבחנה: עייפות יתר של שרירי הצוואר ושל שריר הטרפז. נבחרו נקודות הגב, הצוואר והכתף, המחטים נשארו 30 דקות, העווית בשריר שוחררה והכאב פחת; בסך הכול נערכו חמישה טיפולים, אחת לשבועיים – הקלה קלינית.

📖 איור 11-1-2-3 · עמ' 208

כאב צוואר

הרובד ההולוגרפי · הצוואר

אבחנה: כאב צוואר

טיפול ותוצאה: נדקרו נקודות הצוואר ונקודות הגב בשני הצדדים, והרגישות ללחץ פחתה; אחר כך נוספו שתי מחטים מחזקות מתחת לנקודות הצוואר ולפני נקודות הגב, והרגישות ללחץ חלפה לחלוטין, הסיבוב לימין ולשמאל חופשי, ואין עוד תחושת כאב; כעבור שבוע טופלה פעם נוספת – החלמה קלינית.

CA-5 CA-6

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 33, סובלת חודש מכאב צוואר וקושי בתנועה לימין ולשמאל. בבדיקה: רגישות ללחץ מצוואר 2 עד 6, ושרירי הצוואר ושריר הטרפז מתוחים. אבחנה: כאב צוואר. נדקרו נקודות הצוואר ונקודות הגב בשני הצדדים, והרגישות ללחץ פחתה; אחר כך נוספו שתי מחטים מחזקות מתחת לנקודות הצוואר ולפני נקודות הגב, והרגישות ללחץ חלפה לחלוטין, הסיבוב לימין ולשמאל חופשי, ואין עוד תחושת כאב; כעבור שבוע טופלה פעם נוספת – החלמה קלינית.

📖 איור 11-1-2-4 · עמ' 208

כאב כתף ממקור צווארי

הרובד ההולוגרפי · הצוואר

אבחנה: כאב כתף ממקור צווארי בצד ימין

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות הצוואר והכתף בצד ימין, וכל אחת מהן חוזקה;

CA-5 CA-9

תיאור המקרה המלא

גבר, בן 58, סובל כמעט חודשיים מכאב בכתף ימין עם הגבלה בתנועה. בבדיקה: רגישות ללחץ ניכרת בצוואר בגובה C3–6, רגישות ללחץ בכל היקף הכתף, הרמה צידית ל-30° והרמה קדימה ל-60°. אבחנה: כאב כתף ממקור צווארי בצד ימין. נבחרו נקודות הצוואר והכתף בצד ימין, וכל אחת מהן חוזקה; לאחר הטיפול ההרמה קדימה הגיעה ל-170° וההרמה הצידית ל-150°, והכאב פחת בצורה ניכרת. טיפלנו עוד שלוש פעמים, אחת לעשרה ימים – החלמה קלינית.

📖 איור 11-1-2-5 · עמ' 210

תסמונת מרובת-שורשים בצוואר ובזרוע

הרובד ההולוגרפי · הצוואר

אבחנה: תסמונת מרובת-שורשים בצוואר ובזרוע בצד ימין

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות הצוואר, הכתף והמרפק, וחוזקו; נערך חיזוק של ארבעה טיפולים נוספים, אחד בשבוע, והקליק במפרק הכתף נעלם גם הוא – החלמה קלינית.

CA-5 CA-9 CA-10

תיאור המקרה המלא

גבר, בן 42, כנר, סובל חודשיים מכאב בכתף ובמרפק ימין, שגרם לנוקשות בשורש כף היד ולעתים לתחושת נימול בקצות האצבעות, ובסיבוב אחורי-חיצוני נשמע קליק במפרק הכתף, מה שמפריע להופעותיו. בבדיקה: רגישות ללחץ בצוואר ימין, בעיקר ב-C5, C6, C7, רגישות ללחץ בראש הארוך של שריר הדו-ראשי בבליטת הקורקואיד של הכתף, רגישות ללחץ באפיקונדילוס הצדדי של עצם הזרוע במרפק, ומתיחות בקבוצת שרירי המיישרים של האמה. אבחנה: תסמונת מרובת-שורשים בצוואר ובזרוע בצד ימין. נבחרו נקודות הצוואר, הכתף והמרפק, וחוזקו; לאחר החדרת המחט הוזזה המחט קלות, וכשהרגישות ללחץ בכל האזורים נעלמה המחטים נשארו 30 דקות, ובעת הוצאת המחטים כאב הכתף והמרפק בצד ימין נעלם ושורש כף היד נעשה גמיש. נערך חיזוק של ארבעה טיפולים נוספים, אחד בשבוע, והקליק במפרק הכתף נעלם גם הוא – החלמה קלינית.

📖 איור 11-1-2-6 · עמ' 210

פיברומיאלגיה של הצוואר, הגב והמותן

הרובד ההולוגרפי · הגב

אבחנה: פיברומיאלגיה של הצוואר, הגב והמותן

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות הצוואר, הגב, המותן, העצה והירך, וחוזקו לפני נקודות הצוואר; נערך חיזוק של שלושה טיפולים נוספים – החלמה קלינית.

CA-5 CA-6 CA-7 CA-8 CA-13

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 42, סובלת מכאב בישבן שמאל שמקרין דרך המותן והגב כלפי מעלה לצוואר ולכתף, בליווי עוויתות שרירים. בבדיקה: רגישות ללחץ בישבן שמאל (+++), ובצומת הצוואר-כתף שמאל (++). אבחנה: פיברומיאלגיה של הצוואר, הגב והמותן. נבחרו נקודות הצוואר, הגב, המותן, העצה והירך, וחוזקו לפני נקודות הצוואר; לאחר הדקירה הרגישות ללחץ נעלמה והעווית בשריר שוחררה. נערך חיזוק של שלושה טיפולים נוספים – החלמה קלינית.

📖 איור 11-1-3-1 · עמ' 210

כאב בשרירים לצד חוליות הצוואר והחזה

הרובד ההולוגרפי · הגב

אבחנה: כאב בשרירים לצד חוליות הצוואר והחזה

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות הצוואר והגב, וחוזקו בשלוש מחטים; הרגישות ללחץ בצוואר הוקלה, המחטים נשארו 30 דקות, לאחר הוצאת המחטים תנועת הצוואר הייתה חופשית, וכעבור שבוע טופל פעם נוספת – החלמה קלינית.

CA-5 CA-6

תיאור המקרה המלא

גבר, בן 42, סובל חודש מכאב צוואר שחודר עד הגב, עם הגבלה בהטיה קדימה ואחורה ובסיבוב; לאחר שני טיפולים אצל כירופרקט האפקט נשמר יומיים והכאב חזר כמקודם. בבדיקה: רגישות ללחץ ניכרת בצוואר בגובה C2–5, ושרירי עמוד השדרה בגב מתוחים ומושכים כלפי מטה החוליות התחתונות של עמוד השדרה החזי. אבחנה: כאב בשרירים לצד חוליות הצוואר והחזה. נבחרו נקודות הצוואר והגב, וחוזקו בשלוש מחטים; הרגישות ללחץ בצוואר הוקלה, המחטים נשארו 30 דקות, לאחר הוצאת המחטים תנועת הצוואר הייתה חופשית, וכעבור שבוע טופל פעם נוספת – החלמה קלינית.

📖 איור 11-1-3-2 · עמ' 210

פיברומיאלגיה כרונית

הרובד ההולוגרפי · הגב

אבחנה: פיברומיאלגיה כרונית

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות המחמם המשולש, הצוואר והגב בשני הצדדים;

CA-2 CA-3 CA-4 CA-5 CA-6

תיאור המקרה המלא

גבר, בן 43, סובל יותר משנה מכאב בצוואר ובגב, ועיסויים תכופים לא הקלו; המטופל עובד בלחץ, בעצימות גבוהה מאוד, ומרגיש לעתים קרובות חרדה. בבדיקה: מלאות בבטן ותחושת התנגדות חזקה. אבחנה: פיברומיאלגיה כרונית. נבחרו נקודות המחמם המשולש, הצוואר והגב בשני הצדדים; לאחר הטיפול כאב הצוואר והגב שוחרר, בסך הכול נערכו שישה טיפולים, ובמקביל הומלץ לו על טיפול בהיפנוזה, ובעקבותיו התגלו כמה גורמים טראומטיים נפשיים מהעבר שהיו הגורם המעורר. לאחר מכן האפקט של הדיקור נשמר זמן ארוך יחסית, והמתח והחרדה הוקלו אף הם בצורה ניכרת. מחלה זו שכיחה מאוד באירופה וקשה מאוד לרפא אותה לחלוטין, ויש לשים לב במיוחד להשפעת הגורמים הנפשיים עליה.

📖 איור 11-1-3-3 · עמ' 212

גדילה עצמית של חוליות החזה

הרובד ההולוגרפי · הגב

אבחנה: גדילה עצמית של חוליות החזה

טיפול ותוצאה: בטיפול נבחרו נקודות הגב בשני הצדדים וחוזקו, בשילוב נקודות המחמם התיכון;

CA-3 CA-6

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 64, סובלת יותר מעשרים שנה מכאב בגב העליון, שהחמיר בהדרגה בשלוש השנים האחרונות. המטופלת סובלת גם מלחץ בחזה, קוצר נשימה ומלאות בבטן העליונה. צילום רנטגן הראה: עקמת קלה של חוליות החזה, וגדילה עצמית בשולי הצד והחזית של חוליות T3–8, היוצרת שינוי דמוי מקור עורב. אבחנה: גדילה עצמית של חוליות החזה. בטיפול נבחרו נקודות הגב בשני הצדדים וחוזקו, בשילוב נקודות המחמם התיכון; לאחר שישה טיפולים הכאב נעלם, טיפול אחת לשבועיים – הקלה קלינית.

📖 איור 11-1-3-4 · עמ' 212

פגיעה בשריר המעוין הגדול

הרובד ההולוגרפי · הגב

אבחנה: פגיעה בשריר המעוין הגדול בצד ימין

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות הגב, וחוזקו בשתי מחטים;

CA-6

תיאור המקרה המלא

נער, בן 12, סובל שלושה ימים מהחמרת כאב בגב ימין; חודש קודם לכן, לאחר משחק רוגבי, חש אי-נוחות בגב, ולפני שלושה ימים נפגע בבית הספר לאחר נפילה עם חבר לכיתה. בבדיקה: עווית ורגישות ללחץ בשריר המעוין הגדול בצד ימין (++). אבחנה: פגיעה בשריר המעוין הגדול בצד ימין. נבחרו נקודות הגב, וחוזקו בשתי מחטים; המתיחות בשריר המעוין שוחררה, המחטים נשארו 20 דקות, הרגישות ללחץ נעלמה בעיקרה ובתנועה כבר אין כאב, וכעבור שבוע נערך טיפול חיזוק נוסף – החלמה קלינית.

📖 איור 11-1-3-5 · עמ' 213

דלקת בגיד שריר העל-קוצי

הרובד ההולוגרפי · הכתף

אבחנה: דלקת בגיד שריר העל-קוצי

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות הצוואר והכתף, וחוזקו שתי מחטים מעל נקודות הצוואר ומתחתן ומחט אחת מאחורי נקודות הכתף;

CA-5 CA-9

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 56, מדריכת יוגה, סובלת חמישה חודשים מכאב בכתף ימין שאינה מאפשרת הרמה צידית; מפני שאינה מקבלת טיפול בזריקות חסימה מהרופאים הגיעה לקליניקה שלי. בבדיקה: רגישות ללחץ בגופי חוליות C4 ו-C5, מתיחות ורגישות ללחץ בשריר העל-קוצי, והרמת היד והרמה צידית של הגף העליון הימני אינן עוברות 90°; צילום רנטגן הראה הסתיידות בגיד שריר העל-קוצי. אבחנה: דלקת בגיד שריר העל-קוצי. נבחרו נקודות הצוואר והכתף, וחוזקו שתי מחטים מעל נקודות הצוואר ומתחתן ומחט אחת מאחורי נקודות הכתף; הרמת היד עברה 150°, המחטים נשארו 20 דקות, ובבדיקה חוזרת אפשר היה להרים עד 180°. כעבור עשרה ימים הגיעה לבדיקה חוזרת, הרמה צידית ל-120° עדיין גרמה לכאב, והמשכנו באותה שיטה; לאחר הדקירה כבר לא הייתה אי-נוחות בתנועה, המחטים נשארו 20 דקות, ולאחר מכן נערך חיזוק של חמישה טיפולים – החלמה קלינית.

📖 איור 11-1-4-1 · עמ' 214

פגיעה במפרק הכתף

הרובד ההולוגרפי · הכתף

אבחנה: פגיעה במפרק הכתף השמאלי

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות הכתף בשיטת הדקירה ההיקפית, תוך תנועה ועם הנעת מחט קלה; כעבור שבוע הגיעה שוב, בתנועה הכאב בכתף היה קל, נדקרה פעם נוספת – החלמה קלינית בעיקרה.

CA-9

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 20, סובלת שלושה שבועות מכאב בכתף שמאל; לפני שלושה שבועות נגרם למטופלת פריקה של מפרק הכתף השמאלי בעקבות פגיעה חיצונית, והיא פנתה למיון בבית החולים לצורך החזרה למקומה ונטלה תרופות נוגדות דלקת ומשככות כאב; הכאב פחת, אך התנועה הוגבלה במידה ניכרת והכאב היה קשה מנשוא. אבחנה: פגיעה במפרק הכתף השמאלי. נבחרו נקודות הכתף בשיטת הדקירה ההיקפית, תוך תנועה ועם הנעת מחט קלה; לאחר שהכאב הוסר בעיקרו המחטים נשארו 20 דקות, ובעת ההליכה אפשר היה להניע את הכתף. כעבור שבוע הגיעה שוב, בתנועה הכאב בכתף היה קל, נדקרה פעם נוספת – החלמה קלינית בעיקרה.

📖 איור 11-1-4-2 · עמ' 214

דלקת בורסה תת-אקרומיאלית; דלקת בגיד הראש הארוך של שריר הדו-ראשי

הרובד ההולוגרפי · הכתף

אבחנה: ① דלקת בורסה תת-אקרומיאלית בכתף ימין;

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות הכתף, וחוזקו שתי מחטים; כעבור שבוע טופל פעם נוספת באותה שיטה – החלמה קלינית.

CA-9

תיאור המקרה המלא

גבר, בן 59, סובל שלושה שבועות מכאב בכתף ימין, כאב בהרמה צידית ובהושטה לאחור, עם הגבלה בתנועה. בבדיקה: רגישות ללחץ מתחת לאקרומיון ובבליטת הקורקואיד; אבחנה: ① דלקת בורסה תת-אקרומיאלית בכתף ימין; ② דלקת בגיד הראש הארוך של שריר הדו-ראשי בצד ימין. נבחרו נקודות הכתף, וחוזקו שתי מחטים; הרמת הכתף כבר אינה כואבת, ובהושטה לאחור עוד נשארה אי-נוחות, הונעה המחט קלות, והכאב נעלם בעיקרו, המחטים נשארו 30 דקות. כעבור שבוע טופל פעם נוספת באותה שיטה – החלמה קלינית.

📖 איור 11-1-4-3 · עמ' 214

דלקת סביב מפרק הכתף

הרובד ההולוגרפי · הכתף

אבחנה: דלקת סביב מפרק הכתף בצד שמאל

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות הצוואר והכתף, וחוזקו; בעת עייפות נוספו גם נקודות המחמם המשולש.

CA-2 CA-3 CA-4 CA-5 CA-9

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 63, סובלת ארבעה חודשים מכאב בכתף שמאל עם הגבלה בתנועה, בליווי אי-נוחות בצוואר. אין גורם מעורר ברור, והמצב מחמיר בהדרגה. בבדיקה: הגף העליון השמאלי מתרחק לצד עד 45° ומורם קדימה עד 60°, סיבוב חיצוני ופנימי מוגבלים שניהם, ובצוואר יש תחושת נוקשות. אבחנה: דלקת סביב מפרק הכתף בצד שמאל. נבחרו נקודות הצוואר והכתף, וחוזקו; בעת עייפות נוספו גם נקודות המחמם המשולש. בסך הכול נערכו שישה טיפולים, אחד בשבוע, הכאב נעלם בעיקרו, התנועה תקינה והצוואר רפוי – החלמה קלינית.

📖 איור 11-1-4-4 · עמ' 216

פגיעה בשריר הדלתא (1)

הרובד ההולוגרפי · הכתף

אבחנה: פגיעה בשריר הדלתא בכתף ימין

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות הכתף, וחוזקו.

CA-9

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 54, סובלת חודשיים מכאב בכתף ימין, עם קושי בהרמת הזרוע ובהחזקת חפצים, והכאב מחריף בהרמת הזרוע. לפני חודשיים נפגעה הכתף בעת עבודות גינון בבית; נטילת תרופות דרך הפה ומריחת משחה נוגדת דלקת מקומית לא הביאו לשיפור גדול, ויש נטייה להחמרה, המפריעה לחיים ולעבודה. בבדיקה: כאב בשריר בצד החיצוני של הכתף ימין עם הגבלה בתנועה; נקודת האחיזה של שריר הדלתא רגישה ללחץ (++). אבחנה: פגיעה בשריר הדלתא בכתף ימין. נבחרו נקודות הכתף, וחוזקו. לאחר הדקירה הרמת הגף העליון חופשית והרגישות המקומית ללחץ פחתה; טיפלנו עוד חמש פעמים, אחד בשבוע – החלמה קלינית.

📖 איור 11-1-4-5 · עמ' 216

פגיעה בשריר הדלתא (2)

הרובד ההולוגרפי · הכתף

אבחנה: פגיעה בשריר הדלתא

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות הכתף, וחוזקו שתי מחטים.

CA-9

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 52, סובלת שלושה שבועות מכאב בכתף לאחר צביעת הבית, שמחריף בהרמת היד. בבדיקה: רגישות ללחץ בשריר הדלתא, וכאב חזק בנקודת האחיזה התחתונה. אבחנה: פגיעה בשריר הדלתא. נבחרו נקודות הכתף, וחוזקו שתי מחטים. המחטים נשארו 30 דקות, והרמת היד כבר ללא כאב; נערך טיפול חיזוק אחד – החלמה קלינית.

📖 איור 11-1-4-6 · עמ' 217

כאב כתף ממקור צווארי

הרובד ההולוגרפי · הכתף

אבחנה: כאב כתף ממקור צווארי

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות הצוואר והכתף בצד ימין, וחוזקה בהן מחט אחת כל אחת;

CA-5 CA-9

תיאור המקרה המלא

גבר, בן 38, סובל חודשיים מכאב בכתף ימין עם הגבלה בתנועה. בעת פעילות ספורטיבית נפל ונחת על המרפק הימני, ובהמשך כאב המרפק החלים מעצמו, אך כאב הכתף הימנית נמשך. בבדיקה: סיבוב פנימי, הרחקה והרמה קדימה של הכתף הימנית מוגבלים כולם בשל כאב, אין רגישות ללחץ ניכרת סביב הכתף הימנית, ויש רגישות ללחץ (+++) בגופי חוליות C5–7 בצוואר ימין; הובא בחשבון נזק דיסטלי המועבר מכנית. אבחנה: כאב כתף ממקור צווארי. נבחרו נקודות הצוואר והכתף בצד ימין, וחוזקה בהן מחט אחת כל אחת; לאחר הדקירה הכאב פחת מאוד, נערכו שלושה טיפולים, הכאב הוסר, תפקוד הכתף שב – החלמה קלינית.

📖 איור 11-1-4-7 · עמ' 217

פגיעה בשריר מרים השכמה

הרובד ההולוגרפי · הכתף

אבחנה: פגיעה בשריר מרים השכמה בצד שמאל

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות הצוואר, וחוזקו שתי נקודות;

CA-5

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 28, סובלת חודשיים מכאב עמום בכתף שמאל, שנגרם מנשיאת התינוק בתקופת ההנקה; הכאב מחריף בסיבוב הראש ובתנועת השכמה, בליווי כאב עמום בכתף ובגב, ותנועת הצוואר מוגבלת. בבדיקה: רגישות ללחץ ניכרת בזווית העליונה של השכמה השמאלית, המקרינה לעורף. אבחנה: פגיעה בשריר מרים השכמה בצד שמאל. נבחרו נקודות הצוואר, וחוזקו שתי נקודות; המחטים נשארו 30 דקות, השריר נרפה והכאב פחת. טיפלנו עוד פעמיים, אחד בשבוע – החלמה קלינית.

📖 איור 11-1-4-8 · עמ' 218

כאב לאחר ניתוח במפרק הכתף

הרובד ההולוגרפי · הכתף

אבחנה: כאב לאחר ניתוח במפרק הכתף

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות הצוואר ונקודות המרפק, וחוזקו; לאחר הדקירה השתפרה הרחקת מפרק הכתף השמאלית בכ-20°, ולאחר 30 דקות של השארת המחטים השתפר טווח התנועה ב-30° נוספות, והוא תקין בעיקרו.

CA-5 CA-9 CA-10

תיאור המקרה המלא

גבר, בן 35, לפני שנתיים נפגע בכתף שמאל, דבר שגרם לנקע (פריקה) של מפרק הכתף השמאלית; לאחר ניתוח להחזרת המפרק נותרו תסמינים שיוריים: הרחקה מוגבלת של מפרק הכתף השמאלית ותחושת משיכה באזור המרפק השמאלי. בבדיקה: רגישות ניכרת ללחץ בצד שמאל של הצוואר ובשריר העל-קוצי, אין רגישות ניכרת ללחץ מקומית במפרק הכתף, ובמפרק המרפק השמאלי יש רגישות ללחץ המלווה במשיכה של השרירים והגידים. אבחנה: כאב לאחר ניתוח במפרק הכתף. נבחרו נקודות הצוואר ונקודות המרפק, וחוזקו; לאחר הדקירה השתפרה הרחקת מפרק הכתף השמאלית בכ-20°, ולאחר 30 דקות של השארת המחטים השתפר טווח התנועה ב-30° נוספות, והוא תקין בעיקרו. לאחר מתיחת היתר היה בקצות האצבעות רדימות קלה; כעבור שבוע טופל שוב באותה שיטה, הרדימות ביד נעלמה – החלמה קלינית בעיקרה.

📖 איור 11-1-4-9 · עמ' 219

פגיעה בשריר התת-קוצי

הרובד ההולוגרפי · הכתף

אבחנה: פגיעה בשריר התת-קוצי השמאלי

טיפול ותוצאה: נדקרו נקודות הכתף ונקודות מאחורי הכתף בצד שמאל, והכאב הוקל מיד;

CA-9

תיאור המקרה המלא

גבר, בן 40, סובל שלושה שבועות מכאב בכתף שמאל באזור השכמה, שנגרם מחוסר זהירות בעת פעילות ספורטיבית. בבדיקה: רגישות ללחץ בשריר התת-קוצי השמאלי וברגישות ללחץ בפקעת הגדולה של עצם הזרוע. אבחנה: פגיעה בשריר התת-קוצי השמאלי. נדקרו נקודות הכתף ונקודות מאחורי הכתף בצד שמאל, והכאב הוקל מיד; המחטים נשארו 20 דקות, כעבור שבוע נערך טיפול נוסף – החלמה קלינית.

📖 איור 11-1-4-10 · עמ' 219

עייפות יתר של שריר הטרפז

הרובד ההולוגרפי · הכתף

אבחנה: עייפות יתר של שריר הטרפז השמאלי

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודת הצוואר (CA-5) ונקודת הכתף (CA-9) באותו צד; לאחר הדקירה הכאב פחת באופן ניכר, אך עדיין נותרה תחושת נוקשות בשריר, ולכן נוספו שתי מחטים בין נקודות הצוואר והכתף, והשריר נרפה.

CA-5 CA-9

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 28, דוקטורנטית, נתונה ללחץ גבוה בשל עבודה ובעיות אישיות, ולעיתים קרובות עליה לעבוד מול המחשב עשר שעות ויותר ביום. היא סובלת מכאב בצד שמאל של הצוואר והכתף. בבדיקה: נוקשות ורגישות ללחץ בשריר הטרפז השמאלי, ורגישות קלה בצד ימין, ללא תסמינים סובייקטיביים. אבחנה: עייפות יתר של שריר הטרפז השמאלי. נבחרו נקודת הצוואר (CA-5) ונקודת הכתף (CA-9) באותו צד; לאחר הדקירה הכאב פחת באופן ניכר, אך עדיין נותרה תחושת נוקשות בשריר, ולכן נוספו שתי מחטים בין נקודות הצוואר והכתף, והשריר נרפה. לאחר 30 דקות של השארת המחטים לא נותרה כל תחושה. טיפלנו עוד פעמיים כדי להפחית את הלחץ ולהסיר את המתח הנפשי, והכאב בצוואר ובכתף נעלם לגמרי – החלמה קלינית.

📖 איור 11-1-4-11 · עמ' 220

עווית בשריר הטרפז

הרובד ההולוגרפי · הכתף

אבחנה: עווית בשריר הטרפז

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות הצוואר ונקודות הגב, מחט אחת בכל צד, ולאחר מכן נוספו שלוש מחטים בין הנקודות.

CA-5 CA-6

תיאור המקרה המלא

גבר, בן 63, סובל שלושה שבועות מכאב בכתפיים ובצוואר משני הצדדים. בבדיקה: רגישות ללחץ בשריר הטרפז (+++), ברגישות ללחץ בחלק התחתון של הגב (+) ותיאבון ירוד. אבחנה: עווית בשריר הטרפז. נבחרו נקודות הצוואר ונקודות הגב, מחט אחת בכל צד, ולאחר מכן נוספו שלוש מחטים בין הנקודות. המחטים נשארו 30 דקות; לאחר הוצאתן עווית השריר נעלמה, ואין עוד רגישות ללחץ בגב התחתון. כעבור שבועיים טופל שוב – החלמה קלינית.

📖 איור 11-1-4-12 · עמ' 221

דלקת בבליטת הקורקואיד

הרובד ההולוגרפי · הכתף

אבחנה: דלקת בבליטת הקורקואיד הימנית

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות הכתף, עם תפעול קל של המחט;

CA-9

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 56, סובלת חודשיים מכאב באזור בליטת הקורקואיד בצד ימין; מלבד רגישות ללחץ, גם הסיבוב החיצוני של הכתף מוגבל, ואילו ההרמה כלפי מעלה תקינה. אבחנה: דלקת בבליטת הקורקואיד הימנית. נבחרו נקודות הכתף, עם תפעול קל של המחט; לאחר שהרגישות ללחץ נעלמה המחטים נשארו 20 דקות, ולאחר הוצאתן הסיבוב החיצוני כבר אינו כואב. כעבור שבוע טופלה שוב – החלמה קלינית.

📖 איור 11-1-4-13 · עמ' 221

צוואר תפוס (落枕)

הרובד ההולוגרפי · הכתף

אבחנה: צוואר תפוס

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות הצוואר ונקודות הגב בצד ימין;

CA-5 CA-6

תיאור המקרה המלא

גבר, בן 62, סובל שבועיים מכאב בצוואר ובכתף ימין; לדבריו, הכאב בצוואר החל לפני שבועיים לאחר שהתעורר משינה. בבדיקה: רגישות ללחץ בצד ימין בחוליות C2–5, רגישות ללחץ בשריר הטרפז, וסיבוב הראש והצוואר מוגבל. אבחנה: צוואר תפוס. נבחרו נקודות הצוואר ונקודות הגב בצד ימין; לאחר הדקירה הרגישות ללחץ בצוואר ובכתף נעלמה, המחטים נשארו 20 דקות והסיבוב של הראש כבר אינו כואב. בבדיקת מעקב כעבור שבוע לא נותרה כל אי-נוחות – החלמה קלינית.

📖 איור 11-1-4-14 · עמ' 222

כאב במפרק המרפק; עייפות יתר של שרירי המותן

הרובד ההולוגרפי · המרפק

אבחנה: כאב במפרק המרפק הימני;

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות המרפק, וחוזקו, וכן נקודות הגב, המותן והעצה, וחוזקו. כעבור שבועיים נדקרה שוב פעם אחת, כאב המרפק והמותן נעלם – החלמה קלינית.

CA-6 CA-7 CA-8 CA-10

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 48, סובלת חצי שנה מכאב במפרק המרפק הימני, ובמקביל מתחושת כאב ונוקשות עמומה בגב התחתון בצד ימין, שהחמירה בחודש האחרון ומעלה. אבחנה: כאב במפרק המרפק הימני; עייפות יתר של שרירי המותן בצד ימין. נבחרו נקודות המרפק, וחוזקו, וכן נקודות הגב, המותן והעצה, וחוזקו. לאחר הטיפול הכאב פחת; המחטים נשארו 30 דקות, כאב מפרק המרפק נעלם לגמרי וכאב המותן נותר קל בלבד. כעבור שבועיים נדקרה שוב פעם אחת, כאב המרפק והמותן נעלם – החלמה קלינית.

📖 איור 11-1-5-1 · עמ' 222

דלקת באפיקונדיל המדיאלי של עצם הזרוע

הרובד ההולוגרפי · המרפק

אבחנה: דלקת באפיקונדיל המדיאלי

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות המרפק; בתנועה כבר לא היה כאב והרגישות ללחץ פחתה, ולאחר שחוזקו עוד שתי מחטים נעלמה הרגישות ללחץ לגמרי.

CA-10

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 63, סובלת חודשיים מכאב בצד הפנימי של המרפק השמאלי; לפני שלושה ימים נפלה בשוגג ונחתה על כף היד, והכאב החמיר, עד שהיה קשה לשאת אותו בעת נשיאת חפצים ובעת סחיטת מגבת. בבדיקה: רגישות ללחץ (+++) בגיד המשותף של שרירי המרפק. אבחנה: דלקת באפיקונדיל המדיאלי. נבחרו נקודות המרפק; בתנועה כבר לא היה כאב והרגישות ללחץ פחתה, ולאחר שחוזקו עוד שתי מחטים נעלמה הרגישות ללחץ לגמרי. המחטים נשארו 20 דקות. בבדיקת מעקב כעבור שבועיים התנועה אינה מוגבלת ויש רק רגישות קלה ללחץ; טיפלנו עוד פעם אחת – החלמה קלינית.

📖 איור 11-1-5-2 · עמ' 223

דלקת באפיקונדיל הלטרלי של עצם הזרוע

הרובד ההולוגרפי · המרפק

אבחנה: דלקת באפיקונדיל הלטרלי

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות הצוואר בצד ימין, וחוזקה נקודה אחת, והרגישות ללחץ במרפק פחתה בחצי; לאחר מכן נבחרו נקודות המרפק הימני, וחוזקו שתי מחטים.

CA-5 CA-10

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 51, סובלת חודשיים מכאב במרפק ימין, שמחריף בנשיאת חפצים ובסחיטת מגבת. בבדיקה: רגישות ניכרת ללחץ בחוליות C5 ו-C6. אבחנה: דלקת באפיקונדיל הלטרלי. נבחרו נקודות הצוואר בצד ימין, וחוזקה נקודה אחת, והרגישות ללחץ במרפק פחתה בחצי; לאחר מכן נבחרו נקודות המרפק הימני, וחוזקו שתי מחטים. הרגישות ללחץ במרפק נעלמה, והמשכנו בשני טיפולי ביסוס.

📖 איור 11-1-5-3 · עמ' 223

מרפק טניסאי ותסמונת מורטון

הרובד ההולוגרפי · המרפק

אבחנה: ① מרפק טניסאי;

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות המרפק ונקודות כף הרגל, וחוזקו;

CA-10 CA-16

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 53, סובלת ארבעה חודשים מכאב במרפק ימין, וחמש שנים מכאב מתחת למפרקי המסרקים של האצבעות השלישית והרביעית של כף הרגל השמאלית. בבדיקה: כאב בעת הפעלת כוח ביד ימין, בייחוד בסחיטת מגבת ובנשיאת חפצים, ורגישות ללחץ (+++) באפיקונדיל הלטרלי של עצם הזרוע הימנית. מזה שנים רבות כואבת כף הרגל באזור המסרקים, ובייחוד בחורף, כשהנעליים צרות יותר, הכאב מחמיר; רגישות ללחץ (++) במפרקי המסרקים השלישי והרביעי. אבחנה: ① מרפק טניסאי; ② תסמונת מורטון. נבחרו נקודות המרפק ונקודות כף הרגל, וחוזקו; לאחר הדקירה הכאב פחת, ולאחר שלושה טיפולים נעלם בעיקרו, וחיזקנו עוד פעמיים – הקלה קלינית.

📖 איור 11-1-5-4 · עמ' 224

עייפות יתר של שרירי הפשט של פרק כף היד

הרובד ההולוגרפי · פרק כף היד והיד

אבחנה: עייפות יתר של שרירי הפשט של פרק כף היד בשני הצדדים

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות המרפק משני הצדדים, וחוזקו, בצירוף נקודות פרק כף היד;

CA-10 CA-11

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 33, סובלת שבעה חודשים מכאב בפרקי שתי כפות הידיים. הילד נולד לפני שנה, ובשל נשיאת הילד מדי יום הופיע כאב בפרקי הידיים, חמור יותר בצד ימין. בבדיקה: רגישות ניכרת ללחץ בשרירי הפשט של פרק כף היד בשני הצדדים. אבחנה: עייפות יתר של שרירי הפשט של פרק כף היד בשני הצדדים. נבחרו נקודות המרפק משני הצדדים, וחוזקו, בצירוף נקודות פרק כף היד; כבר לאחר טיפול אחד הכאב פחת. טיפלנו אחת לשבוע, ולאחר חמישה טיפולים – החלמה קלינית.

📖 איור 11-1-6-1 · עמ' 224

תסמונת התעלה הקרפלית עם מחלת עמוד שדרה צווארי

הרובד ההולוגרפי · פרק כף היד והיד

אבחנה: ① תסמונת התעלה הקרפלית בצד ימין;

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות הצוואר, המרפק, פרק כף היד והיד, והמחטים נשארו חצי שעה.

CA-5 CA-10 CA-11 CA-12

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 52, סובלת יותר מחודשיים מכאב באזור הבליטה של האגודל (תנר) ביד ימין, וברדימות באצבע המורה ובאצבע האמצעית. בבדיקה: רגישות ללחץ בצד ימין של הצוואר, רגישות ללחץ ברקמת השריר באזור מפרק המרפק, וסימן טינל חיובי. אבחנה: ① תסמונת התעלה הקרפלית בצד ימין; ② מחלת עמוד שדרה צווארי. נבחרו נקודות הצוואר, המרפק, פרק כף היד והיד, והמחטים נשארו חצי שעה. הכאב והרדימות ביד ימין פחתו באופן ניכר; טופלה חמש פעמים ברציפות, הכאב והרדימות נעלמו לגמרי – החלמה קלינית.

📖 איור 11-1-6-2 · עמ' 225

תסמונת לכידות מרובות בגף העליון

הרובד ההולוגרפי · פרק כף היד והיד

אבחנה: תסמונת לכידות מרובות בגף העליון הימני

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות הצוואר, המרפק והאגודל, וחוזקו נקודות המרפק.

CA-5 CA-10

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 35, סובלת שנתיים מכאב באזור הבליטה של האגודל ביד ימין. בבדיקה: רגישות ללחץ בצד ימין של הצוואר; רגישות ניכרת ללחץ מקומית באזור הבליטה של האגודל הימני, וכאב בהרחקה ובהקרבה של האגודל; רגישות ללחץ באפיקונדיל הלטרלי של המרפק הימני. אבחנה: תסמונת לכידות מרובות בגף העליון הימני. נבחרו נקודות הצוואר, המרפק והאגודל, וחוזקו נקודות המרפק. המחטים נשארו 30 דקות, לאחר הדקירה הכאב פחת; חיזקנו בעוד שלושה טיפולים – החלמה קלינית.

📖 איור 11-1-6-3 · עמ' 225

עייפות יתר של שרירי המותן

הרובד ההולוגרפי · המותן

אבחנה: עייפות יתר של שרירי המותן

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות המותן, וחוזקה מחט אחת למעלה ואחת למטה, בשיטת דקירה עם תנועה;

CA-7

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 65, סובלת חמש שנים מכאב כרוני בגב התחתון, כאב בגב התחתון ובישבן, שמופיע בהליכה ובתנועת המותן ומחמיר במתח ובעייפות. בבדיקה: רגישות ניכרת ללחץ בצד ימין של אזור המותן. אבחנה: עייפות יתר של שרירי המותן. נבחרו נקודות המותן, וחוזקה מחט אחת למעלה ואחת למטה, בשיטת דקירה עם תנועה; לאחר שלוש דקות בבדיקה הרגישות ללחץ נעלמה והתנועה אינה מושפעת. המחטים נשארו 30 דקות, ובהליכה כבר לא נותרו תסמינים; חיזקנו בעוד שני טיפולים – הקלה קלינית.

📖 איור 11-1-7-1 · עמ' 226

פגיעה בשריר המותני הגדול (1)

הרובד ההולוגרפי · המותן

אבחנה: פגיעה בשריר המותני הגדול

טיפול ותוצאה: בטיפול נבחרו נקודות המותן, נקודות העצה ונקודות המחמם התחתון, ונוספו מחטים מחזקות;

CA-4 CA-7 CA-8

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 55, סובלת ארבעה חודשים מכאב בגב התחתון, בליווי קושי להתכופף. נטילת תרופות נוגדות דלקת ומשככות כאב מקלה, אך הכאב חוזר תמיד. בבדיקה: רגישות מקומית ללחץ בגב התחתון, תנועה מוגבלת, ורגישות ללחץ (+++) בנקודת האחיזה של שריר המותני הגדול על הטרוכנטר הקטן באזור המפשעה. אבחנה: פגיעה בשריר המותני הגדול. בטיפול נבחרו נקודות המותן, נקודות העצה ונקודות המחמם התחתון, ונוספו מחטים מחזקות; המחטים נשארו 30 דקות, ובהתכופפות כבר אין כאב. בבדיקת מעקב כעבור שבוע המותן רפויה יותר מקודם, ואין כל אי-נוחות בהתכופפות ובסיבוב; טופלה שוב באותה שיטה – החלמה קלינית.

📖 איור 11-1-7-2 · עמ' 226

פגיעה בשריר המותני הגדול (2)

הרובד ההולוגרפי · המותן

אבחנה: פגיעה בשריר המותני הגדול

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות המותן, וחוזקה נקודה אחת למעלה ואחת למטה, ובנקודות המחמם התחתון נדקרו שתי מחטים.

CA-4 CA-7

תיאור המקרה המלא

גבר, בן 55, סובל שבועיים מכאב בגב התחתון בצד ימין, המתבטא בעיקר בקושי בהסתובבות ובהתכופפות. בבדיקה: רגישות ללחץ בצד ימין של גופי החוליות L2–4, ורגישות ניכרת ללחץ בצד הפנימי של שורש הירך הימנית, סמוך למפשעה. אבחנה: פגיעה בשריר המותני הגדול. נבחרו נקודות המותן, וחוזקה נקודה אחת למעלה ואחת למטה, ובנקודות המחמם התחתון נדקרו שתי מחטים. לאחר הדקירה המטופל כבר מתהפך על המיטה ללא כאב; המחטים נשארו 30 דקות, ולאחר הוצאתן הוא ירד מהמיטה ונע ללא אי-נוחות ניכרת. כעבור שבוע נערך טיפול ביסוס אחד – החלמה קלינית.

📖 איור 11-1-7-3 · עמ' 227

כאב גב תחתון בהריון

הרובד ההולוגרפי · המותן

אבחנה: כאב גב תחתון בהריון

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות המותן ונקודות השוק;

CA-7

⚠️ המקרה עוסק במטופלת בהריון, אף שהספר מונה הריון בין התוויות הנגד (עמ' 156, 190).

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 32, בחודש התשיעי להריונה, סובלת מכאב בגב התחתון בליווי כאב בשוק השמאלית; בהליכה ובתנועה כואב הגב התחתון והשוק תפוחה וכואבת. אבחנה: כאב גב תחתון בהריון. נבחרו נקודות המותן ונקודות השוק; לאחר הדקירה הכאב פחת מיד, וגם עווית שריר התאומים בשוק הוקלה – הקלה קלינית.

📖 איור 11-1-7-4 · עמ' 228

בקע דיסק מותני בקטע L4–5 עם הסטת חוליה מותנית

הרובד ההולוגרפי · המותן

אבחנה: ① בקע דיסק מותני בקטע L4–5;

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות המותן והעצה, וחוזקו.

CA-7 CA-8

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 58, סובלת שנתיים מכאב גב תחתון חוזר, עם הגבלה בתנועה, ולעיתים קרובות הגב התחתון נתקע פתאום. בבדיקה: רגישות ניכרת ללחץ ב-L4–5 וב-L5-S1. בדימות תהודה מגנטית: חוליה L4 הוסטה לאחור, ויש לחץ קל על חוט השדרה בקטע L4–5. אבחנה: ① בקע דיסק מותני בקטע L4–5; ② הסטת חוליה מותנית. נבחרו נקודות המותן והעצה, וחוזקו. נערכו בסך הכול שמונה טיפולים, אחד בשבוע; הכאב בגב התחתון נעלם בעיקרו, התנועה חופשית ותסמיני התקיעה והלחץ נעלמו – הקלה קלינית.

📖 איור 11-1-7-5 · עמ' 228

כאב כרוני במותן וברגל עם גדילת עצם בחוליות המותניות

הרובד ההולוגרפי · המותן

אבחנה: ① כאב כרוני במותן וברגל;

טיפול ותוצאה: בטיפול נבחרו נקודות המותן והעצה, וחוזקו, בסך הכול ארבע מחטים;

CA-7 CA-8

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 65, סובלת חצי שנה מכאב בגב התחתון בצד ימין, בליווי כאב בצד החיצוני של הירך ברגל ימין; בהליכה, ובייחוד בעלייה וירידה במדרגות, הכאב מחמיר. צילום רנטגן: עמוד השדרה מעוקם לצד שמאל, יש גדילת עצם במרווח בין L5 ל-S1 והחורים הבין-חולייתיים מצטמצמים. בבדיקה: רגישות ניכרת ללחץ באזור הגב התחתון והישבן בצד ימין, ובדיקת הרמת רגל ישרה שלילית. אבחנה: ① כאב כרוני במותן וברגל; ② גדילת עצם בחוליות המותניות. בטיפול נבחרו נקודות המותן והעצה, וחוזקו, בסך הכול ארבע מחטים; נערכו בסך הכול שמונה טיפולים, ובעלייה וירידה במדרגות ובהליכה כבר אין כאב כלל – הקלה קלינית.

📖 איור 11-1-7-6 · עמ' 230

סיאטיקה

הרובד ההולוגרפי · המותן

אבחנה: סיאטיקה בצד ימין

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות המותן והעצה, וחוזקה נקודה אחת באמצע;

CA-7 CA-8

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 57, סובלת שלושה ימים מכאב בגב התחתון, בישבן, בחלק האחורי של הירך ובצד האחורי-חיצוני של השוק בצד ימין. באופן כללי היא סובלת כעשר שנים מכאבי גב תחתון, פעם קל ופעם חמור. הפעם, לאחר ישיבה על ספה נמוכה, החל הכאב בגב התחתון מיד עם הקימה, קשה ללכת, והכאב מגיע עד מפרק הקרסול. בבדיקה: בדיקת הרמת רגל ישרה – 60°, בדיקת ההיפר-פלקסיה חיובית, רגישות ללחץ בישבן ימין, בחלק האחורי של הירך ובבור המפרק (פוליטאלי), ורגישות ללחץ בשליש התחתון של השוק סמוך לגיד אכילס. אבחנה: סיאטיקה בצד ימין. נבחרו נקודות המותן והעצה, וחוזקה נקודה אחת באמצע; הרגישות ללחץ בישבן ובירך הימנית נעלמה, וכשהמטופלת ירדה מהמיטה והלכה ותנועת המותן כבר לא גרמה כל אי-נוחות. טיפלנו עוד פעמיים, אחד בשבוע – הקלה קלינית.

📖 איור 11-1-7-7 · עמ' 231

בקע דיסק מותני עם סיאטיקה

הרובד ההולוגרפי · המותן

אבחנה: ① בקע דיסק מותני;

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות המותן והעצה, וחוזקה מחט אחת;

CA-7 CA-8

תיאור המקרה המלא

אישה, סובלת שנה מסיאטיקה בצד שמאל, עם כאב חוזר המקרין מהגב התחתון לאורך הצד החיצוני של הירך, אל הצד החיצוני של השוק ועד לבהונות. לפני חמש שנים הייתה התקפה דומה, ולאחר טיפול בחסימה החלימה קלינית, אך הפעם התוצאה אינה ניכרת. בבדיקה: בדיקת הרמת רגל ישרה בצד שמאל חיובית, בגובה 70°. בצילום CT: בקע דיסק מותני בין חוליות 4–5 של המותן. אבחנה: ① בקע דיסק מותני; ② סיאטיקה בצד שמאל. נבחרו נקודות המותן והעצה, וחוזקה מחט אחת; לאחר הטיפול הרגישות ללחץ בגב התחתון ובישבן פחתה באופן ניכר, ובהליכה נותרה אי-נוחות קלה בשוק. טיפלנו עוד ארבע פעמים, הכאב נעלם, בדיקת הרמת הרגל הישרה שלילית ובגובה 90° – הקלה קלינית.

📖 איור 11-1-7-8 · עמ' 231

נוירלגיה של העצב הירכי

הרובד ההולוגרפי · המותן

אבחנה: נוירלגיה של העצב הירכי בצד ימין

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודת המחמם התחתון (CA-4) ונקודת הברך (CA-14); בנקודת המחמם התחתון, בחלק התחתון הסמוך לאזור המפשעה, נדקרו שתי מחטים, שהסירו את הרגישות ללחץ במפשעה, ובסמוך לנקודת הברך נדקרו עוד שתי מחטים, שהסירו את אי-הנוחות בברך.

CA-4 CA-14

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 56, סובלת שנתיים מכאב בירך ימין, שמחמיר בהליכה ומקרין מאזור המפשעה אל מפרק הברך. בבדיקה: אין נקודת רגישות ללחץ בגב התחתון, יש רגישות ניכרת ללחץ בנקודת המוצא של שריר ארבע-ראשי הירך באזור המפשעה, רגישות ללחץ בשרירי הצד הפנימי של הירך, ובדיקת מפרק הברך תקינה עם טווח תנועה תקין. אבחנה: נוירלגיה של העצב הירכי בצד ימין. נבחרו נקודת המחמם התחתון (CA-4) ונקודת הברך (CA-14); לאחר הדקירה הוצאה המטופלת להליכה והכאב פחת. בנקודת המחמם התחתון, בחלק התחתון הסמוך לאזור המפשעה, נדקרו שתי מחטים, שהסירו את הרגישות ללחץ במפשעה, ובסמוך לנקודת הברך נדקרו עוד שתי מחטים, שהסירו את אי-הנוחות בברך. לאחר 30 דקות של השארת המחטים כבר אין כאב. טיפלנו עוד שלוש פעמים לביסוס, אחד בשבוע – החלמה קלינית.

📖 איור 11-1-7-9 · עמ' 231

פגיעה בעצב הירכי

הרובד ההולוגרפי · המותן

אבחנה: פגיעה בעצב הירכי בצד שמאל

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות המותן והעצה, וחוזקה נקודה אחת באמצע, ובנוסף נבחרו נקודות המחמם האמצעי והתחתון.

CA-3 CA-4 CA-7 CA-8

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 62, סובלת שמונה שנים מכאב בעצב הירכי בצד שמאל, עם החמרה בחודשיים האחרונים; כאב בחלק הקדמי של הירך השמאלית, קושי בהליכה, ולעיתים גם התעוררות מכאב בלילה. צילום רנטגן: עקמת ימנית שמרכזה ב-L2, עם גדילת עצם. אבחנה: פגיעה בעצב הירכי בצד שמאל. נבחרו נקודות המותן והעצה, וחוזקה נקודה אחת באמצע, ובנוסף נבחרו נקודות המחמם האמצעי והתחתון. לאחר הטיפול הכאב בגב התחתון ובבטן התחתונה השמאלית פחת. בסך הכול נערכו שמונה טיפולים, אחד בשבוע, ולאחר מכן אחד בשבועיים; הכאב נעלם – הקלה קלינית.

📖 איור 11-1-7-10 · עמ' 233

חבלה כרונית בעצם הזנב

הרובד ההולוגרפי · העצה ואזור הירך

אבחנה: חבלה בעצם הזנב

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות העצה, וחוזקו שתי מחטים;

CA-8

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 38, סובלת שנתיים מכאב בעצם הזנב לאחר נפילה בישיבה על מדרגות, והכאב מופיע בישיבה ממושכת. היא פנתה לכירופרקטור, וטיפולים בתרופות נוגדות דלקת דרך הפה ובחסימה מקומית במשך כמה חודשים לא סילקו את הכאב. בבדיקה: רגישות ניכרת למגע בעצם הזנב, ורגישות ללחץ בחוליות המותן ובמפרק העצה-כסל (סקרואיליאק). אבחנה: חבלה בעצם הזנב. נבחרו נקודות העצה, וחוזקו שתי מחטים; כאב עצם הזנב פחת, וטיפלנו אחת לשבועיים. לאחר שלושה טיפולים הכאב הוסר לגמרי, אין רגישות מקומית ללחץ, ואין אי-נוחות גם בישיבה של יותר משעה – החלמה קלינית.

📖 איור 11-1-8-1 · עמ' 233

פגיעה בשריר העכוז הבינוני (1)

הרובד ההולוגרפי · העצה ואזור הירך

אבחנה: פגיעה בשריר העכוז הבינוני השמאלי

טיפול ותוצאה: נבחרה נקודת העצה (CA-13), בדקירה אמצעית; במגע הכאב פחת, ובהתאם למיקום הכאב חוזקו שתי מחטים, אחת למעלה ואחת למטה, ובמגע הכאב נעלם.

CA-8 CA-13

⚠️ בטקסט נכתב "נקודת העצה (CA-13)"; לפי פרק 3 העצה היא CA-8 והירך CA-13.

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 33, לפני שלושה ימים החליקה במדרגות ונחתה על הישבן השמאלי; כואב בישבן בהליכה ובישיבה. בבדיקה: בחלק התחתון של הישבן השמאלי יש חבורה בגודל 2×3 ס"מ, שריר העכוז הבינוני והאזור של בליטת הישכיון כואבים כבר במגע קל, והכאב מחמיר בעמידה על רגל אחת. אבחנה: פגיעה בשריר העכוז הבינוני השמאלי. נבחרה נקודת העצה (CA-13), בדקירה אמצעית; במגע הכאב פחת, ובהתאם למיקום הכאב חוזקו שתי מחטים, אחת למעלה ואחת למטה, ובמגע הכאב נעלם. כשהמטופלת הוצאה להליכה לא הייתה אי-נוחות ניכרת, ובישיבה נותר כאב קל; נעשה תפעול בו-זמני של שלוש המחטים, ובישיבה חוזרת כבר אין כאב. כעבור שבוע טופלה שוב – החלמה קלינית.

📖 איור 11-1-8-2 · עמ' 234

פגיעה בשריר העכוז הבינוני (2)

הרובד ההולוגרפי · העצה ואזור הירך

אבחנה: פגיעה בשריר העכוז הבינוני השמאלי

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות המותן, העצה והירך;

CA-7 CA-8 CA-13

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 19, סובלת חודש מכאב בישבן השמאלי ללא גורם מעורר ברור, עם צליעה קלה. בבדיקה: רגישות ללחץ (++) בחלק התחתון של המותן ובישבן השמאלי, תנועת ההתכופפות והסיבוב תקינה, ובדיקת העמידה על רגל אחת חיובית. אבחנה: פגיעה בשריר העכוז הבינוני השמאלי. נבחרו נקודות המותן, העצה והירך; לאחר הדקירה רקמת השריר נרפתה, הרגישות ללחץ נעלמה, ולאחר הוצאת המחטים ההליכה תקינה – החלמה קלינית.

📖 איור 11-1-8-3 · עמ' 235

פגיעה בשריר העכוז הבינוני (3)

הרובד ההולוגרפי · העצה ואזור הירך

אבחנה: פגיעה בשריר העכוז הבינוני בצד שמאל

טיפול ותוצאה: נבחרה נקודת העצה, וחוזקו שתי מחטים;

CA-8

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 48, מספרת על כאב בישבן השמאלי במשך שנה ושני חודשים, שהתחיל בעקבות פעילות יתר בהליכה; בהליכה היא צולעת מכאב, וליטול תרופות משככות כאב ונוגדות דלקת ולבצע חסימה מקומית לא הביאו להקלה מלאה. בבדיקת אולטרסאונד: צפיפות שכבת השריר של העכוז הבינוני מוגברת; בבדיקה: רגישות ללחץ (++) בשריר העכוז הבינוני. אבחנה: פגיעה בשריר העכוז הבינוני בצד שמאל. נבחרה נקודת העצה, וחוזקו שתי מחטים; הרגישות ללחץ בשריר העכוז הבינוני פחתה באופן ניכר, והמחטים נשארו 20 דקות. טיפלנו עוד פעמיים לביסוס, אחד בשבועיים; הרגישות ללחץ נעלמה ובהליכה אין עוד תחושת כאב – החלמה קלינית.

📖 איור 11-1-8-4 · עמ' 235

נוירלגיה של העצב העורי העליון של הישבן

הרובד ההולוגרפי · העצה ואזור הירך

אבחנה: נוירלגיה של העצב העורי העליון של הישבן

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודת המותן (CA-7) ונקודת הגב (CA-6), ולפני נקודת המותן ומתחתיה חוזקה מחט אחת בכל צד, ונוספה מחט אחת על נקודת הגב.

CA-6 CA-7

תיאור המקרה המלא

גבר, בן 55, סובל יומיים מכאב בגב התחתון, המקרין לצד החיצוני של הירך ולברך, אך הכאב אינו חוצה את מפרק הברך. בבדיקה: רגישות ללחץ (+++) ב-L2–5, מתח בשרירי הגב והמותן לצד עמוד השדרה, רגישות ללחץ באזור העצב העורי העליון של הישבן, והתכופפות מוגבלת, עם הקרנה למעלה ולמטה. אבחנה: נוירלגיה של העצב העורי העליון של הישבן. נבחרו נקודת המותן (CA-7) ונקודת הגב (CA-6), ולפני נקודת המותן ומתחתיה חוזקה מחט אחת בכל צד, ונוספה מחט אחת על נקודת הגב. הרגישות ללחץ במותן פחתה באופן ניכר, גם נוקשות שרירי הגב הוקלה, והמטופל הוצא להליכה – כבר אין כאב, אך בהתכופפות עדיין יש אי-נוחות. בנקודות המותן והגב נעשה תפעול המחטים, עם רטט קל, ובהתאמה העמקנו מעט; בהתכופפות חוזרת כבר אין בעיה. המחטים נשארו 20 דקות, ובעת הוצאתן כבר אין כאב. לאחר מכן הוריתי למטופל לא להרים משאות כבדים, וטיפלנו עוד פעם אחת – החלמה קלינית.

📖 איור 11-1-8-5 · עמ' 235

פגיעה בשריר הדו-ראשי של הירך

הרובד ההולוגרפי · העצה ואזור הירך

אבחנה: פגיעה בשריר הדו-ראשי של הירך בצד שמאל

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות העצה והירך, וחוזקה מחט אחת בכל אחת; לאחר הוצאתן הכאב בהליכה נעלם, וכעבור שבוע נדקרה שוב – החלמה קלינית.

CA-8 CA-13

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 52, סובלת שבוע מכאב בירך שמאל, עם צליעה קלה בהליכה וכאב בצד הצדדי בעת פשיטת הירך. לדברי המטופלת אין גורם מעורר ברור. בבדיקה: רגישות ללחץ בגבשושית הישכיון השמאלית, ורגישות ללחץ בנקודת האחיזה של שריר הדו-ראשי של הירך בצד החיצוני של בור המפרק (פוליטאלי). אבחנה: פגיעה בשריר הדו-ראשי של הירך בצד שמאל. נבחרו נקודות העצה והירך, וחוזקה מחט אחת בכל אחת; בעת הליכה הכאב פחת, והמחטים נשארו 20 דקות. לאחר הוצאתן הכאב בהליכה נעלם, וכעבור שבוע נדקרה שוב – החלמה קלינית.

📖 איור 11-1-8-6 · עמ' 237

פגיעה בשריר הפיריפורמיס

הרובד ההולוגרפי · העצה ואזור הירך

אבחנה: פגיעה בשריר הפיריפורמיס בצד שמאל

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות המותן והעצה, והמחטים נשארו 30 דקות;

CA-7 CA-8

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 38, סובלת יותר מחודש מסיאטיקה בצד שמאל ללא גורם מעורר ברור, עם כאב המקרין לצד האחורי-חיצוני של הירך עד לאזור הקרסול, וגורם לקושי בהליכה ולצליעה. בבדיקה: אין רגישות ללחץ באזור חוליות המותן, רגישות ללחץ (++) באזור מפרק העצה-כסל, רגישות ללחץ (+++) באזור שריר הפיריפורמיס, ובדיקת המתח של שריר הפיריפורמיס חיובית. אבחנה: פגיעה בשריר הפיריפורמיס בצד שמאל. נבחרו נקודות המותן והעצה, והמחטים נשארו 30 דקות; בסיאטיקה עדיין יש תחושת הקרנה כלפי מטה, אך בעוצמה נמוכה מ-50%. כעבור שבוע טופלה שוב, התסמינים נעלמו בעיקרם, וטיפלנו עוד פעמיים לביסוס – החלמה קלינית.

📖 איור 11-1-8-7 · עמ' 237

כאב לאחר ניתוח במפרק הירך

הרובד ההולוגרפי · העצה ואזור הירך

אבחנה: כאב לאחר ניתוח במפרק הירך השמאלי

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות המותן והעצה; לאחר הדקירה הרגישות ללחץ פחתה, חוזקה מחט אחת, ובתפעול קל של המחט הרגישות ללחץ כבר אינה ניכרת.

CA-7 CA-8

תיאור המקרה המלא

גבר, בן 27, סובל שנתיים מכאב במפרק הירך השמאלי, שמחמיר בעייפות ובימי גשם. לפני שנתיים עבר החלפת מפרק ירך מלאכותי, ומאז הוא חש אי-נוחות מתמדת, והכאב בולט בגשם ובעייפות. בבדיקה: רגישות ללחץ (+++) בשריר העכוז הבינוני סמוך למפרק הירך, ורגישות ללחץ (++) בגב התחתון. אבחנה: כאב לאחר ניתוח במפרק הירך השמאלי. נבחרו נקודות המותן והעצה; לאחר הדקירה הרגישות ללחץ פחתה, חוזקה מחט אחת, ובתפעול קל של המחט הרגישות ללחץ כבר אינה ניכרת. המחטים נשארו 20 דקות. לאחר הוצאתן, בהליכה, הכאב פחת; טופל עוד פעמיים בדיקור וחימום, אחד בשבועיים, והכאב הוקל בעיקרו.

📖 איור 11-1-8-8 · עמ' 238

דלקת בורסה של גבשושית הישכיון

הרובד ההולוגרפי · העצה ואזור הירך

אבחנה: דלקת בורסה של גבשושית הישכיון

טיפול ותוצאה: נבחרה נקודת העצה התחתונה והרגישות ללחץ פחתה; חוזקה עוד מחט אחת, והכאב נעלם לגמרי.

CA-8

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 61, סובלת שבוע מכאב בישבן השמאלי, כואב בישיבה ממושכת, והכאב מחמיר בעלייה במדרגות. בבדיקה: רגישות ללחץ (+++) באזור גבשושית הישכיון השמאלית. אבחנה: דלקת בורסה של גבשושית הישכיון. נבחרה נקודת העצה התחתונה והרגישות ללחץ פחתה; חוזקה עוד מחט אחת, והכאב נעלם לגמרי. כעבור שבוע טופלה שוב – החלמה קלינית.

📖 איור 9-1-8-11 · עמ' 238

רכות סחוס של פיקת הברך

הרובד ההולוגרפי · הברך

אבחנה: רכות סחוס של פיקת הברך

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות הברך, ונדקרו ארבע נקודות מסביב; בבדיקה נוספת הרגישות ללחץ נעלמה ונותר כאב קל בכריעה;

CA-14

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 46, סובלת חצי שנה מכאב במפרק הברך, שמחמיר בעלייה וירידה במדרגות ובכריעה; לעיתים הרגל רפויה והיא נופלת בקלות. בבדיקה: רגישות ללחץ (++) מתחת לפיקת הברך, מתח בשריר התאומים מאחורי הברך ורגישות ללחץ (+++). אבחנה: רכות סחוס של פיקת הברך. נבחרו נקודות הברך, ונדקרו ארבע נקודות מסביב; בבדיקה חוזרת הרגישות ללחץ פחתה, והמחטים נשארו 20 דקות. בבדיקה נוספת הרגישות ללחץ נעלמה ונותר כאב קל בכריעה; המשכנו בטיפול באותה שיטה עוד פעמיים – החלמה קלינית.

📖 איור 1-9-1-11 · עמ' 239

כאב במפרק הברך לאחר כריתת המניסקוס

הרובד ההולוגרפי · הברך

אבחנה: כאב במפרק הברך הימנית לאחר כריתת מניסקוס

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודת המחמם התחתון (CA-4) ונקודת הברך (CA-14); במחמם התחתון נדקרה דקירה משולשת, ולצד נקודת הברך חוזקו שתי מחטים.

CA-4 CA-14

תיאור המקרה המלא

גבר, בן 32, סובל חודשיים מכאב במפרק הברך הימנית; לפני שלוש שנים עבר כריתת מניסקוס, ומאז כמעט חדל לעסוק בספורט, קשה לו לכרוע עד הסוף והליכה כואבת. בבדיקה: בדיקת ההתנגדות לפשיטת הברך חיובית, ובצד הפנימי של מפרק הברך יש נקודת רגישות ללחץ (++), וכן רגישות ללחץ בבטן התחתונה הימנית ובנקודת המוצא של שריר ארבע-ראשי הירך באזור המפשעה. אבחנה: כאב במפרק הברך הימנית לאחר כריתת מניסקוס. נבחרו נקודת המחמם התחתון (CA-4) ונקודת הברך (CA-14); במחמם התחתון נדקרה דקירה משולשת, ולצד נקודת הברך חוזקו שתי מחטים. המחטים נשארו 30 דקות; הרגישות ללחץ בבטן הימנית ובמפשעה נעלמה, והמטופל יכול כבר לכרוע. כעבור שבועיים טופל שוב, ובהליכה ובכריעה כבר אין שום תחושת כאב; חיזקנו עוד פעמיים – הקלה קלינית.

📖 איור 2-9-1-11 · עמ' 239

דלקת במפרק הברך

הרובד ההולוגרפי · הברך

אבחנה: דלקת במפרק הברך השמאלית

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות המחמם המשולש, בחיזוק המחמם העליון, ונקודות הברך והקרסול.

CA-2 CA-3 CA-4 CA-14 CA-15

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 60, סובלת שנתיים מכאב בשתי הברכיים, שהחמיר במחצית השנה האחרונה, ובייחוד בירידה במדרגות ובכריעה הכאב קשה לנשיאה. בבדיקה: מפרק הברך השמאלית נפוח, שרירי השוק בשני הצדדים מתוחים, ויש רגישות ללחץ בכל הבטן; בשיחה התברר שיש לה קונפליקטים נפשיים רבים עם המשפחה. אבחנה: דלקת במפרק הברך השמאלית. נבחרו נקודות המחמם המשולש, בחיזוק המחמם העליון, ונקודות הברך והקרסול. לאחר הדקירה כאב הברך פחת, ולאחר שלושה טיפולים היא כורעת עד הסוף; נערכו חמישה טיפולים, נפיחות המפרק נעלמה – החלמה קלינית, וגם כאב הבטן הוקל באופן ניכר.

📖 איור 3-9-1-11 · עמ' 240

דלקת במפרק הברך; עווית בשריר הטרפז

הרובד ההולוגרפי · הברך

אבחנה: ① דלקת במפרק הברך השמאלית;

טיפול ותוצאה: בטיפול נבחרו נקודות הכתף ונקודות הברך, וחוזקו.

CA-9 CA-14

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 26, פקידה במשרד, סובלת כמעט שנתיים מכאב במפרק הברך השמאלית, ובמקביל חצי שנה ממתח וכאב בצד שמאל של הצוואר והכתף, עם הגבלה בתנועה. לדבריה, היא רצה ריצה קלה באופן קבוע לאורך זמן, ולפני שנתיים הצטבר נוזל במפרק הברך; לאחר טיפול אצל רופא אורתופד הנפיחות נעלמה בהדרגה והכאב השתפר, אך בעת פעילות עדיין יש כאב, ובייחוד בתרגילי מתיחה של הרגליים ביוגה היא מוגבלת בשל הכאב. בשל הכתיבה התכופה בהישענות קדימה מתוח הצוואר זמן רב. אבחנה: ① דלקת במפרק הברך השמאלית; ② עווית בשריר הטרפז השמאלי. בטיפול נבחרו נקודות הכתף ונקודות הברך, וחוזקו. לאחר הדקירה השרירים נרפו, הכאב פחת ותפקוד התנועה של הברך השתפר; נערכו שלושה טיפולים, תחושת הכאב נעלמה והתנועה תקינה – החלמה קלינית.

📖 איור 4-9-1-11 · עמ' 241

תסמונת הרגליים חסרות המנוחה

הרובד ההולוגרפי · הרגל

אבחנה: תסמונת הרגליים חסרות המנוחה

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות המחמם המשולש ונקודות הברך והקרסול, וחוזקו.

CA-2 CA-3 CA-4 CA-14 CA-15

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 35, סובלת שלושה חודשים מכאב בשתי השוקיים, חמור יותר בצד ימין, והכאב מקרין לעיתים קרובות לכף הרגל, ואחרי פעילות במשך היום התסמינים מוקלים, ובלילה הם מחמירים. בבדיקה: מתח בשרירי השוק בשתי הרגליים. אבחנה: תסמונת הרגליים חסרות המנוחה. נבחרו נקודות המחמם המשולש ונקודות הברך והקרסול, וחוזקו. המתח בשרירי השוק הוקל; המשכנו בעוד שלושה טיפולים, אחד בשבוע, בלילה כבר אין כאב בשוקיים והשינה השתפרה, וחיזקנו עוד פעמיים – הקלה קלינית.

📖 איור 1-10-1-11 · עמ' 241

פגיעה בשריר התאומים

הרובד ההולוגרפי · הרגל

אבחנה: פגיעה בשריר התאומים

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות המחמם המשולש ונקודות הברך והקרסול;

CA-2 CA-3 CA-4 CA-14 CA-15

תיאור המקרה המלא

גבר, בן 16, סובל חצי שנה מעוויתות וכאב חוזרים בשתי השוקיים; תלמיד במגמת ספורט, ובשל אימון יתר נפגעו שרירי השוק, ובדרך כלל הם מתכווצים בקלות. בבדיקה: מתח בבטן עם רגישות קלה ללחץ, ורגישות ללחץ (+++) בשריר התאומים בשני הצדדים. אבחנה: פגיעה בשריר התאומים. נבחרו נקודות המחמם המשולש ונקודות הברך והקרסול; לאחר הדקירה נבדק, ועוויתות שרירי השוק הוקלו, וההליכה כבר אינה כואבת. טיפלנו עוד פעמיים, והמטופל כבר יכול לרוץ שני קילומטרים ללא כל אי-נוחות – החלמה קלינית.

📖 איור 11-1-10-2 · עמ' 242

דלקת בגיד שריר התאומים

הרובד ההולוגרפי · הרגל

אבחנה: דלקת בגיד שריר התאומים

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות הקרסול וחוזקו נקודות;

CA-15

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 41, סובלת שבועיים מכאב בשוק ובקרסול השמאליים. בבדיקה: לחיצה על הקרסול החיצוני כואבת, כפיפה כף-רגלית כואבת ושרירי השוק מתוחים. אבחנה: דלקת בגיד שריר התאומים. נבחרו נקודות הקרסול וחוזקו נקודות; לאחר הטיפול המתח בשרירי השוק נעלם, והכאב בכפיפה כף-רגלית ובפשיטה גבית נעלם. כעבור שבוע נערך טיפול ביסוס נוסף – החלמה קלינית.

📖 איור 11-1-10-3 · עמ' 243

פגיעה בשריר הפרוני הארוך עם כאב במפשעה

הרובד ההולוגרפי · הרגל

אבחנה: פגיעה בשריר הפרוני הארוך הימני

טיפול ותוצאה: נבחרו הנקודות: שתי מחטים מתחת למחמם התחתון, ומחט אחת בכל אחת מנקודות הברך והקרסול.

CA-14 CA-15

תיאור המקרה המלא

גבר, בן 34, סובל שנתיים מכאב במפרק הקרסול הימני שנגרם מאימון ריצה לא נכון. הטיפול אצל רופא המשפחה ורופאים מומחים לא הועיל, והכאב הלך והתפשט למפרק הברך באותו צד ולמפשעה. רופא צרפתי אבחן "פגיעה בשריר הפרוני הארוך הימני", אך הטיפול לא הועיל, והמטופל הופנה למרפאתי. בבדיקה: רגישות ללחץ בשריר הפרוני הארוך הימני, נוקשות בשריר התאומים, ורגישות ללחץ בבור המפרק (פוליטאלי) ובמפשעה. אבחנה: פגיעה בשריר הפרוני הארוך הימני. נבחרו הנקודות: שתי מחטים מתחת למחמם התחתון, ומחט אחת בכל אחת מנקודות הברך והקרסול. המחטים נשארו 20 דקות והכאב פחת באופן ניכר; טיפלנו עוד פעמיים לביסוס, אחד בשבוע – החלמה קלינית.

📖 איור 11-1-10-4 · עמ' 243

דלקת בגיד אכילס (1)

הרובד ההולוגרפי · הרגל

אבחנה: דלקת בגיד אכילס הימני

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות הקרסול, וחוזקו שלוש מחטים בכיוון השוק;

CA-15

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 39, סובלת שלושה שבועות מכאב בשוק ובגיד אכילס בצד ימין, שמחמיר עם הקימה בבוקר ובהליכה ומוקל במנוחה. בבדיקה: רגישות ללחץ בשריר ובגיד בחלק התחתון של השוק ובנקודת האחיזה של גיד אכילס בעצם העקב. אבחנה: דלקת בגיד אכילס הימני. נבחרו נקודות הקרסול, וחוזקו שלוש מחטים בכיוון השוק; במישוש גיד אכילס הכאב המקומי פחת, והמחטים נשארו 20 דקות. נערכו בסך הכול ארבעה טיפולים, אחד בשבוע – החלמה קלינית.

📖 איור 11-1-10-5 · עמ' 244

דלקת בגיד אכילס (2)

הרובד ההולוגרפי · הרגל

אבחנה: דלקת בגיד אכילס הימני

טיפול ותוצאה: נבחרה נקודה מתחת לנקודת הקרסול הימני, ושלוש מחטים באזור השוק הימנית;

CA-15

תיאור המקרה המלא

ילד, בן 12, סובל חמישה חודשים מכאב בגיד אכילס הימני, שנגרם מפעילות ספורטיבית מוגזמת. בבדיקה: רגישות ניכרת ללחץ בקצה התחתון של השוק ובקצה גיד אכילס. אבחנה: דלקת בגיד אכילס הימני. נבחרה נקודה מתחת לנקודת הקרסול הימני, ושלוש מחטים באזור השוק הימנית; הכאב פחת מיד, שרירי השוק נרפו, והוריתי למטופל להפסיק זמנית את הפעילות הספורטיבית. טיפלנו עוד פעמיים, אחד בשבועיים – החלמה קלינית.

📖 איור 11-1-10-6 · עמ' 244

דלקת בגיד אכילס; דלקת בורסה של עצם העקב

הרובד ההולוגרפי · הרגל

אבחנה: ① דלקת בגיד אכילס הימני;

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות הברך והקרסול, וחוזקו שלוש מחטים.

CA-14 CA-15

תיאור המקרה המלא

גבר, בן 45, סובל ארבעה חודשים מכאב בעקב ובגיד אכילס בצד ימין, שמחמיר בהליכה. בבדיקה: שריר התאומים בשוק ימין מתוח ורגיש ללחץ בחלקו האמצעי-תחתון, יש כאב במגע בגיד אכילס (++), ורגישות ללחץ בעצם העקב הימנית (++). אבחנה: ① דלקת בגיד אכילס הימני; ② דלקת בורסה של עצם העקב הימנית. נבחרו נקודות הברך והקרסול, וחוזקו שלוש מחטים. לאחר טיפול אחד הכאב פחת; טיפלנו עוד שלוש פעמים, אחד בשבוע, הכאב נעלם לגמרי וההליכה תקינה – החלמה קלינית.

📖 איור 11-1-10-7 · עמ' 245

פגיעה בגיד השריר הטיביאלי הקדמי; דלקת בגיד אכילס

הרובד ההולוגרפי · הרגל

אבחנה: ① פגיעה בגיד השריר הטיביאלי הקדמי השמאלי;

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות הקרסול השמאלי, וחוזקו שתי נקודות, ובשוק נדקרו שלוש מחטים בנקודות המתאימות ועד לאזור העקב.

CA-15

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 68, סובלת שלושה שבועות מנקע בקרסול השמאלי עם הגבלה בתנועה וקושי בהליכה, וכאב לפני הקרסול הפנימי בעת כפיפה גבית של כף הרגל. בדימות תהודה מגנטית: קרע בגיד השריר הטיביאלי הקדמי. בבדיקה: עווית ורגישות ללחץ בשריר שמעל גיד אכילס. אבחנה: ① פגיעה בגיד השריר הטיביאלי הקדמי השמאלי; ② דלקת בגיד אכילס השמאלי. נבחרו נקודות הקרסול השמאלי, וחוזקו שתי נקודות, ובשוק נדקרו שלוש מחטים בנקודות המתאימות ועד לאזור העקב. המחטים נשארו 20 דקות, כאב הקרסול פחת והמטופלת הולכת בקלילות. המשכנו בשני טיפולי ביסוס, אחד בשבוע – החלמה קלינית.

📖 איור 11-1-10-8 · עמ' 245

תסמונת מורטון

הרובד ההולוגרפי · כף הרגל

אבחנה: תסמונת מורטון דו-צדדית

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות כפות הרגליים משני הצדדים, וחוזקו;

CA-16

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 51, סובלת כשנתיים מכאב בחלק הקדמי של כפות הרגליים, שהחמיר בשלושת החודשים האחרונים, ואינה יכולה לעמוד זמן רב או ללכת למרחקים. בבדיקה: רגישות ללחץ במפרקי המסרקים-בהונות השני והשלישי בצד ימין ובמפרקי המסרקים-בהונות השלישי והרביעי בצד שמאל. בהסתמך על צילום רנטגן ודימות תהודה מגנטית, האבחנה: תסמונת מורטון דו-צדדית. נבחרו נקודות כפות הרגליים משני הצדדים, וחוזקו; לאחר טיפול אחד הכאב פחת, ולאחר חמישה טיפולים נעלם לגמרי – הקלה קלינית. כאשר שרירי השוק נוקשים, יש לדקור בין נקודות הברך והקרסול כדי להרפות את שרירי השוק.

📖 איור 11-1-11-1 · עמ' 245

נקע בקרסול

הרובד ההולוגרפי · כף הרגל

אבחנה: נקע בקרסול החיצוני השמאלי

טיפול ותוצאה: נדקרו נקודות הקרסול בצד שמאל, וחוזקו שתי מחטים; המחטים נשארו 30 דקות נוספות, ובהליכה כבר אין כאב.

CA-15

תיאור המקרה המלא

גבר, בן 19, סובל שבוע מנקע בצד החיצוני של מפרק הקרסול השמאלי בעקבות משחק כדורגל, ובמקביל נדרך על ידי אדם אחר, והליכה כואבת. אבחנה: נקע בקרסול החיצוני השמאלי. נדקרו נקודות הקרסול בצד שמאל, וחוזקו שתי מחטים; המטופל נתבקש לנוע על רגל אחת ולקפוץ, ואין כאב. המחטים נשארו 30 דקות נוספות, ובהליכה כבר אין כאב. נערך טיפול ביסוס אחד – החלמה קלינית.

📖 איור 11-1-11-2 · עמ' 247

כאב במפרק הקרסול; עווית בשרירי הצוואר

הרובד ההולוגרפי · כף הרגל

אבחנה: ① כאב במפרק הקרסול הפנימי הימני;

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות מתאימות בשוק הימנית ונקודות הקרסול, נקודות הצוואר, נקודות הגב ונקודות מחזקות; לאחר הדקירה הכאב פחת, המחטים נשארו 30 דקות, וכעבור שבוע נדקרה שוב – החלמה קלינית.

CA-5 CA-6 CA-15

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 38, סובלת שלושה שבועות מכאב בשוק ובגב כף הרגל, והכאב מופיע בהליכה. יש לה גם כאב בצד ימין של הצוואר, הקשור לעבודה ממושכת מול המחשב, והיא בהריון בחודש הרביעי. בבדיקה: רגישות ללחץ בצד ימין של הצוואר בחוליות C2–5, שריר הטרפז מתוח, אין נפיחות מקומית, יש רגישות ללחץ בשריר הטיביאלי הקדמי הימני ובשרירי הפשט הארוכים של האגודל והבהונות, ואין רגישות ללחץ במותן ובברך. אבחנה: ① כאב במפרק הקרסול הפנימי הימני; ② עווית בשרירי הצוואר. נבחרו נקודות מתאימות בשוק הימנית ונקודות הקרסול, נקודות הצוואר, נקודות הגב ונקודות מחזקות; לאחר הדקירה הכאב פחת, המחטים נשארו 30 דקות, וכעבור שבוע נדקרה שוב – החלמה קלינית. ניתן להשתמש בדיקור הלחי לאחר שלושת החודשים הראשונים להריון, אלא אם כן מדובר בהפלות חוזרות, ובעת הדקירה אין ליצור כל תחושת גירוי.

📖 איור 11-1-11-3 · עמ' 247

תסמונת תעלת הקרסול

הרובד ההולוגרפי · כף הרגל

אבחנה: תסמונת תעלת הקרסול השמאלית

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות המחמם התחתון, העצה, השוק (בחיזוק) וכף הרגל.

CA-4 CA-8 CA-16

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 40, סובלת שמונה חודשים מכאב ומתחושת נפיחות בכף הרגל השמאלית, וכאב לסירוגין, התכווצות ואי-נוחות של נפיחות בכף הרגל ובעקב. בבדיקה: רגישות ללחץ בבטן התחתונה השמאלית, המשוכה אל המפשעה, מתח ורגישות ללחץ בשריר התאומים בשוק, ורגישות בצד הפנימי של הקרסול השמאלי, המקרינה אל כף הרגל. אבחנה: תסמונת תעלת הקרסול השמאלית. נבחרו נקודות המחמם התחתון, העצה, השוק (בחיזוק) וכף הרגל. לאחר הדקירה פחתה הרגישות ללחץ בבטן השמאלית, בשוק ובקרסול; טיפלנו עוד שלוש פעמים באותה שיטה, כאב כף הרגל השמאלית ותחושת הנפיחות נעלמו לגמרי – החלמה קלינית.

📖 איור 11-1-11-4 · עמ' 247

שיעול ממקור לא ידוע

מחלות המחמם המשולש

אבחנה: שיעול ממקור לא ידוע

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות המחמם המשולש משני הצדדים, וחוזקו נקודות המחמם האמצעי והתחתון בצד ימין.

CA-2 CA-3 CA-4

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 58, סובלת כשנה משיעול; נטילת אנטיביוטיקה וסירופ נגד שיעול לא הועילה באופן ניכר. המטופלת מעשנת 30 שנה, הרופא הורה לה להפסיק לעשן, ולאחר ההפסקה עדיין לא חל שיפור ניכר. בבדיקה: תחושת מלאות בבטן וכאב בבטן התחתונה הימנית. אבחנה: שיעול ממקור לא ידוע. נבחרו נקודות המחמם המשולש משני הצדדים, וחוזקו נקודות המחמם האמצעי והתחתון בצד ימין. בבדיקת מעקב כעבור שבוע השיעול פחת באופן ניכר ונפח הריאות גדל; המשכנו בשלושה טיפולים, אחד בשבוע, והמטופלת כבר אינה משתעלת – הקלה קלינית.

📖 איור 11-2-1 · עמ' 249

דלקת הפאשיה של הגב והמותן; כאבי מחזור

מחלות המחמם המשולש

אבחנה: ① דלקת הפאשיה של הגב והמותן;

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות המחמם האמצעי והתחתון, וחוזקה מחט אחת, ונדקרו נקודות המותן, הגב והכתף בדקירה חודרת.

CA-3 CA-4 CA-6 CA-7 CA-9

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 31, סובלת חודשיים לאחר לידה מכאב בגב ובמותן בצד שמאל, שהולך ומחמיר; הכאב מתחיל בגב התחתון השמאלי ומתפשט כלפי מעלה אל הגב והצוואר, ויש גם כאב ואי-נוחות בכתף ובמרפק השמאליים. בעבר סבלה מכאבי מחזור, ובגיל ההתבגרות הייתה בעיה רגשית שנבעה מסכסוכים במשפחה. בבדיקה: רגישות ללחץ בבטן התחתונה השמאלית. אבחנה: ① דלקת הפאשיה של הגב והמותן; ② כאבי מחזור. נבחרו נקודות המחמם האמצעי והתחתון, וחוזקה מחט אחת, ונדקרו נקודות המותן, הגב והכתף בדקירה חודרת. לאחר טיפול אחד כאב הגב, המותן והכתף פחת; המשכנו בארבעה טיפולים, כאב הגב, המותן והכתף והכאב בבטן נעלמו – החלמה קלינית.

📖 איור 11-2-2 · עמ' 249

הפרעה תפקודית עצבית של מערכת העיכול

מחלות המחמם המשולש

אבחנה: הפרעה תפקודית עצבית של מערכת העיכול

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות הראש בדיקור הלחי, בחיזוק, ונקודות המחמם המשולש.

CA-1 CA-2 CA-3 CA-4

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 62, סובלת שלוש שנים מכאבי בטן חוזרים, בליווי תחושת אי-נוחות ורעב בקיבה, חומציות, תחושת צריבה במעי הושט, כאב גב, נדודי שינה והתרגשות רגשית. לאחר שיחה מפורטת, בשילוב היפנותרפיה, התברר שאביה מת בגיל 62 מסרטן הערמונית שהתפשט בגרורות לבטן ולריאות, והתת-מודע של המטופלת סבר שגם היא קרובה למותה, ולכן התסמינים הלכו והחמירו שוב ושוב. אבחנה: הפרעה תפקודית עצבית של מערכת העיכול. נבחרו נקודות הראש בדיקור הלחי, בחיזוק, ונקודות המחמם המשולש. לאחר הטיפול המתח והרגישות ללחץ בבטן פחתו בהדרגה, ובמקביל נערכה הכוונה נפשית כדי שהמטופלת תבין שמותו של אביה והמחלה אינם קשורים אליה בשום קשר תורשתי, ולנתק לחלוטין את ההשפעה הרעה שהופיעה בתת-מודע. לאחר שלושה טיפולים התסמינים הקליניים נעלמו בעיקרם; לאחר מכן נערך טיפול סדיר, פעם בחודש, כטיפול שימור, בסך הכול חצי שנה, ותסמיני מערכת העיכול של המטופלת לא חזרו – הקלה קלינית.

📖 איור 11-2-3 · עמ' 249

דלקת בחצוצרות עם כאב בטן

מחלות המחמם המשולש

אבחנה: דלקת בחצוצרות עם כאב בבטן השמאלית

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות המחמם המשולש משני הצדדים, ובמחמם התחתון השמאלי נוספו שתי מחטים מחזקות.

CA-2 CA-3 CA-4

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 42, סובלת חצי שנה מכאב בגב התחתון בצד שמאל ואינה מסוגלת להתכופף. בבדיקה: רגישות ללחץ באזור המותן השמאלי, ורגישות ניכרת ללחץ במפשעה באותו צד; המטופלת מספרת על כאב בחצוצרה השמאלית בהקשר גינקולוגי. אבחנה: דלקת בחצוצרות עם כאב בבטן השמאלית. נבחרו נקודות המחמם המשולש משני הצדדים, ובמחמם התחתון השמאלי נוספו שתי מחטים מחזקות. לאחר הטיפול כאב הגב התחתון פחת וההתכופפות השתפרה; טיפלנו אחת לשבוע, ולאחר ארבעה טיפולים התסמינים נעלמו לגמרי, הרגישות ללחץ במפשעה ובבטן התחתונה השמאלית נעלמה – החלמה קלינית.

📖 איור 11-2-4 · עמ' 251

בקע סרעפתי

מחלות המחמם המשולש

אבחנה: בקע סרעפתי

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות המחמם המשולש, וחוזק המחמם האמצעי.

CA-2 CA-3 CA-4

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 42, סובלת כמעט שלושה חודשים מאי-נוחות צורבת בבטן העליונה-אמצעית ומתחושת מלאות בבטן השמאלית, בליווי נדודי שינה. בבדיקה: מלאות באזור הקיבה ובבטן השמאלית, וכאב בלחיצה. בגסטרוסקופיה האבחנה: בקע סרעפתי. נבחרו נקודות המחמם המשולש, וחוזק המחמם האמצעי. לאחר הדקירה הבטן נעשתה רכה יותר והרגישות ללחץ פחתה. המשכנו בארבעה טיפולים, אחד בשבוע, התסמינים נעלמו בעיקרם – הקלה קלינית. מחלות של מערכת העיכול קשורות לעיתים קרובות למצב הרוח, ולכן יש לתת להן תשומת לב ולהעניק הכוונה נפשית, ובשילוב עם הטיפול התוצאה טובה יותר.

📖 איור 11-2-5 · עמ' 251

תסמונת המעי הרגיז

מחלות המחמם המשולש

אבחנה: תסמונת המעי הרגיז

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות המחמם המשולש משני הצדדים, נקודות הצוואר בדקירה חודרת אל נקודות הראש, וחוזקה נקודה אחת.

CA-1 CA-2 CA-3 CA-4 CA-5

תיאור המקרה המלא

גבר, בן 44, סובל עשר שנים מכאב בבטן הימנית, בליווי נפיחות בטן, שלשול ועצירות. פניו נוטות באופן ניכר לצד ימין. כאב הבטן הופיע בזמן שנולד בנו הבכור; הוא מספר שכשהיה אב טרי היה מתוח וחרד מאוד, וחשש שהבן לא ישרוד, ואביו של המטופל סבל מדיכאון. בבדיקת קולונוסקופיה בבית החולים לא נמצאה כל חריגה, אך המטופל סובל כבר עשר שנים מכאבי בטן חוזרים, והטיפול התרופתי לא הועיל באופן ניכר. בבדיקה: כאב מעל ומתחת לטבור בצד ימין, המטופל מסרב ללחיצה ויש התנגדות. אבחנה: תסמונת המעי הרגיז. נבחרו נקודות המחמם המשולש משני הצדדים, נקודות הצוואר בדקירה חודרת אל נקודות הראש, וחוזקה נקודה אחת. לאחר הדקירה הרגישות ללחץ בבטן פחתה, והמחטים נשארו 30 דקות. לאחר מכן טופל באותה שיטה בסך הכול עשר פעמים, כאב הבטן נעלם והיציאות תקינות – החלמה קלינית.

📖 איור 11-2-6 · עמ' 252

דלקת כרונית של שלפוחית השתן

מחלות המחמם המשולש

אבחנה: דלקת כרונית של שלפוחית השתן

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות המחמם האמצעי והתחתון בדקירה שטחית, וחוזקה נקודה אחת, ולאחר מכן נקודות המחמם התחתון בדקירה בעומק בינוני, וחוזקה נקודה אחת.

CA-3 CA-4

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 66, סובלת שלוש שנים משתן תכוף, דחיפות במתן שתן וכאב בעת השתנה, בהתקפים חוזרים. אבחנה: דלקת כרונית של שלפוחית השתן. נבחרו נקודות המחמם האמצעי והתחתון בדקירה שטחית, וחוזקה נקודה אחת, ולאחר מכן נקודות המחמם התחתון בדקירה בעומק בינוני, וחוזקה נקודה אחת. הטיפול אחד בשבוע; לאחר שלושה טיפולים תדירות ההתקפים פחתה, ונמשכו עוד חמישה טיפולים, אחד בשלושה שבועות, ולאחר שלושה חודשים ההתקפים פסקו בעיקרם – החלמה קלינית.

📖 איור 11-2-7 · עמ' 253

דלקת כרונית של בלוטת הערמונית

מחלות המחמם המשולש

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות המחמם המשולש, וחוזק המחמם התחתון. לאחר שלושה טיפולים ירד מספר ההשתנות ללילה לשתיים-שלוש, ולאחר שמונה טיפולים נוספים נשמר על אחת עד שתיים בלילה – הקלה קלינית.

CA-2 CA-3 CA-4

תיאור המקרה המלא

גבר, בן 72, מתעורר לעיתים קרובות בלילה להשתנה, ארבע עד חמש פעמים בכל לילה; אבחנת רופא האורולוגיה: דלקת כרונית של בלוטת הערמונית. נבחרו נקודות המחמם המשולש, וחוזק המחמם התחתון. לאחר שלושה טיפולים ירד מספר ההשתנות ללילה לשתיים-שלוש, ולאחר שמונה טיפולים נוספים נשמר על אחת עד שתיים בלילה – הקלה קלינית.

📖 איור 11-2-8 · עמ' 253

דלקת כרונית של רירית הקיבה

מחלות המחמם המשולש

אבחנה: דלקת כרונית של רירית הקיבה

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות המחמם האמצעי והתחתון, וחוזקה מחט אחת בין שתי הנקודות.

CA-3 CA-4

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 38, סובלת כמעט שלוש שנים מכאב חוזר בקיבה ומחומציות, בליווי תסמינים כמו חומצה בקיבה, תחושת חום צורב ונפיחות בטן; ההתקפים חוזרים לעיתים קרובות בהשפעת גורמים כמו רגשות ומתח בעבודה. לדבריה, בגיל ההתבגרות היו בעיות במשפחה והיחסים עם ההורים היו מתוחים כל הזמן. בבדיקה: רגישות ללחץ בבטן העליונה-אמצעית ובבטן התחתונה. אבחנה: דלקת כרונית של רירית הקיבה. נבחרו נקודות המחמם האמצעי והתחתון, וחוזקה מחט אחת בין שתי הנקודות. לאחר הטיפול כאב הבטן, החומצה ותחושת החום הצורב פחתו; טיפלנו עוד חמש פעמים, אחד בשלושה שבועות, התסמינים נעלמו בעיקרם והמצב הרגשי הלך והתייצב – הקלה קלינית.

📖 איור 11-2-9 · עמ' 254

סיבוך לאחר אבלציה בגלי רדיו

מחלות המחמם המשולש

אבחנה: סיבוך לאחר אבלציה בגלי רדיו

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות המחמם העליון, המחמם האמצעי ונקודות הגב, וחוזקו;

CA-2 CA-3 CA-6

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 48, סובלת יותר משמונה חודשים מכאב מתחת לסרעפת בצד שמאל, ואינה מסוגלת לשכב שטוחה. בסוף 2015 אושפזה בשל קצב לב מהיר ועברה אבלציה בגלי רדיו; לאחר הניתוח הדפיקות פחתו, אך מתחת לבליטת עצם החזה (תהליך הקסיפואיד) בצד שמאל היא חשה כאב ואי-נוחות, אינה יכולה לשכב שטוחה, בשכיבה שטוחה יש כאב משיכה, בליווי בחילה והקאות, והיא נאלצת לישון בישיבה, בליווי חרדה וחוסר שקט. בבדיקה: מלאות ורגישות ללחץ מתחת לתהליך הקסיפואיד ובבטן השמאלית, קצב הלב 84 פעימות בדקה, ללא הפרעת קצב. אבחנה: סיבוך לאחר אבלציה בגלי רדיו. נבחרו נקודות המחמם העליון, המחמם האמצעי ונקודות הגב, וחוזקו; לאחר הדקירה הכאב פחת והיא יכולה לשכב שטוחה. המחטים נשארו עוד 30 דקות, אזור הקיבה והבטן נרגע והרגישות ללחץ נעלמה. כעבור שבועיים טופלה שוב, וכבר אין כל אי-נוחות והחרדה השתפרה; חיזקנו עוד פעמיים – החלמה קלינית.

📖 איור 11-2-10 · עמ' 255

כאב סיבי שרירים בצוואר ובגב

מחלות גוף-נפש

אבחנה: כאב סיבי שרירים בצוואר ובגב

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודת הצוואר (CA-5) ונקודת הגב (CA-6), ונוספו שתי מחטים לפני נקודת הצוואר ומתחתיה, ומחט אחת מתחת לנקודת הגב.

CA-5 CA-6

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 41, מתלוננת על כאב בגב שנתיים, שמחמיר לאחר עייפות ומתח. בבדיקה: רגישות ללחץ בנקודות רבות בצוואר, בגב ובמותן. אבחנה: כאב סיבי שרירים בצוואר ובגב. נבחרו נקודת הצוואר (CA-5) ונקודת הגב (CA-6), ונוספו שתי מחטים לפני נקודת הצוואר ומתחתיה, ומחט אחת מתחת לנקודת הגב. המחטים נשארו 45 דקות, ובמהלכן המטופלת נרדמה, ולאחר שהתעוררה הייתה רגועה מאוד; הרגישות ללחץ והכאב הסובייקטיבי נעלמו. הוריתי לה להגיע לטיפול פעם בחודש, כדי למנוע הצטברות מתח שתגרום לדלקת סיבי שרירים כרונית; נערכו בסך הכול שישה טיפולים – החלמה קלינית.

📖 איור 11-3-1 · עמ' 256

נוירלגיה של העצב העורפי הגדול; כאב כתף ממקור צווארי; הפרעת חרדה

מחלות גוף-נפש

אבחנה: ① נוירלגיה של העצב העורפי הגדול;

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות הצוואר, וחוזקו שתי נקודות, וכן נקודות המחמם המשולש, וחוזקה מחט אחת במחמם התחתון.

CA-2 CA-3 CA-4 CA-5

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 39, סובלת שלושה חודשים מכאב בצד ימין של הצוואר, המקרין לראש ולכתף, בליווי חרדה רגשית וחוסר מנוחה. בעלה רופא פנימאי נתן לה תרופות נוגדות דלקת ומשככות כאב, שהקלו מעט, אך בשל צריבה וחומציות בקיבה היא אינה מסוגלת לשאת תרופות מערביות, והופנתה אליי לטיפול. בבדיקה: נוקשות בצד ימין בחוליות C1–6, כאב כבר במגע קל, המקרין לראש ולכתף, והרמת הכתף כואבת. הבטן נוקשה, ברגישות ניכרת ללחץ בבטן הימנית לצד הטבור, ובלחיצה עמוקה יש התנגדות; הערכתי שהדבר קשור למצב הרגשי. המטופלת מספרת שאביה נפטר לא מזמן והיא עצובה מאוד, אינה שבעת רצון מהלימודים של ילדה, ולאחר ריב מילולי פתאום הופיעו כאב ראש וכאב צוואר. אבחנה: ① נוירלגיה של העצב העורפי הגדול; ② כאב כתף ממקור צווארי; ③ הפרעת חרדה. נבחרו נקודות הצוואר, וחוזקו שתי נקודות, וכן נקודות המחמם המשולש, וחוזקה מחט אחת במחמם התחתון. המחטים נשארו 40 דקות. הרגישות ללחץ בצוואר פחתה, הכאב בכתף אינו ניכר, והרגישות ללחץ בבטן פחתה. טיפלנו כך שלוש פעמים, אחת לשבוע, כאב הראש, הצוואר והכתף נעלם, מצב הרוח נרגע לגמרי, והיא סבלנית מאוד כלפי הילד והבעל, ומספרת שמצאה מחדש את תחושת האושר בחיים.

📖 איור 11-3-2 · עמ' 256

עייפות יתר של שרירי המותן; הפרעת חרדה

מחלות גוף-נפש

אבחנה: ① עייפות יתר של שרירי המותן;

טיפול ותוצאה: בטיפול נבחרו נקודות המחמם המשולש ונקודות המותן, וחוזקו המותן והמחמם התחתון.

CA-2 CA-3 CA-4 CA-7

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 52, סובלת שלושה חודשים מכאב בצד שמאל של המותן ובצד החיצוני של הירך, בליווי מתח וחרדה (בשל עבודה). בבדיקה: רגישות ללחץ בגב התחתון השמאלי, רגישות ללחץ במפשעה, ומתח ורגישות ללחץ בכל הבטן. אבחנה: ① עייפות יתר של שרירי המותן; ② הפרעת חרדה. בטיפול נבחרו נקודות המחמם המשולש ונקודות המותן, וחוזקו המותן והמחמם התחתון. לאחר הטיפול כאב המותן פחת, וכעבור שבוע כמעט ללא תסמינים; טיפלנו עוד שלוש פעמים באותה שיטה – כאב המותן החלים קלינית.

📖 איור 11-3-3 · עמ' 257

הפרעת חרדה (1)

מחלות גוף-נפש

אבחנה: הפרעת חרדה (תסמונת תגובת דחק לאחר טראומה)

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות המחמם המשולש, והמחטים נשארו 40 דקות;

CA-2 CA-3 CA-4

תיאור המקרה המלא

ילדה, בת 8, סובלת שלושה שבועות מחרדה, עצב וחוסר יציבות רגשית; לאחר פיגוע הטרור בפריז הרגישה אהדה רבה כלפי הנספים, ושקעה באבל ללא יכולת להשתחרר ממנו. בבדיקה: מתח בכל הבטן, רגישות ללחץ (++). אבחנה: הפרעת חרדה (תסמונת תגובת דחק לאחר טראומה). זו תלמידה רגישה ונבונה מאוד, עם יכולת הבנה יוצאת דופן והישגים לימודיים טובים מאוד; לפני שנתיים החלימה אצלי מאקזמה, והפעם הגיעה בשל חוסר היציבות הרגשית. נבחרו נקודות המחמם המשולש, והמחטים נשארו 40 דקות; במהלכן ישנה שינה עמוקה, ולאחר שהתעוררה הרגישה רגועה מאוד ורצתה במיוחד לשיר; בלחיצה הבטן הייתה רכה, והטיפול הסתיים. כעבור שבוע סיפרו ההורים שמצבה הרגשי של הילדה חזר לתקינותו.

📖 איור 11-3-4 · עמ' 258

הפרעת חרדה (2)

מחלות גוף-נפש

אבחנה: הפרעת חרדה

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות המחמם המשולש, וחוזק המחמם העליון;

CA-2 CA-3 CA-4

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 32, סובלת חודשיים ממתח וחרדה; בשל מתח בעבודה, ובנוסף אחותה הרחוקה ביפן מאושפזת בשל דיכאון וגם בריאותה של האם אינה טובה, נגרמו למטופלת מתח ונדודי שינה. בבדיקה: מלאות בבטן, וכאב מתחת לתהליך הקסיפואיד עם סירוב ללחיצה. אבחנה: הפרעת חרדה. נבחרו נקודות המחמם המשולש, וחוזק המחמם העליון; המחטים נשארו 30 דקות, כל הבטן נעשתה רכה והמטופלת חשה רגועה מאוד. נערכו שמונה טיפולים ברציפות, אחד בשבועיים – הקלה קלינית.

📖 איור 11-3-5 · עמ' 258

הפרעת חרדה (3)

מחלות גוף-נפש

אבחנה: הפרעת חרדה

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות המחמם המשולש ונקודות הראש, בשילוב נקודות הצוואר, הגב, המותן והעצה, ובמהלך הטיפול נערכה הכוונה נפשית.

CA-1 CA-2 CA-3 CA-4 CA-5 CA-6 CA-7 CA-8

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 21, הגיעה לטיפול לאחר שלושה חודשים של חרדה וחוסר מנוחה שהתעוררו בשל לחץ לימודים ומבחנים בבית הספר. בחודשים האחרונים היא רגשנית מאוד, סובלת מנדודי שינה, פסימית, חסרת ביטחון עצמי, נרגשת בקלות ובוכה בקלות. המטופלת הגיעה בליווי אמה, ובשיחה פרטית עם האם התברר שהמטופלת מעולם לא פגשה את אביה הביולוגי, והדבר יצר אצלה מצוקה ממושכת; מכיוון שהיא סבורה שאינה מצטיינת מספיק, אביה אינו רוצה לפגוש אותה, ובמשך זמן רב היא משתדלת מאוד, ומצטיינת בלימודים ובהתנהגות. כשהלימודים אינם מתקדמים כשורה היא חרדה ובלתי רגועה במיוחד, סובלת מנדודי שינה, חשה טיפשה וחסרת יכולת, ולעיתים חשה ייאוש מוחלט. בבדיקה: מתח בשרירי הצוואר, הגב, המותן והישבן ורגישות מקומית ללחץ, וצומת של צ'י בצד ימין התחתון של הבטן. אבחנה: הפרעת חרדה. נבחרו נקודות המחמם המשולש ונקודות הראש, בשילוב נקודות הצוואר, הגב, המותן והעצה, ובמהלך הטיפול נערכה הכוונה נפשית. המטופלת בכתה במשך 20 דקות. בבדיקת המעקב השנייה כעבור שבוע השינה השתפרה באופן ניכר, לעיתים היא מתעוררת באמצע אך נרדמת שוב בקלות רבה, והמצב הרגשי יציב יחסית. לאחר מכן הגיעה פעם בשבועיים-שלושה, בסך הכול חמש פעמים; צומת הצ'י בבטן הימנית נעלמה – הקלה קלינית. בכל טיפול נערכה הכוונה נפשית, והוריתי למטופלת להגיע לטיפול מניעתי בדיקור כשהיא חשה לחץ רב, חוסר יציבות רגשית או מתח בגב ובמותן.

📖 איור 11-3-6 · עמ' 259

הפרעת חרדה (4)

מחלות גוף-נפש

אבחנה: הפרעת חרדה (תסמונת תגובת דחק לאחר טראומה)

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות המחמם המשולש ונקודות הראש.

CA-1 CA-2 CA-3 CA-4

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 48, סובלת חמישה ימים מהחמרה בחרדה, פחד ועצב. לפני ארבעה חודשים, ב-17 בנובמבר 2015, אירע פיגוע הטרור בפריז סמוך לביתה, ובעקבותיו נספתה חברה קרובה, והופיעו רגשות של חרדה, פחד ועצב; ב-22 במרץ 2016 אירע פיגוע טרור בבריסל שבבלגיה, מולדתה, והדבר עורר שוב חרדה ופחד. בבדיקה: נוקשות בצוואר ומלאות בכל הבטן. אבחנה: הפרעת חרדה (תסמונת תגובת דחק לאחר טראומה). נבחרו נקודות המחמם המשולש ונקודות הראש. המחטים נשארו 40 דקות, ובמהלכן המטופלת בכתה בעצמה ושחררה את הרגשות הקשים; בעת הוצאת המחטים היא כבר רגועה בהרבה והכאב בצוואר נעלם. כעבור שבוע טופלה שוב, מצבה הרגשי יציב, ולאחר שלושה טיפולים – הקלה קלינית.

📖 איור 11-3-7 · עמ' 260

הפרעת חרדה; כאב באזור הקיבה

מחלות גוף-נפש

אבחנה: ① הפרעת חרדה (תסמונת תגובת דחק לאחר טראומה);

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות המחמם המשולש ונקודות הצוואר, וחוזקה נקודה בין הצוואר לכתף;

CA-2 CA-3 CA-4 CA-5

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 28, סובלת שלושה שבועות מנפיחות וכאב ואי-נוחות באזור הקיבה, בליווי כאב צוואר ומתח וחרדה רגשית, שהתעוררו בעקבות אירוע הטרור בפריז. בבדיקה: רגישות ללחץ ב-C2–5, רגישות ללחץ בשריר הטרפז משני הצדדים, ורגישות ללחץ מתהליך הקסיפואיד ועד לאזור שמעל הטבור. אבחנה: ① הפרעת חרדה (תסמונת תגובת דחק לאחר טראומה); ② כאב באזור הקיבה. נבחרו נקודות המחמם המשולש ונקודות הצוואר, וחוזקה נקודה בין הצוואר לכתף; לאחר הדקירה הכאב והרגישות ללחץ באזור הקיבה פחתו, והרגישות ללחץ בצוואר ובכתף הוקלה. המחטים נשארו 30 דקות, ולאחר הוצאתן הכאב בקיבה ובצוואר נעלם. חיזקנו עוד ארבע פעמים, אחת לשבועיים – הקלה קלינית.

📖 איור 11-3-8 · עמ' 260

תסמונת הצוואר והמותן

מחלות גוף-נפש

אבחנה: תסמונת הצוואר והמותן

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות המחמם המשולש משני הצדדים ונקודות הצוואר, הגב, המותן והעצה.

CA-2 CA-3 CA-4 CA-5 CA-6 CA-7 CA-8

תיאור המקרה המלא

גבר, בן 43, סובל כשלוש שנים מכאב ונוקשות במותן ובצוואר, שהתסמינים מחמירים בכל פעם שהוא עייף ומתוח. במחצית השנה האחרונה המותן נעשתה נוקשה בהדרגה, והתכופפות קדימה היא רק כ-40°–50°. אבחנה: תסמונת הצוואר והמותן. נבחרו נקודות המחמם המשולש משני הצדדים ונקודות הצוואר, הגב, המותן והעצה. לאחר חמישה טיפולים ההתכופפות 90°, תנועת הצוואר לצדדים גמישה ומצב הרוח רגוע יחסית – הקלה קלינית.

📖 איור 11-3-9 · עמ' 260

התמכרות לקנאביס

מחלות גוף-נפש

אבחנה: התמכרות לקנאביס

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות הראש, בחיזוק, נקודות המחמם המשולש ונקודות הצוואר והגב, ובכל טיפול חל שיפור.

CA-1 CA-2 CA-3 CA-4 CA-5 CA-6

תיאור המקרה המלא

גבר, בן 28, מעשן קנאביס שש שנים, ומקווה שהדיקור יוכל לעזור לו להיגמל. לפני שש שנים, בשל התאבדות אחיו הצעיר, סבל מכאב נפשי בלתי נסבל והחל לעשן קנאביס, ולאחר מכן, בשל לחץ בעבודה ודאגות במשפחה, לא הצליח להיגמל. בבדיקה: מתח ורגישות ניכרת ללחץ בצוואר, בגב ובמותן, מלאות בבטן ומתח רב בבטן התחתונה הימנית. אבחנה: התמכרות לקנאביס. נבחרו נקודות הראש, בחיזוק, נקודות המחמם המשולש ונקודות הצוואר והגב, ובכל טיפול חל שיפור. לאחר ארבעה טיפולים אפשר היה לשלוט במצב בעיקרו, והוא חדל לעשן קנאביס; חיזקנו עוד שלוש פעמים, בשילוב הכוונה נפשית, והוא נגמל כעת לגמרי, ורגשות האשמה והעצב נרגעו. לאחר מכן הגיע פעם בחודש, ולאחר חצי שנה מצבו הרגשי יציב, יחסו לחיים חיובי, והוא כבר אינו מוטרד מקנאביס.

📖 איור 11-3-10 · עמ' 262

כאב כרוני בגב התחתון

מחלות גוף-נפש

אבחנה: כאב כרוני בגב התחתון

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות המחמם האמצעי והתחתון משני הצדדים, וחוזקה מחט אחת;

CA-3 CA-4

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 46, סובלת שנתיים מכאב חוזר בגב התחתון. במותן יש לעיתים קרובות תחושת כובד, ללא כאב מקרין לגפיים התחתונות. בליווי נוקשות, מלאות וכאב בבטן התחתונה. למטופלת לחץ רב בעבודה ובמקביל בעיות במשפחה, והיא נמצאת זמן רב במצב מתמשך של מתח. בבדיקה: רגישות קלה ללחץ בתהליכים הקוצניים L4–5. אבחנה: כאב כרוני בגב התחתון. נבחרו נקודות המחמם האמצעי והתחתון משני הצדדים, וחוזקה מחט אחת; המחטים נשארו 30 דקות, ובעת הוצאתן המלאות בבטן התפזרה, הרגישות ללחץ פחתה באופן ניכר, וכשהמטופלת קמה ותנועה את המותן הרגישה רגועה מאוד והכאב כבר אינו ניכר. נערכו ארבעה טיפולי ביסוס, אחד בשבוע, ולאחר חודש כאב המותן נעלם לגמרי; חיזקנו עוד שלוש פעמים – החלמה קלינית.

📖 איור 11-3-11 · עמ' 262

דיכאון; דלקת סיבי שרירים כרונית

מחלות גוף-נפש

אבחנה: ① דיכאון;

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות המחמם המשולש משני הצדדים, נקודות הצוואר ונקודות הראש.

CA-1 CA-2 CA-3 CA-4 CA-5

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 19, מתלוננת על עייפות ומצב רוח ירוד במשך חצי שנה. רופא פסיכיאטר אבחן: דיכאון, ורשם טיפול בתרופות נוגדות דיכאון; המטופלת אינה מוכנה לטיפול תרופתי ופנתה לדיקור. בשל לחץ לימודים רב, נדודי שינה ממושכים ובעיות משפחתיות, נפטר פתאום סבה מצד האם. מכיוון שהוריה נפרדו בגיל צעיר, הסב היה בבחינת דמות אב, מצב רוחה כבד מאוד, והיא עצובה ומדוכדכת, וכעת הפסיקה את לימודיה. בבדיקה: נוקשות במותן ובצוואר, כאב ומלאות בבטן. אבחנה: ① דיכאון; ② דלקת סיבי שרירים כרונית. נבחרו נקודות המחמם המשולש משני הצדדים, נקודות הצוואר ונקודות הראש. לאחר שישה טיפולים הכאב והנוקשות בצוואר ובמותן נעלמו, והמלאות באזור הקיבה והבטן נרגעה. מצב רוחה רגוע מכפי שהיה, התגובה לאירועים אינה חריפה כל כך, והיא מסוגלת לחשוב על הדברים בכיוון חיובי – הקלה קלינית.

📖 איור 11-3-12 · עמ' 263

כאב ראש מתחי

מחלות גוף-נפש

אבחנה: כאב ראש מתחי

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות המחמם המשולש, נקודות הצוואר, וחוזקה מחט אחת, ונקודות הראש;

CA-1 CA-2 CA-3 CA-4 CA-5

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 29, סובלת עשר שנים מכאב ראש חוזר, וכמעט בכל בוקר מופיע כאב באזור המצח. יש בעיות במשפחה ולחץ בעבודה; מתח, עייפות או אלכוהול יכולים לעורר אותו, והגורם הרגשי הוא אחד החשובים ביותר. בבדיקה: מתח ורגישות ללחץ בצוואר, רגישות מקומית ללחץ, ומלאות ורגישות ללחץ בכל הבטן. אבחנה: כאב ראש מתחי. נבחרו נקודות המחמם המשולש, נקודות הצוואר, וחוזקה מחט אחת, ונקודות הראש; לאחר הטיפול המתח בצוואר ובבטן פחת וכאב הראש הוקל. נערכו בסך הכול עשרה טיפולים, כאב הראש התייצב בעיקרו, ויש בו אחת עד שתיים התקפות בחודש, שמסתיימות בתוך עשר דקות עד חצי שעה. לאחר מכן הוריתי למטופלת לבוא פעם בחודש להפחתת לחץ בדיקור, שיכול להביא להקלה קלינית בכאב ראש כרוני.

📖 איור 11-3-13 · עמ' 264

נדודי שינה

מחלות גוף-נפש

אבחנה: נדודי שינה

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות המחמם המשולש ונקודות הראש.

CA-1 CA-2 CA-3 CA-4

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 46, סובלת זמן רב מנדודי שינה, לעיתים כאב ראש, קושי להירדם והתעוררות מוקדמת בקלות. יש לה בעיות בעבודה ובמשפחה. בבדיקה: מלאות בכל הבטן ורגישות ללחץ, ואין תסמינים ניכרים במערכת העיכול. אבחנה: נדודי שינה. נבחרו נקודות המחמם המשולש ונקודות הראש. לאחר שלושה טיפולים היא ישנה כשש שעות, מצב הרוח השתפר והמלאות בבטן פחתה; לאחר מכן מטופלת פעם בחודש – הקלה קלינית.

📖 איור 11-3-14 · עמ' 265

כאב מרפק ממקור צווארי; הפרעת חרדה

מחלות גוף-נפש

אבחנה: ① כאב מרפק ימין ממקור צווארי;

טיפול ותוצאה: הנקודות שנבחרו: נקודות המחמם המשולש, נקודות הצוואר ונקודות המרפק, וחוזקו נקודות הצוואר.

CA-2 CA-3 CA-4 CA-5 CA-10

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 33, סובלת ארבעה חודשים מכאב בצד החיצוני של המרפק הימני, שמחמיר בנשיאת חפצים ובתנוחת שינה לא טובה. בבירור ההיסטוריה המטופלת מכחישה פגיעה בעבר, ובשנתיים האחרונות היא חרדה לעיתים קרובות בשל בעיות בעבודה ובמשפחה. בדימות תהודה מגנטית: קשת חוליות הצוואר מיושרת, ובקע דיסק בין חוליות הצוואר C5–6. בבדיקה: רגישות ללחץ בקטע הצווארי, חמורה יותר בצד ימין, ורגישות ללחץ במפרק המרפק הימני. אבחנה: ① כאב מרפק ימין ממקור צווארי; ② הפרעת חרדה. הנקודות שנבחרו: נקודות המחמם המשולש, נקודות הצוואר ונקודות המרפק, וחוזקו נקודות הצוואר. נערכו בסך הכול חמישה טיפולים, אחד בשבוע; מצב החרדה השתפר באופן ניכר, וכאב הצוואר והמרפק נעלם – הקלה קלינית.

📖 איור 11-3-15 · עמ' 265

אקזמה באוזן

מחלות גוף-נפש

אבחנה: אקזמה באוזן

טיפול ותוצאה: הנקודות שנבחרו: נקודות המחמם המשולש ונקודות הראש, וחוזק המחמם האמצעי.

CA-1 CA-2 CA-3 CA-4

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 45, סובלת חודשיים מאקזמה בתוך תנוך האוזן הימנית (בחלל האפרכסת), בליווי חרדה וחוסר יציבות רגשית. היו לה התקפות גם לפני חמש שנים ולפני שנתיים. המטופלת נתונה זמן רב למתח בעבודה, נטל המשפחה כבד, בעלה מובטל חצי שנה, מצב רוחה נרגז יותר, ולעיתים קרובות היא חשה אי-נוחות בקיבה, תחושת רעב ובקיעת גזים. אבחנה: אקזמה באוזן. הנקודות שנבחרו: נקודות המחמם המשולש ונקודות הראש, וחוזק המחמם האמצעי. נערכו ארבעה טיפולי דיקור, אחד בשבועיים; מצב הרוח של המטופלת הירגע, ותסמיני הקיבה והאקזמה באוזן נעלמו – הקלה קלינית.

📖 איור 11-3-16 · עמ' 266

שלבקת חוגרת בראש ובפנים

מחלות גוף-נפש

אבחנה: שלבקת חוגרת בראש ובפנים

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות המחמם המשולש משני הצדדים ונקודות הצוואר בצד ימין.

CA-2 CA-3 CA-4 CA-5

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 76, סובלת שבוע משלבקת חוגרת בראש ובפנים, כאב צורב כאש, ואינה מוצאת מנוחה בישיבה או בשכיבה; נגעי העור פזורים בעיקר במצח הימני ומסביב לעין. לפני הופעת המחלה כעסה. בבדיקה: רגישות ללחץ בחלק העליון של הצוואר בצד ימין, ומלאות בבטן השמאלית. אבחנה: שלבקת חוגרת בראש ובפנים. נבחרו נקודות המחמם המשולש משני הצדדים ונקודות הצוואר בצד ימין. טיפלנו פעמיים בשבוע; לאחר הטיפול הכאב החל לפחות והשינה השתפרה, לאחר שלושה טיפולים הכאב ונגעי העור השתפרו באופן ניכר, ולאחר חמישה טיפולים כבר אין כאב; עברנו לטיפול אחת לשבועיים, וטיפלנו עוד שלוש פעמים – החלמה קלינית.

📖 איור 11-3-17 · עמ' 267

עווית בשריר התאומים בשוק

מחלות גוף-נפש

אבחנה: עווית בשריר התאומים בשוק

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות הראש משני הצדדים, וחוזקו, ונקודות הברך והקרסול משני הצדדים, ובין שתי הנקודות חוזקו שתי מחטים.

CA-1 CA-14 CA-15

תיאור המקרה המלא

גבר, בן 68, סובל שלושה חודשים מכאב בשתי השוקיים וקושי בהליכה. המטופל הוא מארגן ומאמן של מועדון טיולי הליכה, ועוסק בתחום זה יותר מעשרים שנה. לפני תשעה חודשים חתנו נפטר לאחר שלושה שבועות של תרדמת בבית החולים בעקבות תאונת דרכים, ומאז החלו שוקיו לכאוב בהדרגה, והכאב הלך והחמיר; כעבור חודש הכאב היה קשה לנשיאה, ההליכה התקשתה, ומעבר לקילומטר אחד הכאב בלתי נסבל וצריך לנוח לפחות עשר דקות. בבדיקה: נוקשות בשרירי התאומים בשתי השוקיים, עם רגישות ללחץ (+++), ותפיחות ורגישות ללחץ בבטן התחתונה. אבחנה: עווית בשריר התאומים בשוק. נבחרו נקודות הראש משני הצדדים, וחוזקו, ונקודות הברך והקרסול משני הצדדים, ובין שתי הנקודות חוזקו שתי מחטים. לאחר טיפול אחד אפשר היה ללכת שני קילומטרים ללא כל אי-נוחות; כעבור שבוע טופל שוב, והוא הגיע לאחר שהלך חמישה קילומטרים ביום, ללא כל תחושת אי-נוחות בשוקיים – החלמה קלינית. מקרה זה אינו פגיעה שרירית פשוטה, אלא יש לו גורם מעורר נפשי ברור.

📖 איור 11-3-18 · עמ' 268

דלקת הפאשיה של שרירי המותן

מחלות גוף-נפש

אבחנה: דלקת הפאשיה של שרירי המותן

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות המחמם המשולש משני הצדדים, ונקודות הצוואר בדקירה חודרת אל נקודות הראש;

CA-1 CA-2 CA-3 CA-4 CA-5

תיאור המקרה המלא

גבר, בן 33, מתלונן על כאב בגב התחתון במשך חצי שנה, חמור במיוחד עם הקימה בבוקר, והכאב מחמיר בהתכופפות ובסיבוב המותן. בבדיקה: רגישות ללחץ בצוואר, אין רגישות ניכרת ללחץ במותן, רגישות ללחץ (++) בשריר העכוז הבינוני, מלאות בבטן, רגישות ללחץ בכל הבטן, וכאב עם סירוב ללחיצה בנקודות ג'ונג-ואן (中脘) ו-ווא-לינג (外陵). אבחנה: דלקת הפאשיה של שרירי המותן. זו חסימה בתנועת הצ'י הנגרמת מרגשות, והמחלה הראשונה משפיעה על המחלה המאוחרת. נבחרו נקודות המחמם המשולש משני הצדדים, ונקודות הצוואר בדקירה חודרת אל נקודות הראש; המחטים נשארו 30 דקות, ולאחר הוצאתן תנועת המותן תקינה, הצוואר רפוי והרגישות ללחץ נעלמה. טיפלנו עוד שלוש פעמים, אחת לשבועיים, מצבו הרגשי יציב והתסמינים הגופניים נעלמו – החלמה קלינית. במקרה זה, אף שכאב הגב התחתון הוא התלונה העיקרית, הגורם המעורר הראשוני אינו במותן אלא בחסימת תנועת הצ'י בבטן.

📖 איור 11-3-20 · עמ' 270

הפרעה תפקודית של מערכת העיכול

מחלות גוף-נפש

אבחנה: הפרעה תפקודית של מערכת העיכול (על רקע רגשי)

טיפול ותוצאה: נבחרו נקודות המחמם המשולש משני הצדדים, ובכל פעם הוסר כאב הבטן שניתן היה למשש, כדי לתת למטופלת ביטחון;

CA-2 CA-3 CA-4

תיאור המקרה המלא

אישה, בת 63, סובלת כמעט שנה מכאב בבטן התחתונה השמאלית, בליווי חרדה רגשית. אמה נפטרה מסרטן השד, ואחותה נפטרה לפני שנתיים מסרטן המעי הגס, ומאז החלו להופיע אצל המטופלת בהדרגה תסמיני כאב בטן, ועצירות ושלשול מתחלפים, עם נטייה מתמשכת להחמרה. בבדיקה: בקולונוסקופיה לא נמצאה כל חריגה. אבחנה: הפרעה תפקודית של מערכת העיכול (על רקע רגשי). נבחרו נקודות המחמם המשולש משני הצדדים, ובכל פעם הוסר כאב הבטן שניתן היה למשש, כדי לתת למטופלת ביטחון; כשהתסמינים השתפרו באופן ניכר החלה הכוונה נפשית, תוך הדגשה שסרטן אינו מחלה תורשתית, כדי לנתק את שורש החשיבה השלילית. לאחר שנים-עשר טיפולים במשך שלושה חודשים המטופלת הפיגה לגמרי את המצב הנפשי השלילי. לאחר מכן היא מגיעה אחת לחודש-חודשיים לטיפול ויסות, וכבר שלוש שנים, והיא יצאה לגמרי מצל הסרטן.

📖 איור 11-3-19 · עמ' 269

9 טכניקת דיקור ובטיחות

שלבי הטיפול

1. **אבחנה:** זיהוי אזור הכאב ובדיקת תנועה/מישוש בטן לפני הדיקור, כדי שתהיה נקודת השוואה.
2. **בחירת צד:** בכאב חד-צדדי – בדרך כלל בלחי של אותו הצד; בבעיה מרכזית או מערכתית – דו-צדדי (ראו כרטיס כל נקודה).
3. **איתור במישוש:** מאתרים לפי ציוני הדרך הגרמיים (קשת הזיגומה, מפרק הלסת, זווית הלסת) ושריר המלעס בהידוק שיניים. מחפשים את הנקודה הרגישה ביותר באזור.
4. **החדרה:** מחטים דקות (0.16–0.18 × 13 מ"מ), בדרך כלל עם מוליך, החדרה מהירה ושטחית לעומק 2–5 מ"מ לפי הנקודה.
5. **בדיקה חוזרת:** מיד לאחר ההחדרה מבקשים מהמטופל להזיז את האזור הכואב או ממששים שוב את הבטן. אם אין שיפור – מתקנים מעט את מיקום המחט.
6. **שהייה:** 20–45 דקות, ובמהלכן אפשר לעודד את המטופל להניע בעדינות את האזור הכואב.

בטיחות ואזהרות

- מחטים סטריליות לשימוש חד-פעמי וחיטוי העור לפני הדיקור.
- **CA-4 ו-CA-14:** עורק וריד הפנים עוברים ליד הגבול הקדמי של שריר המלעס ומעל גוף הלסת. ממששים את הדופק ודוקרים לידו ולא עליו.
- **CA-5 ו-CA-6 (קדמית לאוזן):** העורק הרקתי השטחי ועצב הפנים נמצאים באזור – דיקור שטחי בלבד.
- הפנים עשירות בכלי דם: אחרי הוצאת המחט לוחצים עם צמר גפן יבש כ-30 שניות כדי למנוע שטף דם.
- לא דוקרים דרך עור מודלק, פצעים, אקנה פעיל או הרפס.
- **הריון ונטייה לדימום** (כולל נטילת מדללי דם) מופיעים בספר המקור בין התוויות הנגד – ראו למטה. במטופלים עם נטייה להתעלפות – לטפל בשכיבה.
- כאב חריף, חדש או לא מוסבר מחייב אבחנה רפואית לפני שמטפלים בו כבעיה תפקודית.

מכשירים וביצוע לפי ספר המקור 📖 עמ' 154–155

מחטים: חד-פעמיות סטריליות, גוף דק וחלק וגמיש; בדרך כלל קוטר 0.14–0.20 מ"מ ואורך 7–30 מ"מ.

עומק: דיקור ישר 0.2–0.5 צון; אלכסוני 0.5–1 צון; חודר 0.5–1.5 צון. העיקרון: מחלה קלה – שטחי, מחלה קשה – עמוק; משלבים עם אבחון הבטן.

טכניקה: השיטה מדגישה את הגעת הצ'י והיעילות ואינה שואפת לתחושת מחט: "יעילות נחשבת כהגעת הצ'י"; אם אין שיפור – מתקנים וממשיכים. מומלצת החדרה מהירה ללא כאב – בדיקור מעופף (飞针) או דרך צינורית.

הוצאת המחט: לחיצה קצרה בכדור צמר גפן יבש; להימנע מעיסוי ולחיצה חזקה (במיוחד ליד העיניים). במי שנוטה לדימום אסור לדקור – אפשר מוקסה או לחיצה ועיסוי נקודתיים; במי שחושש ממחטים ובילדים – לחיצה באצבע או גירוד עדין בגומי מחק.

השארת מחטים: 20–40 דקות; ניתן לכוונן ולהוסיף מחטים לפי התגובה. בכאב כרוני עקשן ובמי שזקוק להרפיה נפשית – זמן ארוך יותר.

מהלך טיפול: בדרך כלל אחת לשלושה ימים, חמש פעמים – מהלך אחד. מחוץ לסין – לפי המצב, פעם בשבוע עד שלושה שבועות.

עור הפנים דק ורך ועשיר בכלי דם; וריד הפנים מתקשרים עם הסינוס הקברנוזי שבגולגולת, ולכן זיהום בפנים עלול להתפשט לתוך הגולגולת – נדרש חיטוי קפדני. 📖 עמ' 154

התוויות נגד לפי ספר המקור 📖 עמ' 156

1. מחלות עור עם פגיעה בעור הפנים והלחיים, וזיהום מקומי.
2. חום גבוה, התכווציות מבהילות, אי-ספיקת לב וריאות, ומחלות בטן חריפות למיניהן.
3. מדדים פיזיולוגיים ומעבדתיים החורגים בחומרה מהנורמה.
4. ירידה בטסיות הדם ונטייה לדימום.
5. מטופלים שעברו ניתוח אסתטי או הזרקות בפנים (הרזיית פנים, הפחתת קמטים) – לשאול בפירוט ולהעריך את הסיכון לפני ההחלטה.
6. נוירלגיה טריגמינלית ועווית של שרירי הפנים – זהירות מרבית.
7. אסור לאכול בזמן הדיקור – לעיסה עלולה לגרום לתקיעת מחט או לשבירתה.
8. נשים בהיריון, במיוחד עם היסטוריה של הפלות או הריון בעקבות הפריה מלאכותית.

פרק 10 – הבטחת הבטיחות: אזור הדיקור קרוב לחושים ועשיר בכלי דם; יש להשתמש תמיד במחטים חד-פעמיות (0.14–0.20 מ"מ) ולחטא היטב. אין להמליץ על דיקור הלחי למי שיש לו נטייה לדימום, רגישות למתכת, פגיעות עור בלחיים ובפנים, ולנשים בהריון. תגובות לוואי כלליות קשורות לרוב למצב נפשי לא יציב, רעב, תשישות, גירוי חזק מדי, בחירת נקודות לא נכונה או טיפול ארוך מדי. 📖 עמ' 189–190

10 מילון מונחים

מונחי השיטה כפי שהם מוגדרים בספר המקור. מונחים המסומנים בקו מנוקד בטקסטים באתר מקשרים לכאן.

דיקור הלחי 颊针疗法

שיטת טיפול בנקודות ספציפיות באזור הפנים והלחיים (בדיקור, עיסוי, טיפול מגנטי, לייזר וכדומה), המבוססת על יחידה הולוגרפית של כל הגוף בלחי.

📖 עמ' 39

מערכת מיקרו-דיקור 微针系统

שיטה שבה, על בסיס קשר השלכה בין אזור מקומי לכל חלקי הגוף, בודקים או מטפלים באזור המקומי כדי לאבחן או לטפל בכל הגוף (הגדרת פרופ' וואנג שואה-טאי).

📖 עמ' 10

יחידה / עובר הולוגרפי 全息元

יחידה מקומית המכילה השלכה של הגוף כולו. ללחי אין גבול אנטומי בולט של העובר ההולוגרפי, וההשלכה בה רציפה.

📖 עמ' 39, 72

אזור נקודה 穴区

בדיקור הלחי הנקודה אינה נקודה במובן המסורתי אלא אזור; בין אזורי הנקודות יש המשכיות (למשל בין הירך לברך – ההשלכה של הירך).

📖 עמ' 39

נקודת מיקום 定位穴

16 נקודות היסוד הן נקודות מיקום סטנדרטיות לפי סימנים גרמיים; בקליניקה מדייקים אותן לפי המטופל.

📖 עמ' 39, 50

נקודת מטרה / יעד 靶点

המקום שבו מכוונים את הטיפול – ההתאמה בין הנקודה למוקד המחלה או למנגנון המחלה.

📖 עמ' 50, 151

המחמם המשולש הגדול 大三焦

המחמם המשולש במובנו הכולל והמבני – שליח הצ'י המקורי העובר בכל האיברים; להבדיל מהמחמם המשולש כ"פקיד התעלות".

📖 עמ' 13

דרכי הצ'י 气街

ארבעה מקומות (ראש, חזה, בטן, שוק) שבהם מתכנס צ'י המרידיאנים ומסתובב; "הצ'י שבראש נעצר במוח".

📖 עמ' 10–11

גוף-נפש 心身

הגישה הרואה בגוף ובנפש אחדות; הרובד השלישי של התוויות השיטה.

📖 עמ' 13, 155

סומטיזציה 躯体化

ביטוי בעיות נפשיות וחברתיות באמצעות תסמינים גופניים; לפי המחבר, חלק מהכאבים הכרוניים העקשניים קשורים לכך.

📖 עמ' 13, 104

אבחון בטן 腹诊

בדיקת הבטן בלחיצה ובמישוש לצורך אבחון; בדיקור הלחי משמש לקביעת נקודת היעד ולבדיקה חוזרת אחרי הדיקור.

📖 עמ' 140

פי 痞

"מלאות ללא כאב" – חסימה וסטגנציה של צ'י, או גוש בבטן.

📖 עמ' 145

קשר 结

גוש או חסימה שאינה ניתנת להזזה בבטן; בכאב – השלב השלישי (הידבקות, צלקת).

📖 עמ' 145, 154

גוש צ'י 气团

ממצא בבטן הנחשב לפי המחבר מקום המוצא הפתולוגי של מחלה כרונית.

📖 עמ' 147

קבלת הצ'י 得气

בדיקור הלחי נקבעת לפי האפקט: "כשהצ'י מגיע – יש יעילות" (气至而有效), ולא לפי תחושת מחט.

📖 עמ' 155, 192

תחושת מחט סמויה 隐性针感

גירוי יעיל פיזיולוגית שהמטופל אינו חש או חש קלות – בניגוד ל"תחושת מחט גלויה" (显性针感) כמו חמיצות, נימול ונפיחות.

📖 עמ' 192–193

דיקור מעופף 飞针

טכניקת החדרה מהירה ללא כאב; אפשרות נוספת היא החדרה דרך צינורית.

📖 עמ' 155

דיקור הצד הנגדי 缪刺

בחירת נקודה בצד הנגדי למקום המחלה (שיטת ההתאמה שמאל-ימין).

📖 עמ' 152

צ'נג-ג'יאנג 承浆 · CV-24

נקודת מרידיאן הרן בשקע שבמרכז חריץ הסנטר-שפה; ציון דרך לנקודות הברך, הקרסול וכף הרגל.

📖 עמ' 28, 45–46

התפר הרקתי-זיגומטי 颞颧缝

התפר בין עצם הרקה לעצם הלחי על קשת הלחי; נקודת הכתף (CA-9) באמצעו.

📖 עמ' 44

טיפול בשורש 治病求本

בהקשר השיטה – ויסות המחמם המשולש כטיפול בפתולוגיה העמוקה, מעבר לנקודות המקומיות.

📖 עמ' 51

מנגנון הצ'י: עלייה, ירידה, יציאה וכניסה 气机升降出入

הצורה הבסיסית של פעילות הצ'י; הפרעה בה היא "עיקר השינויים הפתולוגיים" לפי פרק 8.

📖 עמ' 51, 150

צוואר תפוס משינה 落枕

כאב ונוקשות חריפים בצוואר לאחר שינה; מהתוויות נקודת הצוואר (CA-5).

📖 עמ' 41

חמשת האיברים (החושים) 五官

עיניים, אוזניים, אף, פה ולשון; "מחלות חמשת האיברים" בהתוויות CA-2.

📖 עמ' 41

11 מקורות והערות לבדיקה

ספר המקור: "דיקור הלחי (颊针疗法)", וואנג יונגז'ואו (王永洲), הוצאת הבריאות העממית (人民卫生出版社) – תרגום עברי. מספרי העמודים (📖) הם לפי סימון העמודים בתרגום. **מקורות נוספים באתר:** "טבלה 1 בדיווח המקרה" (P1/P2) ותיאורי המישוש והמחט באטלס הם תוכן האתר הקיים. להלן פערים שזוהו בין תוכן האתר לבין הספר. הם לא תוקנו בשקט – כל פער מוצג כדי שגורם מקצועי יכריע.

מיקום CA-4

עדיפות גבוהה

באתר: "בחלק התחתון של הגבול הקדמי של שריר המלעס, בקו אופקי עם קו השפתיים/זווית הפה".

בספר: (עמ' 41, 47): "בשוליים הקדמיים של הזווית הפנימית של הלסת התחתונה"; מבנה עמוק: החלק האמצעי של ענף הלסת והזווית הפנימית שלה.

המלצה: יש לאמת מול איור 4-1-3 ואיורים 2-5-1/3-5 בספר. נקודת הייחוס בספר היא גרמית (הזווית הפנימית של הלסת), ולא קו הפה. גם טבלה 1 באתר ("על הקו האלכסוני הקדמי של הלסת התחתונה") מנוסחת אחרת מהתרגום העברי של הספר – ייתכן הבדל תרגום של אותו מונח סיני; מומלץ לבדוק מול המקור הסיני.

CA-4

מיקום CA-6

עדיפות בינונית

באתר: "ממש קדמית לטרגוס (אזור SI19), בשקע מפרק הלסת".

בספר: (עמ' 41): "מתחת לשוליים התחתונים של שורש קשת הלחי, מתחת למפרק הלסת-רקה". הספר אינו משווה את הנקודה ל-SI19.

המלצה: להסיר את ההשוואה ל-SI19 או לציין את מקורה.

CA-6

מיקום CA-8 ו-CA-13

עדיפות בינונית

באתר: CA-8 "באזור זווית הלסת... אחורית ותחתונה לנקודת הירך"; CA-13 "בדיוק בין CA-4 ל-CA-8".

בספר: (עמ' 43, 45): CA-8 – חצי צון לפני ומעל לזווית הלסת; CA-13 – צון אחד לפני ומעל לזווית הלסת, בבליטת שריר הלעיסה.

המלצה: הסדר היחסי תואם, אך המרחקים בצון מהזווית מופיעים רק בספר – מומלץ לאמץ אותם.

CA-8 CA-13

מיקום CA-14 עד CA-16 ושרירי הסנטר

עדיפות גבוהה

באתר: CA-14 "על הגבול התחתון של גוף הלסת, באמצע הקו"; CA-15 "מעט אחורית ותחתונה ל-CA-16, בבסיס שריר מוריד השפה התחתונה"; CA-16 "על שריר הסנטר (Mentalis)".

בספר: (עמ' 45–46): CA-14 – אמצע הקו בין זווית הלסת לצ'נג-ג'יאנג (CV-24); CA-15 – על הקו CA-14–CV-24 בשליש הקרוב לקו האמצע, עמוק לו שריר מוריד זווית הפה; CA-16 – חצי צון לצד CV-24, עמוק לו שריר מוריד השפה התחתונה.

המלצה: קו הייחוס ושיוך השרירים שונים. יש לאמת מול איורים 2-4-3 עד 4-4-3. בנוסף, טבלה 1 באתר ממקמת את CA-15 "בשליש הקרוב לנקודת הברך", ואילו הספר – "בשליש הקרוב לקו האמצע של הגוף" (כלומר קרוב יותר ל-CV-24): כיוון הפוך.

CA-14 CA-15 CA-16

שיוך שרירים לנקודות במפת השרירים

עדיפות בינונית

באתר: שריר הרקה ← CA-1, CA-2, CA-9; הזיגומטיים ← CA-9, CA-10, CA-11; הפטריגואיד ← CA-2, CA-5, CA-6; הבוקינטור ← CA-2, CA-3, CA-4; חוג הפה ← CA-11, CA-12.

בספר: (עמ' 16–18): שריר הרקה ← הראש והצוואר (CA-1, CA-5); שריר הלעיסה ← שכבה שטחית של המחמם המשולש + הגב, המותן, העצה והירך; הפטריגואיד הפנימי ← שכבה עמוקה של שלושת המחממים; החיצוני ← שכבה עמוקה של העליון והאמצעי + הגב; הבוקינטור ← האמצעי והתחתון; חוג הפה ← היד, שורש כף היד, כף הרגל והקרסול.

המלצה: כרטיס השריר מציג כעת את שני השיוכים זה לצד זה; יש להחליט איזה שיוך יוצג כראשי.

CA-1 CA-2 CA-5 CA-6 CA-9 CA-10 CA-11

התוויות שאינן מופיעות בספר

עדיפות גבוהה

באתר: CA-1 ו-CA-2 – "ציר HPO" ו"ציר לב-רחם (Bao Mai)" בטיפולי פריון; CA-4 – אנדומטריוזיס; CA-8 – אישיאס, "מקלעת העצבים הסקראלית" וזרימת דם לרחם.

בספר: אין התוויות אלה. CA-4 בספר כולל אי-פוריות, כאבי מחזור, שרירנים ודלקת חצוצרות; סיאטיקה מופיעה בספר תחת CA-7 ו-CA-13, לא תחת CA-8.

המלצה: לציין מקור להתוויות האלה או להסירן.

CA-1 CA-2 CA-4 CA-8

פרוטוקולי כאבי מחזור ופריון

עדיפות גבוהה

באתר: שני פרוטוקולים מלאים, כולל "ב-80% מהמקרים הכאב יורד מיד", טיפול 3–5 ימים לפני הווסת, ושילוב בתהליכי IVF וביום החזרת עוברים.

בספר: אין פרוטוקולים אלה ואין נתון של 80%. הספר מביא מקרים בודדים בלבד (למשל 2-2-11 דלקת פאשיה וכאבי מחזור; 4-2-11 דלקת חצוצרות), ומונה הריון – "במיוחד עם היסטוריה של הפלות או הריון בעקבות הפריה מלאכותית" – בין התוויות הנגד (עמ' 156).

המלצה: דחוף: לבדוק את מקור הפרוטוקולים; שלב "יום החזרת עוברים" עומד בסתירה להתוויות הנגד בספר.

CA-1 CA-2 CA-3 CA-4 CA-7 CA-8

הריון

עדיפות גבוהה

באתר: "זהירות בהריון".

בספר: הריון הוא התוויית נגד (עמ' 156), ו"אין להמליץ על דיקור הלחי... לנשים בהריון" (עמ' 190). מנגד, בפרק המקרים מובא מקרה של כאב גב תחתון בחודש התשיעי להריון (4-7-1-11, עמ' 228) – סתירה פנימית בספר עצמו.

המלצה: עודכן באתר לנוסח הספר; הסתירה הפנימית בספר מסומנת במקרה עצמו.

פרמטרים של מחט וזמן

עדיפות בינונית

באתר: מחט 0.16–0.18 × 13 מ"מ, עומק 2–5 מ"מ, שהייה 20–45 דקות (30–45 בפרוטוקולים).

בספר: (עמ' 155): קוטר 0.14–0.20 מ"מ, אורך 7–30 מ"מ; עומק בצון (ישר 0.2–0.5, אלכסוני 0.5–1, חודר 0.5–1.5); שהייה 20–40 דקות; מהלך – אחת ל-3 ימים × 5 (מחוץ לסין: פעם בשבוע עד שלושה שבועות). הספר אינו נותן עומק לכל נקודה בנפרד.

המלצה: העומקים לכל נקודה באתר אינם מהספר; מומלץ לציין את מקורם.

שבירת טבלה בספר

עדיפות נמוכה

בספר: בטבלה 1-5-3 (עמ' 47) ההתוויות של CA-6 נקטעות ב"עווית של" בגלל מעבר עמוד; ההשלמה "הסרעפת" מופיעה בטקסט (עמ' 43).

המלצה: באתר הושלם "עווית של הסרעפת".

CA-6

טעות פנימית בספר – מקרה 2-8-1-11

עדיפות נמוכה

בספר: במקרה 2-8-1-11 (עמ' 234) נכתב "נבחרה נקודת העצה (CA-13)"; לפי פרק 3, העצה היא CA-8 והירך היא CA-13.

המלצה: ככל הנראה טעות תרגום/דפוס; יש לבדוק מול המקור הסיני.

CA-8 CA-13

12 ▶️ סרטוני הדרכה והדגמות קליניות בדיקור לחי (YouTube)

קישורים ישירים להרצאות והדגמות מעשיות של פרופ' וואנג יונג-ג'או (מייסד השיטה) ומטפלים מוסמכים המדגימים מישוש, שימוש במוליך והחדרה ללא כאב

פרופ' וואנג יונג-ג'או (מייסד השיטה)

הרצאה והדגמת יסודות דיקור לחי (36 דק')

פרופ' וואנג מסביר ומדגים את המיפוי ההולוגרפי על הגולגולת, שלושת המחממים ואופן הדיקור הקליני.

צפה ב-YouTube ↗

(https://www.youtube.com/watch?v=Q3FdBgRjMkI)

סדנה מלאה של פרופ' וואנג

דיוק אנטומי ומישוש בדיקור לחי (שעתיים)

הדרכה מעמיקה על איתור ציוני הדרך הגרמיים והשרירים (קשת הזיגומה, מפרק הלסת ושריר המלעס).

צפה ב-YouTube ↗

(https://www.youtube.com/watch?v=KXOMqCp1VdI)

הדגמת טיפולים קליניים

הדגמת דיקור מעשית בקליניקה (11 דק')

סרטון המציג מקרוב איך ממששים את הלחי, איך מחדירים את המחטים הדקות עם מוליך ואיך בודקים תנועה מיד לאחר מכן.

צפה ב-YouTube ↗

(https://www.youtube.com/watch?v=S5qp73gPhw4)

HKU SPACE - סמינר קליני

טכניקת דיקור לחי ואבחנת בטן (53 דק')

סקירה קלינית של 16 הנקודות, אבחנת הבטן של שלושת המחממים והדגמות על מטופלים.

צפה ב-YouTube ↗

(https://www.youtube.com/watch?v=aEkBpbUVRfg)

המדריך נועד ללימוד ולשימוש מטפלים מוסמכים ברפואה סינית. אינו תחליף להכשרה מעשית בשיטה או לאבחנה רפואית. מקורות: הספר "דיקור הלחי (颊针疗法)" מאת וואנג יונגז'או (王永洲), הוצאת הבריאות העממית – תרגום עברי (ההפניות 📖 לעמודים); טבלה 1 בדיווח המקרה (P1, P2). התוכן אינו מוסיף המלצות קליניות מעבר למקורות; פערים בין המקורות מרוכזים בחלק 11.